

TRANSTORNOS ALIMENTARES

*exemplos de tratamentos psicológicos com
suporte empírico*

**Jennifer Patrícia Kuhn Lago
Márcio Borges Moreira**



Transtornos alimentares: exemplos de tratamentos psicológicos com suporte empírico

Jennifer Patrícia Kuhn Lago

Márcio Borges Moreira

2022, 1ª edição

ISBN 978-85-65721-32-5



Instituto Walden4

www.walden4.com.br

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Lago, Jennifer Patrícia Kuhn

Transtornos alimentares [livro eletrônico] :
exemplos de tratamentos psicológicos com suporte
empírico / Jennifer Patrícia Kuhn Lago, Márcio
Borges Moreira. -- 1. ed. -- Brasília, DF :
Instituto Walden4, 2022.

PDF

Trabalho de conclusão de curso (Bacharel) -
Faculdade de Ciências da Educação e Saúde do Centro
Universitário de Brasília.

Orientador: Prof. Dr. Márcio Borges Moreira.

Bibliografia.

ISBN 978-85-65721-32-5

1. Alimentação - Aspectos psicológicos
2. Prática baseada em evidências 3. Psicanálise -
Estudo de casos 4. Psicologia - Estudo de casos
5. Psicodiagnósticos 6. Psicoterapia - Aspectos
psicológicos 7. Psicopatologia 8. Suporte empírico
9. Transtornos alimentares I. Moreira, Márcio Borges.
II. Título.

22-138883

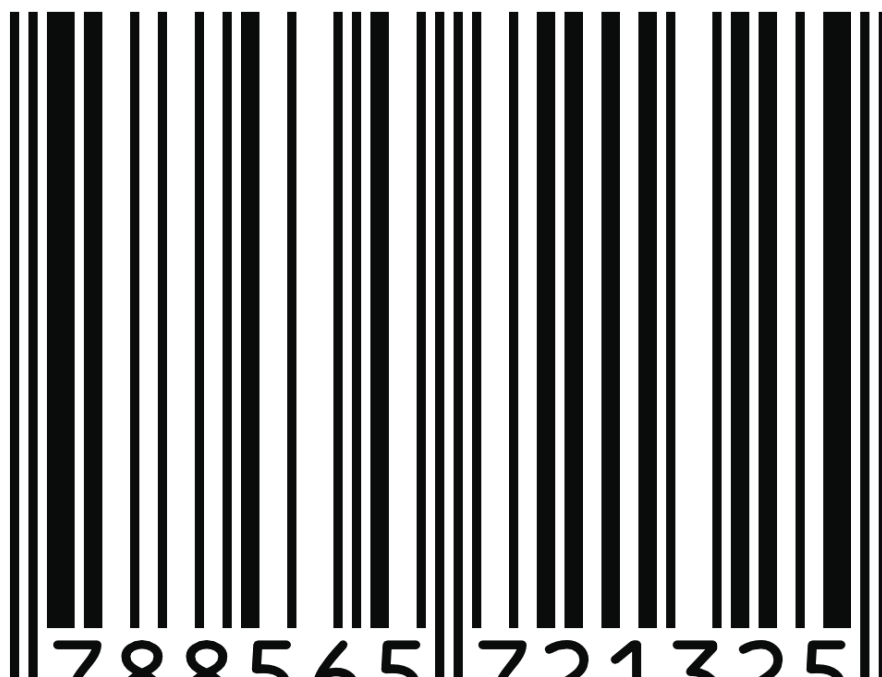
CDD-616.8

Índices para catálogo sistemático:

1. Desordens mentais : Transtornos alimentares 616.8

Henrique Ribeiro Soares - Bibliotecário - CRB-8/9314

ISBN: 978-85-65721-32-5



9 788565 721325

Editora do Instituto Walden4

A Editora do Instituto Walden4 tem como objetivo divulgar conhecimento produzido sobre a Análise do Comportamento (ciência e profissão). No intuito de democratizar o acesso ao conhecimento, muitos de nossos livros são disponibilizados gratuitamente. Todos os nossos livros estão disponíveis em formato digital online. Isso significa que em apenas alguns segundos você poderá estar lendo os livros publicados por nós que lhe interessarem.

Conselho Editorial

Dr. Gleidson Gabriel da Cruz

Dr. Márcio Borges Moreira

Dra. Vanessa Leal Faria

Contato

secretaria@walden4.com.br

@instituto.walden4

<https://www.instagram.com/instituto.walden4>

<https://www.walden4.com.br>

<https://www.facebook.com/iwalden4>

<https://www.youtube.com/user/instwalden4>



Valorize o trabalho das autoras e dos autores!

Este livro, desde a sua concepção, foi desenvolvido para ser um livro distribuído, em seu formato digital, gratuitamente. No entanto, a maioria dos livros são vendidos, e a receita oriunda da venda desses livros é o “ganha-pão” de milhares de famílias de escritores, designers gráficos, diagramadores, revisores, ilustradores, diretores e de uma infinidade de profissionais envolvidos na publicação de um livro. Sempre que você puder, compre um livro original.

Sobre os autores



Jennifer
Lago

Jennifer Patrícia Kuhn Lago

Psicóloga formada pelo CEUB. Estudante de Psicanálise pelo Corpo Freudiano de Brasília. Fluente em Inglês e Espanhol e professora de inglês.



Márcio Moreira

@marcioborgesmoreira

Márcio Borges Moreira | @marcioborgesmoreira

Doutor em Ciências do Comportamento pela Universidade de Brasília (UnB). Mestre em Psicologia e Psicólogo pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Professor da graduação e do mestrado em Psicologia do Centro Universitário de Brasília (CEUB). Diretor do Instituto Walden4. Co-autor do livro *Princípios Básicos de Análise do Comportamento* (Artmed) e de outros livros, capítulos e artigos científicos com temas relacionados à Análise do Comportamento.

Acompanhe os trabalhos de Márcio Moreira pelas mídias sociais:

<https://www.facebook.com/professormarciomoreira>

<https://www.instagram.com/marcioborgesmoreira>

<https://www.youtube.com/user/borgesmoreirayt>

<https://pt.slideshare.net/borgesmoreira>

<https://www.linkedin.com/in/márcio-borges-moreira-10217934>

<http://lattes.cnpq.br/4094892880820475>

Conheça outras obras de Márcio Moreira

[Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Moreira & Medeiros \(2019\)](#)

[Análise do Comportamento Aplicada \(ABA\): o reforçamento. Moreira \(2019\)](#)

[Uma história de aprendizagem operante. Moreira e de Carvalho \(2017\)](#)

["Em casa de ferreiro, espeto de pau": o ensino da Análise Experimental do Comportamento. Moreira \(2004\)](#)

[O conceito de motivação na psicologia. Todorov e Moreira \(2005\)](#)

[Algumas considerações sobre o responder relacional. Moreira, Todorov e Nalini \(2006\)](#)

[Psicologia, comportamento, processos e interações. Todorov e Moreira \(2009\)](#)

[Comportamento supersticioso: implicações para o estudo do comportamento operante. Moreira \(2009\)](#)

[Emergência de classes de equivalência após separação e recombinação dos estímulos compostos utilizados no treino. Moreira e Hanna \(2014\)](#)

[Arranjo de estímulos em treino discriminativo simples com compostos e emergência de classes de estímulos equivalentes. Moreira, Oliveira e Hanna \(2017\)](#)

[Efeitos da marcação de elementos de conjuntos sobre a contagem em tarefas de discriminação condicional. Bandeira, Faria e Moreira \(2020\)](#)

Sumário

Resumo.....	1
Abstract	2
Introdução.....	4
Transtornos alimentares: definição e etiologia.....	5
Relevância do tema.....	9
A visão da Análise do comportamento.....	15
Análise do comportamento: intervenção	17
Estudo de caso - Análise do Comportamento.....	18
A visão da Gestalt-terapia	23
Gestalt-terapia: intervenção.....	25
Estudo de caso - Gestalt-terapia	27
A visão da Terapia Cognitivo-Comportamental.....	31
Terapia Cognitivo-Comportamental: intervenção	33
Estudo de caso - Terapia Cognitivo-Comportamental.....	35
A visão da Psicanálise	38
Psicanálise: intervenção.....	44
Estudo de caso - Psicanálise.....	50
Prática Baseada em Evidências na Psicologia.....	54
Suporte empírico versus Prática Baseada em Evidências	58
Evidências de eficácia das distintas abordagens psicológicas no tratamento dos TAs.....	59
Justificativa, objetivo e procedimentos de elaboração deste livro.....	63
Procedimento	63
Suporte empírico: Análise do Comportamento	67
Suporte Empírico 1	67
Suporte empírico 2.....	68
Suporte empírico 3.....	69
Suporte empírico: Gestalt Terapia	71
Suporte empírico 1.....	71
Suporte empírico 2.....	73
Suporte empírico: Terapia Cognitivo-Comportamental.....	75
Suporte empírico 1.....	75
Suporte empírico 2.....	76
Suporte empírico 3.....	77

Suporte empírico: Psicanálise	79
Suporte empírico 1	79
Suporte Empírico 2	80
Suporte empírico 3.....	81
Discussão	82
Comparações entre abordagens.....	83
PPBE: Ser ou não ser?	83
Considerações finais	86
Referências bibliográficas.....	88

Resumo

Este trabalho teve o objetivo de apresentar práticas que demonstrem tratamentos psicológicos dos transtornos alimentares em quatro abordagens psicológicas, apresentadas em artigos científicos, e que sirvam de suporte empírico da eficácia destas terapias. Para isto, abordou-se a definição e etiologia dos transtornos alimentares e a concepção teórica destes transtornos para a Análise do Comportamento, Gestalt-Terapia, Terapia Cognitivo-Comportamental e Psicanálise, assim como a definição da Prática Baseada em Evidências no contexto da Psicologia. Foram apresentados o processo de intervenção destes transtornos para estas abordagens, um estudo de caso de cada uma delas e ensaios randomizados de tais tratamentos. O procedimento da pesquisa da monografia ocorreu a partir da seleção de meta-análises e revisões bibliográficas que abordam o processo terapêutico pelo qual os psicólogos das abordagens podem atuar no tratamento da Anorexia e/ou Bulimia Nervosas. Estes documentos foram encontrados na Língua Inglesa e traduzidos para o Português. Por fim, buscou-se sistematizar as técnicas, os resultados e as diferenças encontradas, além da discussão da PPBE nas quatro abordagens.

Palavras-chave: Transtornos alimentares, Tratamento psicológico, Psicologia Baseada em Evidências.

Abstract

The purpose of this study was to present practices that showed psychological treatments of eating disorders in four different psychological approaches, presented in scientific articles, that work as empirical support of the efficacy of these treatments. Therefore, it was discussed the definition and etiology of Anorexia and Bulimia Nervosa and the theoretical concept of these disorders for the Behavioural Therapy, Gestalt Therapy, Behaviour-Cognitive Therapy and Psychoanalysis, besides of the presentation of the Evidence-Based Practice in the context of Psychology. There were shown the process of intervention for each of these approaches, one case study for each one, in addition to some randomized controlled studies of these treatments. These documents were searched through the selection of meta-analysis and bibliographical reviews that addressed the therapeutic process in which the psychologists act in the treatment of eating disorders; they were found in English and translated to Portuguese. At last, it was sought to make a systematic review of the techniques, results and mainly differences found between these treatments, as well as the discussion of Evidence-Based Practice in the four approaches cited above.

Key-words: Eating Disorders; Psychological treatment; Evidence-Based Practice.

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

Instituto Walden4

presencial & online



Responsável técnico: Dr. Márcio Borges Moreira

[Clique aqui para acessar o nosso site](#)

Introdução

A Prática Baseada em Evidências foi desenvolvida inicialmente no campo da Medicina com o intuito de aumentar o número de pesquisas e a dedicação dos profissionais dessa área para a realização de investigações que apresentem, como resultado, evidências científicas da eficácia dos tratamentos disponíveis, de maneira a garantir que a população receba os tratamentos que demonstram melhores resultados. Posteriormente, esta discussão foi disseminada em outras áreas da saúde, como a Psicologia. Nesse contexto, no entanto, há discordância entre os profissionais de diferentes abordagens psicológicas em relação a essa prática e a adaptação da Psicologia a esses estudos.

Desta forma, esse trabalho buscou apresentar evidências que possam servir de suporte empírico da eficácia do tratamento de transtornos alimentares na Análise do Comportamento, na Gestalt Terapia, Terapia Cognitivo-Comportamental e na Psicanálise. Para isto, inicialmente, foi apresentada uma introdução do tema dos transtornos alimentares e da compreensão psicológica a respeito do desenvolvimento e manutenção da Anorexia e Bulimia Nervosa, além de possíveis intervenções psicológicas.

Para tal fim, foi apresentada a discussão da Prática Baseada em Evidências no contexto da Psicologia e nas quatro abordagens citadas acima, juntamente com a apresentação da compreensão teórica destas abordagens em relação à Anorexia e Bulimia Nervosa, além de um estudo de caso de cada abordagem e uma breve explicação da intervenção realizada nesses tratamentos. Posteriormente, foram apresentadas algumas pesquisas realizadas até então, que servem de suporte empírico da eficácia destes tratamentos e foi realizada a tradução, da Língua Inglesa ao Português, dos artigos que abordaram tais evidências científicas (artigos que servem de suporte empírico da eficácia destes tratamentos). Por fim, buscou-se discutir as informações obtidas juntamente com as técnicas apresentadas nestes artigos e os resultados dos tratamentos, clarificando as diferenças encontradas entre as abordagens e reforçando as diferenças de concepção teórica dessas abordagens em relação à PPBE.

Em relação à definição e etiologia dos transtornos alimentares, apresentadas abaixo, faz-se relevante o destaque de que não haverá classificação e cisão das abordagens psicológicas, neste primeiro momento. O tema será abordado em sua definição médica, assim como em suas causas e os aspectos sociais, culturais, familiares e individuais influentes no desenvolvimento e manutenção dos transtornos alimentares. Assim sendo, serão abordados autores e explicações de diferentes abordagens da Psicologia para que seja possível a exposição dos vários pontos de vista e das várias compreensões desta área da saúde no que se refere a este tema.

Posteriormente, todavia, serão esclarecidas as diferenças epistemológicas entre quatro abordagens psicológicas e suas compreensões a respeito do desenvolvimento, manutenção e intervenção dos transtornos alimentares. As abordagens psicológicas utilizadas nesta conceituação foram a Análise do Comportamento, a Gestalt-Terapia e a Terapia Cognitivo-Comporta-

mental e a Psicanálise. A escolha delas ocorreu a partir de uma pesquisa inicial realizada com o intuito de selecionar o maior número de pesquisas no tema dos transtornos alimentares.

Transtornos alimentares: definição e etiologia

Os transtornos alimentares são transtornos de ansiedade ocasionados pelo medo excessivo de engordar e uma intensa preocupação com a forma corporal, que levam as pessoas a desenvolver comportamentos alimentares desregulados e buscar métodos inapropriados de manter ou perder peso (Hetherington & Rolls, 2001; Oliveira & Hutz, 2010). É relevante pontuar a importância da imagem corporal e da relação estabelecida pelo indivíduo com seu corpo no desenvolvimento destes transtornos. Para tal, considera-se que “é a partir do corpo que agimos, que nos relacionamos com o mundo à nossa volta e conosco mesmos” e que, se esta relação se vê prejudicada, suas consequências podem vir a ser calamitosas para a saúde física e mental do sujeito (Novaes, 2013, p.16).

Os dois transtornos alimentares mais comuns são a Anorexia Nervosa e a Bulimia Nervosa. Segundo Hetherington e Rolls (2001), pessoas diagnosticadas com um destes dois transtornos têm, em comum, o medo de engordar. A busca pela magreza e sua manutenção os levam a comportamentos alimentares que vão desde a restrição à compulsão alimentar. Ademais, a crônica restrição alimentar, juntamente com episódios de compulsão, contribuem para um desregulamento da compreensão física de fome e saciação.

Os critérios diagnósticos de Anorexia Nervosa, de acordo com o DSM-V e o CID-10, são a perda de peso e recusa em mantê-lo dentro da faixa saudável; o medo mórbido de engordar, mesmo já estando abaixo do peso; a perturbação na forma de vivenciar o baixo peso, com dificuldade de auto-avaliação e distorção de imagem ao negar o baixo peso, bem como amenorréia por três ciclos consecutivos. Dentre os comportamentos subtipos deste transtorno estão a restrição alimentar e a compulsão purgativa.

Já a Bulimia Nervosa é diagnosticada pelo DSM-V e CID-10 como um transtorno de ansiedade baseado no medo excessivo de engordar que leva a pessoa a ter episódios de ingestão de quantidade exagerada de alimentos seguida de comportamentos purgativos, como a indução de vômitos, ingestão de laxantes e prática excessiva de exercícios físicos.

Estes comportamentos não visam apenas saciar a fome exagerada, mas se relacionam com a busca por atender a uma série de estados emocionais ou situações estressantes. Além de realizar comportamentos purgativos, é importante ressaltar que a pessoa diagnosticada com Bulimia Nervosa e Compulsão Alimentar é constantemente acometida pelo sentimento de culpa e medo da perda de controle de seus próprios comportamentos (DSM-V & CID-10).

Oliveira e Hutz (2010) afirmam que os picos para o início da Anorexia Nervosa ocorrem entre 14 e 18 anos, e estão, frequentemente, associados a algum acontecimento vital estressante. Algumas pessoas se recuperam completamente do transtorno após a ocorrência de um episódio

dio isolado, enquanto outras exibem padrão flutuante de ganho de peso e recaída aos comportamentos alimentares desregulados e outros ainda podem viver em curso crônico e degradante por muitos anos. Por isso, a hospitalização pode ser necessária em casos extremos, com o intuito de restauração de peso e correção de desequilíbrios na saúde física do paciente.

Sobre este tópico, cabe ressaltar que o dado utilizado como base pelo DSM-V e CID-10 para definição de um peso saudável é o do IMC (Índice de Massa Corporal). Este índice foi inicialmente desenvolvido com o intuito de utilizar peso e estatura como padrão para critérios diagnósticos e permitir comparações em estudos nacionais e internacionais e, desde então, é utilizado com este objetivo pelos profissionais da saúde. Todavia, existem diversas críticas em relação ao seu uso.

Anjos (1992) afirmou que, apesar de o IMC permitir que saibamos o percentual de gordura corporal do indivíduo e, a partir disso, a quantidade total de massa magra e massa gorda, existe uma grande limitação na distinção de indivíduos saudáveis daqueles portadores de desnutrição energética protéica. O autor ainda afirmou que, para a maior parte dos métodos de avaliação da composição corporal, parâmetros assumidos como verdadeiros para uma parcela da população não podem ser assumidos como verdadeiros para outros grupos, podendo ser, também, compreendidos como inadequados para a amostra brasileira.

Portanto, a discussão em relação ao uso do IMC como base de critério de definição de peso saudável é necessária, ainda mais no que diz respeito a possíveis distorções de imagem e redução de autoestima em indivíduos que não estejam de acordo com os números indicados como saudáveis pelo índice, ainda que este número possa não ser suficiente para a definição de saúde para todos os indivíduos. A despeito da relevância desta discussão, uma apreciação mais detalhada foge aos objetivos deste trabalho. Para uma análise detalhada do assunto, ver, por exemplo, o artigo "Índice de massa corporal obtido por medidas autorreferidas para a classificação do estado antropométrico de adultos: estudo de validação com residentes no município de Salvador, estado da Bahia, Brasil" e o artigo "Sabe a diferença entre Índice de Massa Corporal e Índice de Adiposidade Corporal?", apresentados nas referências deste trabalho.

Etiologia. Como afirmaram Borges et al. (2006), estes transtornos possuem etiologia multifatorial, envolvendo fatores biológicos, genéticos, psicológicos, socioculturais e familiares. Para que se desenvolvam e se mantenham na vida do indivíduo, considera-se fatores de predisposição, precipitantes e mantenedores.

Em relação às predisposições, é de extrema importância considerar a maior incidência destes transtornos no sexo feminino, em indivíduos com histórico familiar de TAs, baixa auto-estima, que apresentem dificuldade de expressar emoções e extremo perfeccionismo. Em relação aos precipitantes, leva-se em consideração a realização de dietas, a ocorrência de separações e perdas, alterações na dinâmica familiar, presença de expectativas irreais e inatingíveis e a proximidade da menarca. Por fim, pode-se considerar alterações endócrinas, distorção da

imagem corporal, distorções cognitivas e práticas purgativas como fatores mantenedores do transtorno (Borges et al., 2006).

É importante considerar a influência dos aspectos socioculturais no desenvolvimento destes transtornos, intensamente conectados com os padrões estéticos sociais de corpo e forma corporal. A magreza, ainda hoje em dia, é associada à autodisciplina e sucesso, enquanto o corpo gordo está conectado com a ideia de fraqueza, perda de controle e falta de saúde. Além disso, Serra (2001) afirmou que os hábitos e as práticas alimentares são construídos nas determinações socioculturais de uma sociedade.

Carreteiro (2005) teorizou que existe um corpo-beleza, construído pela publicidade e a vida social atual, que leva a um aumento do desejo de cada um de se obter e manter um corpo semelhante ao sugerido, repetidamente, como bom, bonito e melhor. Esse processo ocorre, diversas vezes, através da busca por transformações de seus corpos, sejam estas definitivas ou conjecturais. Dentro desta busca, comportamentos alimentares desregulados entram como uma das tentativas mais comuns e avassaladoras, já que parte da concepção de um corpo-beleza está associada à magreza, sua obtenção e manutenção.

Portanto, as práticas alimentares e os padrões estéticos corporais estão intimamente conectados neste processo e constantemente presentes na atualidade, já que "os modelos de beleza são indicativos de distinção social e sinalizadores das diferenças entre classes sociais" (Oliveira & Hutz, 2010).

Carreteiro (2005) ainda afirmou que as sociedades do século XIX também possuíam interesse pelo corpo, porém referiam-se a ele como um corpo social, um corpo político. Quando há essa concepção de corpo como metáfora do social, os indivíduos se interessam pela sociedade e cidadania. No entanto, quando a ênfase do corpo passa a estar no corpo-subjetividade, corpo-estética, corpo-beleza, o corpo social fica enfraquecido e, quando o laço social se enfraquece, o sujeito sofre transformações em suas formas subjetivas de ser.

De acordo com Serra (2001), é a lógica mercadológica que organiza as práticas alimentares, pois o padrão estético da magreza determina o "corpo ideal" e os comportamentos que devem ser seguidos para se cuidar desse corpo. As práticas alimentares, portanto, são regidas por diversos aspectos culturais, sociais, psicológicos e individuais. A autora afirmou, desta forma, que o comportamento alimentar não deve ser entendido apenas como prática observável empiricamente, no que diz respeito ao que e quanto comemos, mas deve-se considerar as "dimensões socioculturais e psicológicas" deste comportamento. O comportamento alimentar liga-se às relações sociais do indivíduo e sua maneira de vivencia-las, ou seja, onde, como, quando, porquê e com quem comemos.

Referindo-se a adolescentes, mas permitindo generalização desta lógica a todas as idades, Serra (2001) afirmou que a busca pelo corpo estético, compreendido como perfeito e saudável e estimulado midiaticamente, leva indivíduos no mundo todo a praticar comportamentos alimentares desregulados que comprometem a qualidade de sua saúde física e mental.

Outro fator gerador de extremo sofrimento no que diz respeito aos transtornos alimentares está na contradição das informações disseminadas na comunicação popular e na mídia. Ao mesmo tempo em a mídia e os interesses mercadológicos e capitalistas estimulam o consumo de lanches rápidos, calóricos e pouco nutritivos, como os *fast foods*, a mídia e os padrões estéticos e sociais difundem um corpo ideal magro, esbelto e musculoso (Serra, 2001).

De acordo com Morgan et al. (2002), a magreza é vendida como mercadoria acessível a todos, independentemente da realidade social, cultural, familiar e individual de cada um, sendo vendida, também, como produto relacionado à capacidade de autocontrole, competência e atratividade sexual. No entanto, como ela é uma impossibilidade biológica para grande parte das mulheres, juntamente com esta venda, cresce a insatisfação corporal e os transtornos alimentares.

Além disso, a disseminação de informações que reforcem as pressões estéticas na internet e nas redes sociais é um fator muito relevante para o aumento destes transtornos em contextos adolescentes. Diversas comunidades na internet funcionam como espaços que, além de garantirem o anonimato e a livre expressão de pensamentos, vêm se tornando meios de comunicação entre adolescentes que apresentam insatisfação corporal e comportamentos alimentares desregulados. Em rumos mais patológicos destes meios de comunicação, são construídas páginas *online* nomeadas de "Pró-Ana" (prol da anorexia) e "Pró-Mia" (prol da bulimia). As mensagens trocadas entre usuários e usuárias servem como incentivo para a valorização social de corpos excessivamente magros e comportamentos alimentares de privação e purgação (Copetti & Quiroga, 2018).

É relevante ressaltar que estes transtornos também são comumente desenvolvidos e não diagnosticados, considerando que as pressões sociais e estéticas estão cada vez maiores e são cada vez mais impostas nas redes sociais e no convívio social, principalmente entre os jovens. Isso pode levar a uma banalização deste sofrimento e uma normalização de comportamentos alimentares desregulados. Desta forma, muitos jovens não procuram ajuda profissional para modificação destes comportamentos e tratamentos dos sintomas, fazendo com que a real prevalência de Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa e outros transtornos alimentares seja maior do que a conhecida até então (Copetti & Quiroga, 2018).

Oliveira e Hutz (2010) afirmaram que o estresse é entendido como um dos principais possíveis fatores desencadeantes da Anorexia em pessoas que apresentam medo de fracasso em suas vidas pessoais, escolares, profissionais e/ou relacionais e que possuam características de perfeccionismo. O estresse está intimamente relacionado à maneira que os indivíduos desenvolvem no processo de aprender a lidar com seus traços de personalidade e com as cobranças que impõem a si mesmos e aos outros em suas interações sociais.

Desta maneira, faz-se relevante o destaque, também, de traços de personalidade que se associam aos transtornos alimentares. Indivíduos diagnosticados com Bulimia Nervosa podem apresentar, em comum, expectativas pessoais muito elevadas e grande necessidade de agradar

os outros para se sentirem aceitos e manterem sua auto-estima, enquanto indivíduos diagnosticados com Anorexia Nervosa podem ser mais impulsivos e apresentarem tendência à depressão (Oliveira e Hutz, 2010).

Pessoas diagnosticadas com Anorexia Nervosa Purgativa (ANP) costumam apresentar características impulsivas, excitáveis e intolerantes, que podem contribuir para comportamentos purgativos, enquanto pacientes diagnosticados com Anorexia Nervosa Restritiva apresentam traços de ineficiência, organização excessiva, persistência e tendência ao autocontrole (Baise, 2008; Casper et al. 1980; Anderluch et al., 2003; Klump et al., 2000; e Fassino et al. 2002).

Andersen (1999b) afirmou que homens anoréxicos tendem a apresentar características de ansiedade, auto-punitivas e obsessivo-compulsivas, enquanto homens bulímicos tendem a se aparentar mais narcísicos.

Relevância do tema

Prevalência e gênero. Quando se fala em prevalência dos transtornos alimentares na atualidade, percebe-se que seus números estão em constante crescimento. Ademais, as comorbidades e diversas consequências e efeitos adjacentes destes transtornos fazem com que pesquisas a seu respeito e seu tratamento sejam imprescindíveis (Ambulim, 2011; Nielsen, 2001).

Vale ressaltar que, apesar de os dados encontrados nas pesquisas a respeito da prevalência de Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa já apresentarem, de maneira clara, as abundantes diferenças de sua incidência entre os gêneros, faz-se importante a realização de pesquisas que busquem compreender as diferentes formas de pressão social que ambos os gêneros sofrem e suas diferentes buscas de enfrentamento (Ambulim, 2011; Nielsen, 2001).

Conforme estima o Ambulim (2011), 0,5 a 4% das mulheres desenvolvem Anorexia Nervosa e de um a 4,2%, Bulimia Nervosa. Em homens, estima-se que seja menos de 0,5 em cada 100 mil indivíduos por ano. Nielsen (2001) conclui, em sua pesquisa, que a incidência de TA é maior no sexo feminino, sendo a incidência de AN de aproximadamente oito em cada 100 mil indivíduos, enquanto a incidência de Bulimia é de aproximadamente 12 a cada 100 mil indivíduos.

Em estudo realizado por Swanson et al. (2011), com 10.123 adolescentes com idades de 13 a 18 anos, encontrou-se prevalência de 0,3% de Anorexia Nervosa e de 0,9% de Bulimia Nervosa. Copetti e Quiroga (2018) reforçam que estes são transtornos predominantemente femininos com proporção, em adolescentes, de três mulheres a cada homem (3:1). Hercowitz (2015) encontrou, em suas pesquisas, prevalência dos transtornos em 1,1% a 4,2% da população, fato este que reforça a relevância das características culturais em que o indivíduo se insere na maior ou menor incidência de transtornos mentais, incluindo, portanto, transtornos alimentares.

Outra pesquisa que aborda a prevalência média destes dois transtornos é a realizada por Hoek e Hoeken (2003). Os números encontrados são de 0,3% das mulheres desenvolvem Anorexia Nervosa e de 1% a 0,1% de mulheres e homens jovens, respectivamente, desenvolvem Bulimia Nervosa em algum momento de suas vidas.

Oliveira e Hutz (2010) afirmaram que uma das hipóteses para a maior incidência de transtornos alimentares em meninas e mulheres é o fato de estas sofrerem muito mais pressão social para obter e manter corpos magros. Como afirmou Serra (2001), a menina adolescente é o maior alvo da mídia, a partir do momento em que seu corpo é universalizado como mercadoria capitalista de consumo e fetiche para a lei do mercado. A preocupação feminina com seu peso e forma corporal não vem apenas de uma questão de saúde ou preocupação com o excesso de gordura, mas de uma organização mercadológica e capitalista que vende a magreza como a única forma corporal aceitável (Vale, 2002).

Apesar de os dois transtornos alimentares estudados e apresentados nesta pesquisa não terem grande incidência no gênero masculino, observa-se um aumento gradativo de dificuldades emocionais de homens em sua relação com seus corpos e as pressões estéticas e sociais impostas sobre eles (Vale, 2002).

Greenberg e Schoen (2008) afirmaram que, ainda que haja distinção no que concerne a prevalência de Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa entre os gêneros, observa-se a apresentação de comorbidades em comum, como depressão, abuso de substâncias, outros transtornos de ansiedade e transtornos de personalidade.

Anderson (1999b) observou, em sua pesquisa, que prevalecem, entre os gêneros, maneiras diferentes de lidar com o corpo, peso e apresentar os sintomas de transtornos alimentares. Entre elas, por exemplo, está o fato de que as mulheres costumam apresentar insatisfação corporal em termos de quilos e tamanho de roupa, comumente referindo-se à forma corporal da cintura para baixo (coxas, quadril e bunda), enquanto os homens tipicamente reportam insatisfação corporal da cintura para cima, particularmente peito e braços.

Ademais, enquanto muitas mulheres tendem a buscar, constantemente, uma magreza extrema e, a partir disso, desenvolvem comportamentos alimentares desregulados, vários homens tendem a buscar o aumento de definição muscular visto que cresceram em um contexto que socializa a crença de que homens mais musculosos são mais masculinos e atraentes, o que os leva a desenvolver comportamentos que envolvem o excesso de exercícios físicos (Anderson, 1999b).

Uma discussão mais aprofundada a respeito da maior prevalência de transtornos alimentares, em especial Anorexia e Bulimia Nervosa, em mulheres, não se faz cabível neste trabalho. No entanto, em consideração à relevância do tema na busca por uma maior compreensão a respeito dos fatores sociais, estéticos, culturais, familiares, entre outros, presentes no desenvolvimento destes transtornos em homens e, conseqüentemente, na busca por se conhecer as melhores intervenções psicológicas, pode-se ler o artigo “Males with eating disorders: Medical

considerations” ou “Eating disorders in males”, entre outros, apresentados nas referências deste trabalho.

Comorbidades. De acordo com Pinzon e Nogueira (2004), o estudo dos transtornos alimentares é extremamente necessário já que sua ocorrência causa intenso prejuízo pessoal e social, o que requer um entendimento em relação à origem, causas, desencadeamentos e tratamentos de tais transtornos.

Os resultados de uma pesquisa, realizada por Herzog et al. (2000), trazem que a Anorexia Nervosa está associada ao risco substancial de morte e suicídio. Estes números são ainda maiores quando associados a uma longa duração do transtorno, compulsão e purgação, abuso de substâncias e comorbidades psiquiátricas.

Ademais, é importante considerar a relevância de uma Distorção de Imagem Corporal, muito presente em indivíduos que sofrem de transtornos alimentares, além de causarem extremo sofrimento emocional e físico na vida do indivíduo, estão constantemente associados a sentimentos de fracasso, impotência e desespero (Herzog et al., 2000).

Estes sentimentos, como afirmou Castilhos (2004 citado por Vale & Elias, 2011), podem levar o sujeito a desenvolver estratégias de fuga ou esquiva de contextos sociais e se limitar de possibilidades de reforçamentos sociais e afetivos. Assim, em um ciclo vicioso, podem levá-lo a se engajar no consumo alimentar desregulado, como restrições, para mudar seu corpo e se sentir aceito, ou até compulsões, em busca de prazer fisiológico, mesmo que momentâneo.

De acordo com Fortes et al. (2012), observa-se um processo lento e gradativo no comprometimento da saúde física, emocional e social de indivíduos com transtornos alimentares. Estes transtornos não se instalam de maneira imediata, mas se apresentam como um ritual diário, reforçado pelas necessidades emocionais do indivíduo, ritual este que o distancia de um elo saudável consigo mesmo, com o meio e com as relações à sua volta.

Kaye et al. (2004) realizaram uma pesquisa com 672 participantes, dos quais 97 possuíam diagnóstico de Anorexia Nervosa, 282 de Bulimia Nervosa e 293 foram diagnosticados com ambos os transtornos. Destes, 41% também haviam sido diagnosticados com Transtorno Obsessivo-Compulsivo e 20% com Fobia Social. A maioria dos participantes reportaram características de TOC, Fobia Social, Fobias restritas ou quadro generalizado de ansiedade na infância, antes do desenvolvimento do transtorno alimentar. Os participantes com histórico de transtorno alimentar ou diagnosticados com o transtorno no momento da pesquisa, e que não apresentavam conjuntamente alguma comorbidade, ainda assim apresentavam tendências ansiosas, perfeccionismo e características de tentativa de prevenção de danos. A presença de qualquer outro transtorno de ansiedade tende a exacerbar os sintomas do transtorno alimentar, inclusive pelo fato de este, em si, tratar-se de um transtorno de ansiedade, intensamente relacionado ao medo de engordar

Comprometimento da saúde física. Estes transtornos possuem diversas complicações clínicas e podem afetar todos os sistemas do corpo do indivíduo. Em relação à pele e anexos, observa-se a recorrência de afinamento e perda de cabelo, unhas quebradiças, erosão do esmalte dentário e cáries (comuns em pacientes que provocam o vômito). No que diz respeito ao sistema gastrointestinal, observam-se dores abdominais, gastrites, erosões gastroesofágicas, alterações de enzimas hepáticas, pancreatite, diminuição do peristaltismo intestinal, constipação, entre outros sintomas. O sistema cardiovascular pode ser afetado, levando o sujeito a desenvolver bradicardia, hipotensão, arritmias, insuficiência cardíaca, dentre outros. Ademais dos sistemas citados acima, é comum que haja grande afetação do sistema reprodutivo, com irregularidade menstrual, amenorréia e outros sintomas; afetação do sistema endocrinológico, metabólico, hematológico, renal, entre outros (Borges et al., 2006).

Além de considerar a relevância do tema em relação à influência e interferência destes transtornos nos sistemas físicos do sujeito, é extremamente relevante pontuar a presença de comorbidades psiquiátricas associadas ao desenvolvimento dos transtornos alimentares. De acordo com Borges et al. (2006), o abuso e a dependência de drogas e álcool estão presentes em 12 a 40% dos casos de transtornos alimentares; síndromes depressivas, em 50 a 75% dos casos, transtornos de ansiedade, como fobia social e transtorno obsessivo-compulsivo, em 13 a 35% dos casos e transtornos de personalidade em 40 a 75% dos casos.

Ademais, a mortalidade de indivíduos internados em hospitais psiquiátricos para o tratamento de Anorexia Nervosa é de mais de 10% e ocorre por inanição, suicídio ou desequilíbrio eletrolítico (Oliveira & Hutz, 2010).

Portanto, reforça-se a extrema relevância de se estudar o tema dos transtornos alimentares, suas influências nos diversos sistemas do corpo do sujeito acometido com estes transtornos, levando-se em consideração todos os fatores que o levam a desenvolver o transtorno, bem como fatores que o levam a mantê-lo (Oliveira & Hutz, 2010; Borges et al, 2006).

Compreensão psicológica do desenvolvimento dos TAs. Além da compreensão médica sobre o desenvolvimento e manutenção dos transtornos alimentares, bem como a influência destes na saúde física dos indivíduos, é necessário entender como as diferentes abordagens psicológicas consideram as causas da ocorrência e manutenção de tais transtornos. Serão explicitadas as concepções de quatro abordagens psicológicas, Psicanálise, Terapia Cognitivo-Comportamental, Análise do Comportamento e Gestalt-terapia, em relação à Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa.

Apesar do consenso de que estes são transtornos de ansiedade desenvolvidos com influências multifatoriais, ou seja, aspectos socioculturais, familiares, econômicos e individuais, não há um consenso no que diz respeito ao processo psicológico que o indivíduo enfrenta, já que existem diferentes concepções a respeito da compreensão da causa e manutenção do sofrimento humano nas várias abordagens psicológicas.

Além disso, logo após a explicação do entendimento da abordagem a respeito do desenvolvimento dos transtornos, será explicitada, também, a intervenção utilizada pelos profissionais de cada abordagem psicológica no tratamento de tais transtornos. Compreende-se que existem diversos aspectos a serem considerados no tratamento de Transtornos Alimentares. Faz-se necessário compreender não só os aspectos fisiológicos, mas os psicológicos que levam uma pessoa a desenvolver e manter comportamentos alimentares desregulados, além de aspectos socioculturais que envolvem pressões sociais de magreza e questões de gênero. Outro fator essencial é o conhecimento e a compreensão da interação de cada indivíduo com seus familiares e a dinâmica familiar. Outrossim, deve-se buscar compreender aspectos de predisposição, precipitação e sustentação de comportamentos alimentares desregulados.

Desta maneira, deve-se analisar as diferentes abordagens psicológicas e suas distintas intervenções no tratamento de transtornos alimentares, considerando que cada uma possui uma compreensão de como tais transtornos são desenvolvidos e mantidos na vida do indivíduo e como diferentes intervenções levam a diferentes resultados.

Faz-se relevante observar que o indivíduo em tratamento psicológico é nomeado por distintos termos em cada abordagem psicológica e, portanto, não há consenso no uso de uma única palavra para se referir ao paciente de saúde mental. Desta forma, serão utilizados os termos designados para cada abordagem dentro de cada parte do trabalho. Para a Psicanálise, o indivíduo em análise é nomeado de *analisando(a)*, enquanto para a Análise do Comportamento e Terapia Cognitivo Comportamental, *terapeutizando(a)* ou *paciente* e, para a Gestalt-Terapia, e todas as abordagens humanistas, *cliente*.



Precisando de cursos online sobre Análise do Comportamento? Conheça os cursos disponibilizados pela Editora Artmed ministrados pelo Prof. Márcio Moreira:

[Clique aqui para acessar](#)

A visão da Análise do comportamento

A Análise do Comportamento compreende que todos os comportamentos humanos são multi-determinados por fatores ontogenéticos (a história de vida do sujeito), filogenéticos (história da espécie humana) e culturais (aspectos sociais e culturais nos quais aquele sujeito se insere). Ademais, Skinner (1953) compreende que os comportamentos são determinados pelas relações de contingência entre os eventos antecedentes a ele, a própria ação e as consequências que ela gera.

Portanto, a partir disso, entende-se que todo comportamento possui uma função na vida daquele sujeito, que incluem o contexto no qual ele se comporta, as ações que ele tem e as consequências para este comportamento em sua vida e suas relações sociais. Ademais, as consequências que sucedem seus comportamentos possuem diversas funções, podendo funcionar como reforçadores ou punições, levando aquele indivíduo a manter ou extinguir determinado comportamento de seu repertório comportamental.

No que diz respeito ao comportamento alimentar, Vale e Elias (2011) afirmaram que todo animal vivo necessita do alimento para seu crescimento e manutenção de sua vida. Portanto, ao estudar a história da espécie humana, ou seja, as contingências filogenéticas do comportamento alimentar, infere-se que a comida ganhou papel reforçador incondicionado na vida dos humanos, sendo ele a fonte de sobrevivência desta espécie. Os autores compreendem que, desta forma, os indivíduos da espécie humana nascem sensíveis ao alimento como algo reforçador para seus comportamentos.

Ademais do alimento no geral, compreendem-se diversas explicações fisiológicas e evolutivas para que alimentos mais calóricos e gordurosos, como gorduras e carboidratos possuem força reforçadora muito maior do que alimentos menos calóricos e mais leves, como vegetais e verduras. Considerando que a busca por alimentos, ao longo do processo evolutivo da espécie era a busca por energia e força, dificilmente se escutará, na clínica nutricional, médica ou psicológica, uma pessoa relatar um episódio de "compulsão alimentar com verduras em detrimento de alimentos hiper-calóricos" (Vale & Elias, 2011).

Além disso, a comida costuma eliciar respondentes prazerosos, diferentemente de comportamentos que eliciam respondentes aversivos. Por esse e diversos outros motivos, muitos indivíduos buscam, no comportamento alimentar desregulado, uma tentativa de controle emocional e fuga de eventos aversivos e punitivos (Vale & Elias, 2011).

No que diz respeito aos fatores filogenéticos do comportamento alimentar, compreende-se que os primeiros contatos com alimentos e todos os seguintes na infância costumam vir atrelados a atenção social, afeto e interações com os pais e pares. Pode-se pensar em casos nos quais crianças param de comer como forma de buscar a atenção dos pais, que costumam focar bastante na alimentação regulada de seus filhos pequenos; ou então uma criança que comem muito na busca por reforçadores positivos, já que desenvolveu conexões entre tal com-

portamento com outros de sua vida, relacionado à atenção e cuidado das pessoas próximas à ela (Vale & Elias, 2011).

Como afirmaram Vale e Elias (2011), faz-se relevante considerar, portanto, o processo de condicionamento possivelmente desenvolvido entre os estímulos sociais e afetivos presentes nos diversos contextos sociais e sua relação com o alimento e o ato de alimentar-se. O momento em que o comportamento da criança é reforçado com alimentos costuma vir acompanhado de outros reforçadores sociais, como atenção, afeto e interação com os pais, por exemplo. Dessa maneira, o alimento passa a ser, para além de um reforçador incondicionado filogenético, um estímulo eliciador de respostas relacionadas a bem-estar semelhante ao bem-estar eliciado pelos outros reforçadores sociais com os quais a criança desenvolve condicionamento respondente. Portanto, compreende-se que, em casos de privação afetiva em contextos sociais nos quais a criança se insere, pode-se observar, como consequência deste processo de condicionamento, uma busca, na relação com o alimento, destes reforçadores sociais. Esta busca pode levar esta criança ao desenvolvimento de comportamentos alimentares desregulados como a compulsão alimentar (Vale & Elias, 2011).

Desta maneira, reforça-se a importância de se escutar cada caso e compreender que o desenvolvimento de comportamentos alimentares, sejam estes regulados ou desregulados, está relacionado a diversos fatores pessoais, subjetivos e idiossincráticos de cada um.

Além dos comportamentos alimentares desregulados, outro fator relevante nos transtornos alimentares é a Distorção de Imagem Corporal, que não depende apenas da forma física real do corpo do sujeito, mas está relacionado, também, com as contingências sociais do comportamento. Segundo Vale e Elias (2011, p. 64), a distorção da imagem corporal se constrói a partir de “comportamento perceptivo exteroceptivo e comportamento verbal descritivo”. Por conta do padrão comportamental de descrição da forma física das crianças com adjetivos positivos e o reforçamento do comportamento de cuidar da forma física por parte dos pais, pessoas próximas e pares, muitas crianças desenvolvem associações, como, por exemplo, o corpo de um obeso e o adjetivo “gordo”, além de associar este adjetivo a outros, como “fraco”, “preguiçoso” e “descontrolado”. “Ao aprender a qualificar a forma do outro a criança também irá aprender a se qualificar fisicamente”.

A partir disso, portanto, compreende-se que, diversas vezes, a pessoa não avalia seu corpo como “gordo” ou “magro” a partir de sua forma física real, mas a partir das avaliações de outras pessoas sobre outros corpos, semelhantes ao seu. O autoconhecimento é desenvolvido, também, através de comportamento verbal e interação social (Vale & Elias, 2011).

A terceira geração de abordagens comportamentais têm ganhado destaque no campo de pesquisa e clínica psicológica. Dentre estas abordagens, destaque-se, nesta pesquisa, a ACT (Terapia de Aceitação e Compromisso) e a Terapia Comportamental Dialética.

De acordo com Hayes et al. (2006), o objetivo da ACT é aumentar a flexibilidade psicológica a partir da aplicação de seis processos base: defusão de impulsos, aceitação dos mesmos, con-

tato com o momento presente, reavaliação de valores, comprometimento e o Auto-Contexto, ou seja, a noção de que as pessoas não são o conteúdo de seus pensamentos e sentimentos, mas a consciência de experimentar estes pensamentos e sentimentos. A partir do momento em que o indivíduo compreende que o excesso de controle que busca estabelecer sobre si e seus pensamentos e sentimentos é o problema e não a solução, a relação entre eventos internos aversivos e seus comportamentos mal adaptativos pode mudar. Um exemplo é o de uma pessoa que se refere a si mesma como "gorda" e, conseqüentemente, restringe sua alimentação em busca de evitar sentimentos de vergonha.

Ao realizar o tratamento psicológico de Aceitação e Compromisso com tais pensamentos, esta pessoa passa a ter o poder de escolher não restringir sua alimentação e não realizar comportamentos purgativos. Ela passa a compreender que suas experiências são holísticas e que não é definida pelos seus pensamentos ou sentimentos, mas pela habilidade de escolher suas ações em cima destes.

Já a Terapia Comportamental Dialética é definida, de acordo com Nunes-Costa et al. (2009), um tratamento de regulação afetiva eficaz que envolve a aceitação dos pacientes em relação às suas dificuldades, como utilização de estratégias como o mindfulness, análises metódicas e interativas de cadeias comportamentais. No caso do tratamento de transtornos alimentares, a TCD poderá seguir modalidades individual ou grupal e o número de sessões poderá variar dependendo da idade do paciente, tipo de transtorno e outras especificidades, variando de 16 a 25 semanas de tratamento.

O primeiro processo terapêutico é a busca por diminuição de comportamentos de risco como, por exemplo, ideias suicidas, seguido do trabalho de cuidar de comportamentos que possam afetar a adesão e sucesso de tratamento. Em um terceiro momento, busca-se reduzir interferências de comportamentos associados à qualidade de vida da pessoa, como restrições alimentares e evitamento de eventos aversivos. Por fim, busca capacitar pessoas a um conjunto de estratégias comportamentais que permitam a regulação de formas efetivas de lidar com efeitos negativos de comportamentos alimentares desregulados e/ou purgativos.

Análise do comportamento: intervenção

De acordo com Oliveira e Hutz (2010), a modificação do padrão alimentar da pessoa é uma das metas do tratamento, já que é necessário que haja a restauração de um peso saudável, peso este que tem um impacto muito significativo de (e em) suas crenças e emoções. Um dos objetivos do tratamento é, também, o aumento da quantidade de alimento ingerido, no que diz respeito à Anorexia Nervosa. Em relação à Bulimia, um dos objetivos é reduzir a restrição dietética, já que esta leva o sujeito aos episódios compulsivos e de descontrole alimentar.

No entanto, para que seja possível modificar padrões alimentares, reduzir restrição dietética ou aumentar a ingestão de alimentos, faz-se necessário compreender qual a função de tais comportamentos na vida do terapeutizando em questão. Como dito anteriormente, um com-

portamento, como o comportamento alimentar, só se mantém na vida de um indivíduo se o mesmo possui contingências nas quais ele é reforçado, ou seja, se ele possui alguma função na vida desses sujeitos. Dentre as diversas possíveis funções, existem, por exemplo, pessoas que param de se alimentar em busca da atenção de determinadas pessoas em sua vida e, portanto, compreende-se que o ato de comer, ou, neste caso, parar de comer, não é o que deve-se trabalhar ao longo da terapia, e sim, as ocasiões e contingências do mesmo na vida do cliente, que o levarão a sentir a necessidade de buscar atenção (Oliveira & Hutz, 2010).

Moreira e Medeiros (2019) afirmaram que, a partir do momento em que se encontram os determinantes de um comportamento para um terapeuta, pode-se buscar prever sua futura ocorrência e controlar a mesma, ou seja, buscar aumentar ou diminuir deliberadamente sua probabilidade de ocorrência no futuro. Este é, portanto, o objetivo da psicoterapia realizada a partir da abordagem da Análise do Comportamento.

Para que isso seja possível, é necessária a construção de análises funcionais dos comportamentos do terapeuta e estas devem ser construídas nos primeiros encontros, ao longo das primeiras sessões, para que a atuação e intervenção terapêutica ocorra em cima destas informações. Isso não significa, no entanto, que estas análises sejam realizadas e concluídas neste momento inicial, pois o terapeuta deve retornar a elas ao longo de todo o processo de psicoterapia, ademais de também construir novas análises funcionais, considerando que o terapeuta continua se comportando e, muitas vezes, atribuindo novas funções a antigos comportamentos e realizando novos comportamentos com novas funções (Moreira & Medeiros, 2019).

Estudo de caso - Análise do Comportamento

Um exemplo de estudo de caso de Bulimia Nervosa com tratamento realizado pelo uso da Análise do Comportamento é o apresentado por Santos e Soares (2017). O caso é de uma jovem de 22 anos, aluna de curso universitário da área de saúde, que morava com seus pais e irmã. A cliente afirmou sofrer de BN há cinco anos e que, nos últimos meses antes do início do atendimento, seus sintomas haviam se acentuado.

A cliente apresentava engajamento em compulsões alimentares periódicas, acompanhado pela sensação de falta de controle sobre o comportamento alimentar, bem como métodos compensatórios de evitação de ganho de peso, como indução ao vômito, uso de laxantes e práticas excessivas de exercícios físicos (Santos & Soares, 2017).

A mesma afirmou que, em determinados momentos, chegava a vomitar até quatro vezes em um só dia. No início do tratamento, este comportamento ocorria cerca de uma vez ao dia, todos os dias da semana. Afirmou que tal comportamento começou no final do ensino médio, enquanto namorava um rapaz que a solicitava que comesse a mesma quantidade que ele, o que levava a cliente a comer, porém, por medo de engordar, induzir o vômito. Posteriormente, namorou outro rapaz que reclamava que a mesma comia excessivamente, afirmando que ela

iria ficar obesa se continuasse assim. Por conta disso, seus comportamentos purgativos aumentaram muito. Durante o tratamento, no entanto, namorava outro rapaz que não fazia comentários sobre seu peso nem exigências quanto ao seu hábito alimentar (Santos & Soares, 2017).

No início da psicoterapia, foi hospitalizada para o tratamento de baixa imunidade e desnutrição. Para que o tratamento fosse o mais efetivo possível, encaminhou-se a paciente para um psiquiatra e um nutricionista, com o intuito de otimizar a condução do caso, melhorar o prognóstico e favorecer a adesão da mesma ao tratamento. Além disso, levantou-se informações a respeito das atividades físicas realizadas pela paciente, para que fosse possível avaliar a qualidade e quantidade das mesmas (Santos & Soares, 2017).

Constatou-se que a mesma demonstrava muita preocupação quando não conseguia realizar as atividades, como, por exemplo, quando, ao longo do tratamento, a cliente torceu seu pé e não conseguiu seguir com as referidas atividades. Este acontecimento complicou seu quadro e comprometeu sua recuperação. Como citado no estudo de caso, Teixeira et al. (2009) afirmaram que muitos pacientes diagnosticados com transtornos alimentares podem sofrer injúrias físicas por realizarem atividade física mesmo com dores.

Em relação à análise funcional do comportamento da cliente, algumas condições serviam de ocasião para que seus comportamentos e sintomas ocorressem, como, por exemplo, a desaprovação dos pais em relação ao comportamento de dormir na casa do namorado, a exigência para realização de estágio em áreas que não lhe interessavam, bem como a demonstração de pouco interesse dos pais para com seu bem estar. Outras condições de ocasião para o aparecimento dos sintomas eram, também, momentos de ócio e dias antecedentes às provas da faculdade (Santos & Soares, 2017).

No que diz respeito às possíveis contingências históricas de sua vida, a cliente relatou ter sofrido constantes agressões físicas e verbais por parte dos pais, bem como não possuir abertura da família para questionamento de regras e valores estabelecidos ao longo de toda sua vida. A cliente afirmava que, em sua adolescência, era comum ser agredida fisicamente pelo pai quando engajava em comportamentos considerados inadequados pela família. Ademais, sua família possui histórico de diagnóstico psiquiátrico e dependência química (Santos & Soares, 2017).

Para fins de exemplificação das análises funcionais realizadas para seus comportamentos, abordaremos a análise realizada em relação ao comportamento de não sair da rotina. Pode-se concluir que este comportamento tinha, como ocasião, sua tentativa de manter o controle de sua dieta e, conseqüentemente, de seu transtorno. Todavia, ao longo do tratamento, foi possível perceber que o comportamento de não sair da rotina também era controlado pelo medo de precisar lidar com resolução de problemas (Santos & Soares, 2017).

Pode-se concluir que, no histórico de reforçamento da cliente, o comportamento de solicitar por ajuda em momentos nos quais não conseguisse resolver seus problemas por conta própria

não foi reforçado, o que levou a cliente a desenvolver uma rotina na qual buscasse, ao máximo, nunca precisar pedir ajuda ou buscar por alternativas diante de situações inesperadas (Santos & Soares, 2017).

Desta maneira, a cliente muitas vezes recorria a outras pessoas em busca de ajuda, como, por exemplo, o pai ou namorado. Pode-se concluir, ao longo da realização das análises funcionais e da compreensão das ocasiões e contingências de seus comportamentos, que seu controle parecia não estar apenas associado ao hábito de comer, mas à sua rotina de exercícios, atividades acadêmicas, aos seus sentimentos e emoções (Santos & Soares, 2017).

Pode-se verificar, portanto, que, apesar de o transtorno alimentar merecer extrema atenção, dadas suas consequências emocionais e físicas, o terapeuta deve concentrar atenção, também, a outras variáveis que o ajudem a compreender padrões comportamentais e a buscar a melhor intervenção. A Análise do Comportamento nomeia ambas investigações em Análise Molar, focada na queixa específica, neste caso, no comportamento alimentar e na Bulimia Nervosa, e Molecular, centrada nos antecedentes e consequentes ao comportamento alimentar (Santos & Soares, 2017).

Ao realizar esta ampla análise, pode-se observar, por exemplo, que o comportamento de compulsão alimentar ocorria com maior frequência em sua casa e com menor frequência em outros ambientes, podendo esta ser evidência da relação funcional que o comportamento alimentar tinha com o contexto familiar e com os sentimentos de ansiedade que a cliente sentia neste ambiente, com a pouca valorização de seus pais em relação aos seus comportamentos adequados e a punição dos mesmos, com abusos físicos e psicológicos (Santos & Soares, 2017).

Após tal conclusão, foi necessário levantar a rede de apoio para a qual a cliente pudesse recorrer, por isso a importância do envolvimento de outras pessoas no tratamento. Neste caso, a cliente foi capaz de informar, lentamente, as pessoas de sua vida sobre sua condição e recebeu o apoio das mesmas, como sua mãe, irmã, amigas e namorado, e, desta forma, buscar modificar possíveis antecedentes e mantenedores de seus comportamentos alimentares desregulados (Santos & Soares, 2017).

Portanto, faz-se possível destacar que o transtorno alimentar, assim como todos os transtornos mentais, exigem uma atuação multidisciplinar para que haja uma intervenção integral e efetiva. Ademais, deve-se deixar claro que o caso explicitado acima foi um exemplo para o tratamento de transtornos alimentares para a Análise do Comportamento, a partir do momento em que se afirma que não houve clareza em relação ao diagnóstico, já que a cliente apresentava comportamentos tanto de Anorexia Nervosa quanto de Bulimia Nervosa (Santos & Soares, 2017).

Desta forma, revelou-se a importância da realização de análises funcionais que buscassem compreender as ocasiões para a resposta da cliente, bem como as contingências reforçadoras e punitivas que mantinham ou extinguíam seus comportamentos, podendo levar a cliente ao

sofrimento. Além disso, por fim, é importante ressaltar que, ao longo de todo o tratamento, a cliente apresentou recaídas e avanços e que, apesar de efetivo, o tratamento nunca é linear, variando sempre de cliente para cliente e comportamento para comportamento (Santos & Soares, 2017).

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO APLICADA (ABA)
O REFORÇAMENTO



MÁRCIO BORGES MOREIRA

Livro publicado pela Editora do Instituto Walden

[Clique aqui para saber mais sobre esta obra](#)

A visão da Gestalt-terapia

De acordo com Kyian (2006), para a Gestalt-terapia, a vida se caracteriza por estabilidade e desequilíbrio do organismo, que está sempre em busca de seu processo homeostático. Portanto, quando este processo falha e o organismo se mantém em estado de desequilíbrio por muito tempo, ele se torna incapaz de satisfazer suas necessidades. Para esta abordagem, este é o processo de adoecimento.

É no mundo em que se insere que o indivíduo busca formas de satisfazer suas necessidades e, para que ele as obtenha, ele precisa ser capaz de discriminar sua necessidade dominante, ou seja, a figura a ser fechada naquele momento, de todas suas outras necessidades (figuras). Este processo de reconhecimento e satisfação de necessidade é chamado de formação e destruição de Gestalt (Kyian, 2006).

Este processo é constante e se inicia toda vez que surge uma necessidade na vida do sujeito ou, em casos em que existem várias necessidades, o sujeito as hierarquiza de forma a manter uma como a figura daquele momento, a necessidade principal. Unida à necessidade, há uma tensão, pois a mesma leva o organismo a um desequilíbrio; com o desequilíbrio, ele se mobiliza para uma ação, em busca de sua homeostase inicial. Esta mobilização deixa o organismo em interação com o meio e se chama ‘ação de contato’ ou ‘ação de fuga’, em casos em que o sujeito rejeita a figura (Kyian, 2006).

Quando a necessidade, ou seja, a figura do momento, é satisfeita, ela volta ao fundo e novas figuras surgem, de maneira a reiniciar o ciclo. Esse é o processo denominado, em Gestalt-Terapia, de ciclo de contato, ou seja, o processo de figura/fundo, em busca de satisfação de necessidades. Para que o ciclo de contato se complete, é necessário que a figura se destaque claramente contra o fundo (Kyian, 2006).

O fundo de cada indivíduo é composto por seus aspectos individuais, referentes à sua história de vida e todos os aspectos que a compõem, como situações inacabadas, fluxo da experiência presente, crenças, filosofia de vida, religião, mecanismos de defesa, entre outros. É contra esse fundo que a figura se delinea. Algumas figuras podem ser chamadas de fixas ou cristalizadas, são aquelas que não obtiveram seu fechamento, pressionando o organismo constantemente na busca de sua satisfação; o acúmulo delas leva à neurose (Kyian, 2006).

Pode-se utilizar esta introdução da abordagem para a compreensão do desenvolvimento dos transtornos alimentares. De acordo com Nunes e Holanda (2008), os transtornos alimentares, para a Gestalt-terapia, são um processo de adoecimento, ou seja, uma perda da homeostase do sujeito. Esta abordagem compreende o ser humano com base na sua existência, na sua subjetividade e no seu potencial de constante crescimento e auto-regulação, no potencial para tendência atualizante. A saúde é compreendida como manutenção da homeostase e do equilíbrio e a manutenção do potencial de criatividade, espontaneidade e sensibilidade que todo ser humano tem.

Portanto, compreende-se que o adoecer, de acordo com esta abordagem, é um processo de ajustamento criativo disfuncional, na busca por proteção de determinadas experiências insuportáveis. O ajustamento criativo disfuncional de um indivíduo pode parecer ilógico, para quem o vê de fora, porém sempre diz respeito às características específicas da vida dele, da situação social, cultural, familiar, individual, entre outros fatores. Portanto, os transtornos alimentares e os comportamentos alimentares disfuncionais, apesar de serem desregulados e causarem extremo sofrimento na pessoa, dizem respeito à sua busca por regulação e adaptação à realidade em que se insere (Nunes & Holanda, 2008; Kyian, 2006).

Para as abordagens humanistas, qualquer processo de adoecimento se desenvolve a partir do adoecimento das relações interpessoais do indivíduo. Os transtornos alimentares não se des- toam desta compreensão e, portanto, o foco da terapia destes e de todos os outros transtornos mentais deve estar na busca por conhecer e compreender as dinâmicas relacionais da vida do paciente, já que diversos contextos bloqueiam a criatividade, espontaneidade e sensibilidade necessárias para melhores ajustamentos criativos (Nunes & Holanda, 2008; Kiyen, 2006).

Os transtornos alimentares são, para a Gestalt-Terapia, sintomas, ou seja, sinais e signos que remetem a um significado, uma maneira de ajustamento que não está de acordo com as reais necessidades daquele indivíduo. Desta maneira, não deve-se buscar eliminá-lo já que ele é desenvolvido pelo próprio indivíduo e possui funções na busca pelo seu pleno funcionamen- to; o foco deve estar em compreender o sentido existencial deste sintoma na vida deste sujei- to, é compreender que o sujeito é o sintoma. Diante disso, portanto, deve-se trabalhar com a pessoa de forma completa, compreender que não existe a possibilidade de trabalhar com o transtorno isolado, trabalhar com a dor isolada, com o comportamento alimentar disfuncional isolado, o trabalho terapêutico precisa ser realizado como um todo (Nunes & Holanda, 2008; Tellegen, 1984; Teixeira, 2004a, 2004b; Mattos, 2000).

Nunes e Holanda (2008) também afirmaram que a relação com a comida é mais uma na vida do sujeito e, logo, pode ser representação de outras relações adoecidas em sua vida. Ou seja, o paciente pode usar esta relação como metáfora e, portanto, o objetivo terapêutico não está em trabalhar com os aspectos formais e objetivos da alimentação em si (quantidade de comi- da, horário que come, o que come), mas, sim, trabalhar com o mundo daquele paciente, com seus significados e sentimentos em sua existência e suas relações com o mundo e com os ou- tros.

O objetivo da terapia destes transtornos nesta abordagem é, portanto, inicialmente, descobrir para qual ajustamento criativo este transtorno serve e como a pessoa se apropria do compor- tamento alimentar desregulado como mecanismo de evitação e proteção. Com o foco nas ca- lorias que consome, nos comportamentos de privação de comida, nos processos de compul- são e purgação, entre outros, o indivíduo pode estar em busca da desapropriação de suas questões subjetivas, que são o real cerne de seus conflitos e sofrimento, suas angústias, ansie- dades, sua relação com outros indivíduos e sua sexualidade (Nunes & Holanda, 2008; An- germann, 1998; Teixeira, 2004a, 2004b).

O transtorno alimentar pode ser compreendido, também, como uma interrupção do contato de forma ríspida, ao não conseguir resolver algum ponto na relação e no contato com o outro. Ele busca, desta maneira, aliviar em seu próprio corpo alguma tensão construída no problema relacional com o outro.

Além disso, existem situações de retroflexão nas quais o indivíduo busca fazer em seu corpo o que gostaria de fazer no outro. A Anorexia e Bulimia podem ser exemplos de retroflexões, nos quais o indivíduo devolve para si, ríspida e violentamente, suas dificuldades relacionais no contato com o outro (Carvalho & Lima, 2017).

Este mecanismo de defesa reforça a visão gestáltica de que todo adoecimento diz respeito a adoecimentos nas relações presentes na vida da pessoa e que, conseqüentemente, o foco da terapia deve estar na resolução e melhor compreensão das dinâmicas relacionais na vida do mesmo (Carvalho & Lima, 2017).

Gestalt-terapia: intervenção

Carvalho e Lima (2017) reforçaram que o foco da psicoterapia gestáltica não está na modificação do comportamento alimentar desregulado, nem na busca pelas causas do mesmo no passado do cliente, mas sim, no processo de desenvolvimento de um ajustamento criativo funcional para a situação presente. Essa abordagem, assim como todas as abordagens humanistas, dão maior ênfase para o aqui e agora, ou seja, para o momento atual em que o sujeito se insere e, por isso, o foco do tratamento deve estar na vida atual do cliente. Isso, no entanto, não significa ignorar ou desconsiderar o passado do cliente ou suas ansiedades em relação ao futuro, apenas significa compreender como o cliente se sente agora, como o passado dele afeta o agora e como seus pensamentos em relação ao futuro afetam sua vida hoje.

De acordo com esta abordagem, o adoecimento psicológico está relacionado a uma falta de *awareness*, ou seja, de percepção subjetiva do indivíduo no que diz respeito ao fluxo temporal e espacial em que se insere, o que o leva a manter relações desreguladas com seu passado, presente e futuro e com os espaços em que convive. No que diz respeito aos transtornos de ansiedade, segundo Santos e Faria (2006), o indivíduo ansioso tem sua espacialidade reduzida de diversas maneiras, com resultados, como, por exemplo, redução das interações sociais em situações nas quais sente que "os olhos de todos" se voltarão à si; compreensão do mundo de maneira claustrofóbica, onde o sujeito projeta ao mundo a experiência de estreitamento e opressão interna. No tocante ao tempo para indivíduos ansiosos, vive-se em um tempo contraído, como se nunca houvesse o suficiente para tudo que deve ser feito; a vivência subjetiva do tempo também é estreita e contida.

Desta maneira, o indivíduo estabelece uma diminuição significativa de seu campo vivencial. Dito isto, compreende-se que o indivíduo ansioso possui extrema dificuldade de se inserir e se manter no momento atual, o que o impossibilita de fechar as necessidades de maneira hierarquizada e ordenada. Indivíduos que apresentem transtornos alimentares não só comumente

apresentam-se abalados por uma série de encontros em sua história passada como também possuem uma perspectiva sombria para com seu futuro (Santos & Faria, 2006).

Portanto, o principal objetivo da clínica gestáltica com indivíduos que sofrem de transtornos de ansiedade, assim como os transtornos alimentares, é buscar trabalhar em sua inserção no momento presente, em oposição a buscar compreender os motivos que o levaram a desenvolver tal forma de relacionar-se com o mundo (Carvalho & Lima, 2017; Santos & Faria, 2006).

O terapeuta da Gestalt-Terapia deve dar muita atenção ao processo de construção do vínculo terapêutico, já que é apenas com este bem estabelecido que o cliente pode desconstruir seus mecanismos de defesa que o impossibilitam de perceber o que o faz desviar a atenção e o contato com determinado conteúdo causador de sofrimento. O principal objetivo terapêutico é a construção de *awareness* a respeito das diversas situações de sua vida nas quais, muito provavelmente, o cliente se relaciona de maneira similar à qual se relaciona com sua alimentação e seu corpo (Carvalho & Lima, 2017; Santos & Faria, 2006).

Kyian (2006) reforçou que é papel do Gestalt-terapeuta propiciar a oportunidade para que o cliente possa crescer, ou seja, frustrar o paciente de tal forma que ele possa desenvolver seu próprio potencial. Normalmente, quando a consciência de algo, alguma figura ou necessidade, se torna desagradável, o indivíduo tem a tendência de interromper o processo terapêutico e criar uma zona de neurose, mantida por interrupções e figuras inacabadas. É por meio do trabalho terapêutico que o indivíduo toma consciência de suas interrupções e lhes atribui capacidade de retomada de fluxo, processo denominado *continuum* de consciência.

O tratamento dos transtornos alimentares não tem seu foco apenas na alimentação, deve-se abordar conteúdos relacionados à família, estudos, profissão, amigos, namoro, escola, entre outros, visto que, assim, permite-se que o cliente entre em contato com o campo e com questões de sua história que foram esquecidas, ou que ao menos ele tentou esquecer, e aparecem como sintomas em sua relação com o corpo e alimentação (Kyian, 2006).

De acordo com os autores, para esta abordagem, o corpo é extremamente importante, já que ele possui diversas terminações nervosas e, logo, muita sensibilidade; é no corpo que se expressam os anseios, angústias, sentimentos, sensações, imagens, podendo essa expressão ser consciente ou inconsciente. Os transtornos alimentares e a distorção de imagem corporal são transtornos intimamente relacionados ao corpo e à relação do sujeito com este (Carvalho & Lima, 2017).

De acordo com Kyian (2006), o sintoma corporal é utilizado, pelo terapeuta, como “porta de entrada” que permite o contato direto com o cliente. Isso significa que o Gestalt-terapeuta busca respeitar a “via” que o cliente escolheu, mesmo que involuntariamente, para expressar seus sintomas e sua dificuldade de aceitação de suas figuras. O processo terapêutico busca levar o cliente a amplificar o que sente e amplificar sua compreensão de seu sintoma para melhor percebê-lo, e para lhe dar a palavra, antes mesmo de interrogar sobre seu significado.

Estudo de caso - Gestalt-terapia

A abordagem gestáltica compreende os transtornos mentais e os comportamentos desregulados como tentativas de autorregulação. Pensando analogamente aos transtornos alimentares, os comportamentos alimentares desregulados seriam uma busca por nutrição em decorrência de alguma fome; essa fome seria, em realidade, uma carência emocional não suprida na vida do indivíduo (Costa & Sousa, 2011).

Dessa forma, antes de buscar eliminar um sintoma da vida do cliente, faz-se necessário compreender o que ele busca suprir com este comportamento e o que não está sendo suprido em seu campo emocional; o sintoma serve de muleta e é o que está, atualmente, sustentando o sujeito, retirá-lo sem, antes, desenvolver ajustamentos criativos nos a cliente possa se sustentar seria, no mínimo, agressivo. O TA é experienciado de forma singular e apenas o paciente acometido com ele é capaz de dar sentido ao que vive (Costa & Sousa, 2011).

Ademais, compreende-se que, visto que os transtornos alimentares são, em sua concepção, transtornos de ansiedade, é comum que a temporalidade e espacialidade do indivíduo estejam fortemente desreguladas, de forma que a percepção que o indivíduo tem do tempo e espaço em se insere seja, em realidade, distorcida. Outrossim, faz-se necessário inserir este cliente em seu tempo e espaço, visto que sua relação com sua alimentação também se apresenta como sintoma desta desregulação (Costa & Sousa, 2011).

Um caso clínico de Bulimia e a intervenção realizada pela abordagem gestáltica foi apresentado por Costa e Sousa (2011). A cliente tinha 30 anos, é casada e possui dois filhos. A mesma buscou terapia após perceber que seus comportamentos alimentares desregulados estavam voltando à sua rotina. Ademais, afirmou já ter chegado ao peso de 48 kg, quando precisou ser hospitalizada e, apesar de pensar que havia melhorado após um ano de terapia, relata ter voltado a vomitar, após as refeições, todos os dias.

Em relação à sua rotina, a paciente administra seu lar, conciliando seu tempo com os compromissos extracurriculares dos filhos e compromissos sociais de trabalho e com o esposo. Relatou que, na fase de sua vida em que pesava 48 kg, era muito reconhecida pelas pessoas, o que a levava a tentar manter tal peso e forma corporal, apesar de ter consciência de que estava doente (Costa & Sousa, 2011).

Afirmou se considerar um fruto indesejado, sua mãe era babá e engravidou do patrão; as queixas mais comuns da cliente são em relação à sua mãe, relata nunca ter se sentido amada pela mesma, que a mãe nunca olhava para ela e que nunca a aceitava como era; e de seu esposo, que nunca tem tempo para ela e é agressivo com seus filhos (Costa & Sousa, 2011).

Ao longo das sessões, a terapeuta manteve uma postura gestáltica de acolhimento, buscando compreender a cliente em sua totalidade e entender suas fronteiras de contato com o mundo e com os outros. Pode-se concluir que a terapeuta apreendeu o significado da experiência vivi-

da pela cliente com a bulimia, buscando, também, ampliar esta compreensão para outras vias, como a maneira que ela se relaciona consigo mesma, com a comida, com o corpo e com o mundo (Costa & Sousa, 2011).

De acordo com Miller (1997), o adoecimento é fruto da busca por confirmação de um sistema falso de identidade, da postura que a pessoa desenvolve ao tentar mostrar o que é esperado dela e não o que ela é de verdade. Dessa forma, o homem se fecha para si mesmo e se aliena de suas necessidades, impossibilitando a missão de tornar-se si mesmo e desenvolver seu potencial de atualização. A bulimia é um exemplo claro de desligamento, no qual a bulímica se faz incapaz de discriminar suas necessidades e emoções próprias e costuma engolir padrões sociais que não dizem respeito a si. Pode-se concluir, portanto, que a bulimia é uma maneira adoecida de estar no mundo e uma tentativa falha de se adaptar a ele e se autorregular.

Concluiu-se que a cliente construiu sua autorregulação na tentativa de buscar nutrição afetiva, em decorrência da fome ocasionada pela carência daquilo que é fundamental ao ser humano, a confirmação externa; neste caso, confirmação de sua mãe. Fica muito claro, neste caso, que a bulimia é experienciada de forma singular e diz respeito àquela pessoa única, que dá sentido ao que vive (Costa & Sousa, 2011).

De forma, o gestalt-terapeuta buscará compreender os ajustamentos criativos da cliente, de forma a conhecer as condições para que os mesmos tenham se desenvolvido, se são funcionais ou disfuncionais, o que a paciente consegue ou deixar de conseguir ao realizá-los e quais deveriam ser mantidos e quais deveriam ser modificados (Costa & Sousa, 2011).

Além disso, o objetivo da terapeuta foi o de desenvolver *awareness* na cliente, de maneira a tentar levá-la à consciência dos motivos pelos quais faz o que faz e conhecer suas figuras, ou seja, suas necessidades. A figura é compreendida como um movimento de tensão interna e a cliente assume dominâncias e preferências de atenção para as figuras, que se destacam do fundo complexo que é o contexto em que vive, suas emoções, experiências passadas, relações atuais, entre outros (Costa & Sousa, 2011).

É importante ressaltar que a atenção que a cliente dá para um figura nem sempre é consciente, é comum que uma figura receba extrema atenção enquanto outras são deixadas de lado, comumente gerando muito sofrimento e o desenvolvimento de ajustamentos criativos disfuncionais que levam o sujeito a negar ou suprimir necessidades que deveriam ser supridas (Costa & Sousa, 2011).

O processo terapêutico nesta abordagem buscou levar a cliente à construção de um *awareness* a respeito de seus ajustamentos criativos, para que a mesma fosse capaz de compreender os motivos pelos quais desenvolveu e manteve estes comportamentos alimentares. De acordo com (Costa & Sousa, 2011), Sato (2007) afirmou que é comum a existência de conflitos relacionais familiares em pessoas com bulimia, em especial na relação com a mãe, com muita cobrança e expectativas. No caso da cliente citada acima, a relação com sua mãe era permea-

da por diversos conflitos, principalmente no que diz respeito ao sentimento que a mesma tinha de não aceitação e falta de desejo da mãe para com sua existência.

Para esta cliente, a bulimia era uma "luta contra o corpo", de mulher sensual, com seu protótipo de beleza ("seios, pernas, glúteos em proporções generosas") a um corpo desnutrido e, em suas palavras, "sem peito", "sem bunda", somente "pele e osso". Ao longo do tratamento, a terapeuta foi capaz de conhecer a cliente e seus ajustamentos criativos, construídos de acordo com as condições precárias de sua vida. A mesma cresceu em um contexto de falta de confirmação e aceitação, que serviu de campo para o desenvolvimento de muito sofrimento, *gestalts* inacabadas e comportamentos alimentares desregulados que levaram a cliente a não-autenticidade (Costa & Sousa, 2011).

Neste caso, também se faz relevante a compreensão de que, para a Gestalt-Terapia, a criança costuma abrir mão de suas inúmeras necessidades em busca da plena satisfação dos outros, daquilo que se espera dela, da confirmação externa; isto faz com que muitas crianças não queiram, suprimem, transformem ou distorçam suas necessidades para manter reconhecimento de familiares e outras pessoas importantes em suas vidas. A cliente em questão desenvolveu comportamentos alimentares desregulados como ajustamentos criativos disfuncionais e pouco satisfatórios na busca por confirmação e aceitação de sua mãe, entre outros indivíduos de sua vida (Costa & Sousa, 2011).

É importante ressaltar, neste caso, que, embora o tratamento tenha sido realizado unicamente com a cliente e que não houve, ao menos no texto, a explanação de momentos em que os familiares estiveram presentes no tratamento da cliente, o que foi apresentado no *aqui e agora* dela apresenta pontos de relevância destas relações no desenvolvimento e manutenção de seus sintomas. Pode-se observar um aumento no número de pesquisas que abordem a importância da participação ativa dos familiares no tratamento dos TAs como uma das melhores intervenções neste processo. No entanto, em casos em que isso não faz presente objetivamente, ainda se observa a presença e relevância da comunicação de temas que envolvam as relações familiares e a influência da melhor compreensão delas para a melhora e redução dos sintomas, considerando que a abordagem gestáltica compreende as pessoas critério da vida do paciente como essenciais no desenvolvimento de sintomas; contudo, também são essenciais no processo de *awareness* em relação aos mesmos e no auxílio em sua melhora.

Uma história de aprendizagem operante

Márcio Borges Moreira

Lucas Couto de Carvalho



[Clique aqui para saber mais sobre esta obra](#)

A visão da Terapia Cognitivo-Comportamental

O comportamento alimentar é influenciado por aspectos culturais, sociais, familiares e individuais. Como afirmaram Gonçalves et al. (2021, p. 2), as práticas alimentares vem se modificando ao longo dos anos, já que hoje em dia "não se apresentam apenas como a ingestão de alimentos, mas com razões sociais, delineando o convívio entre as diversas culturas e sendo delineada pelas tradições desses grupos sociais".

Desta forma, a TCC compreende que compulsão ou restrição alimentar podem ser estratégias de enfrentamento utilizadas com intuito de resolver ou ao menos amenizar dificuldades cotidianas, considerando que tais comportamentos podem servir, momentaneamente, como fonte de prazer na vida diária. Além disso, os autores ainda abordam a alimentação emocional, ou seja, o movimento de comer como reação a emoções negativas e muito intensas.

De acordo com Beck e Rosa (2013), a teoria da Terapia Cognitivo-Comportamental fundamenta-se na noção de que o adoecimento vem de um transtorno de pensamento e que o pensamento disfuncional do terapeuta e sua maneira de interpretar determinadas experiências é o que o leva ao sofrimento e ao desenvolvimento de transtornos mentais. Dessa maneira, a abordagem hipotetiza que as emoções, comportamentos e até reações fisiológicas de uma pessoa são influenciados pela percepção que a mesma tem dos eventos que vive e a interpretação de eventos pode levá-la a pensamentos automáticos que geram uma reação.

A autora ainda afirmou que o objetivo da Terapia Cognitivo-Comportamental é levar o terapeuta a compreender seus pensamentos e sua percepção em relação às situações que vive para que possa compreender o que o leva a reagir e se comportar da maneira que se comporta. É fundamental, no processo terapêutico, que o terapeuta consiga passar a diferenciar seus pensamentos automáticos de suas emoções, passando, assim, a distinguir emoções e nomeá-las, para que compreenda a intensidade das mesmas e a influências delas e de suas percepções em seus comportamentos (Beck & Rosa, 2013).

O principal objetivo é fazer com que o terapeuta se torne capaz de identificar dois tipos de pensamentos, aqueles que já identificou como disfuncionais dentro do *setting* terapêutico e as maneiras que tende a repeti-los em outras situações de sua vida, e cognições novas que desenvolva fora do contexto terapêutico. Para isso, o terapeuta cognitivo-comportamental utiliza-se de técnicas, parte integrante da terapia, que busca ampliar as oportunidades de mudanças cognitivas e comportamentais durante a sessão do paciente e ensinar habilidades que o mesmo possa utilizar ao longo de toda sua vida (Beck & Rosa, 2013).

Murphy et al. (2010) afirmaram que as principais características de pensamentos de pacientes anoréxicos e bulímicos dentro do contexto clínico dizem respeito à supervalorização e importância dadas ao formato corporal e peso e o controle que eles buscam sobre estes dois aspectos corporais. Estes indivíduos também tendem a realizar julgamentos de si mesmos baseados na percepção que têm de sua *performance* em outros domínios de suas vidas (qualidade de

seus relacionamentos, capacidades no contexto de trabalho, prática de esportes), inteiramente baseada em seus corpos e formato corporal e na habilidade que acreditam ter em controlar estes aspectos (Murphy et al., 2010).

Na anorexia nervosa, há uma tendência de buscar um senso de controle de seus corpos com a realização excessiva de atividades físicas e na restrição alimentar, enquanto pacientes bulímicos buscam este controle na prática de comportamentos purgativos, principalmente após episódios de compulsão alimentar. É importante ressaltar que muitos destes episódios podem não se enquadrar, de fato, na definição de compulsão alimentar, no que diz respeito à quantidade de alimento ingerida ou até no período de tempo em que foi ingerida, no entanto, o que importa durante o tratamento é, justamente, a compreensão e cognição do indivíduo em relação à estes episódios, que podem ser nomeados de “compulsão subjetiva” (Murphy et al., 2010).

Este é um ponto muito importante na compreensão destes transtornos para a Terapia Cognitivo-Comportamental, visto que esta abordagem compreende que o desenvolvimento de transtornos mentais, como os transtornos alimentares, estão mais relacionados ao pensamento que o indivíduo tem em relação aos seus comportamentos e sua percepção subjetiva de seu corpo, peso e formato corporal, do que o que ele come e como seu corpo aparenta objetiva e realisticamente falando (Murphy et al., 2010).

Portanto, a busca por controle corporal é a mesma em ambos os transtornos, ainda que ocorra através de comportamentos distintos. Esta compreensão reforça a relevância de levar estes terapeutizando, ao longo do tratamento, a apreender seus pensamentos e a influência de sua cognição a respeito de seus corpos, alimentação e peso corporal em seus comportamentos e seus sintomas (Murphy et al., 2010).

O comer desregulado é uma forma muito complexa de ser manejada, considerando sua causa e manutenção multifatoriais e idiossincráticas. Oliveira e Deiro (2013) afirmaram que a perda do controle do consumo alimentar se dá por padrão comportamental semelhante ao de transtornos por uso de substâncias, o que reforça a necessidade de se pesquisar e tratar os transtornos alimentares.

Murphy et al. (2010) abordaram, ainda, três processos que influenciam na manutenção de comportamentos compulsivos e purgativos em pacientes bulímicos. O primeiro seriam os problemas em diversos contextos da vida do indivíduo, que o levam a ter dificuldade em manter dietas restritivas. Em segundo lugar, o fato de o comportamento de compulsão alimentar aliviar, temporariamente, estados emocionais negativos e ser uma distração para problemas externos, podendo se tornar, desta maneira, uma tentativa de enfrentamento destes problemas. Por fim, terapeutizando que apresentem comportamentos purgativos tendem a ter a noção equivocada de que a realização de vômitos e o uso de laxantes seriam soluções efetivas de controle e até perda de peso. Reforça-se, novamente, a relevância do pensamento e das

concepções cognitivas do sujeito em relação aos seus comportamentos e as consequências deles em seu formato e peso corporais.

Apesar da explicação acima em relação às possíveis causas cognitivas para o desenvolvimento dos comportamentos alimentares desregulados e de transtornos alimentares, percebe-se dificuldade em encontrar, inclusive em inglês, maiores explicações da TCC a respeito da concepção teórica destes transtornos. Pode-se observar um número muito maior de textos que abordam o tratamento destes transtornos a partir da aplicação das práticas cognitivo-comportamentais.

Terapia Cognitivo-Comportamental: intervenção

Beck (2013) afirmou que a Terapia Cognitivo-Comportamental é uma abordagem objetiva que busca identificar e corrigir alterações comportamentais e cognitivas e entende que o sistema de crenças do indivíduo determina seus comportamentos e sentimentos. Portanto, pessoas com sistemas de crenças desreguladas possuem visão distorcida a respeito de sua realidade e do mundo ao seu redor, o que as leva a sofrimento e a buscar estratégias de enfrentamento desreguladas.

Os transtornos alimentares, sendo assim, podem ser interpretados como estratégias desadaptativas de enfrentamento de algum sofrimento pelo qual a pessoa passa, construído erroneamente de acordo com sua crença deturpada da realidade. Dessa forma, esta abordagem tem o objetivo de corrigir tais crenças e reconstruir um melhor entendimento em relação à realidade, para que a pessoa busque formas mais saudáveis e adaptáveis ao sofrimento.

Segundo Wilson et al. (2007), o tratamento cognitivo comportamental de Bulimia Nervosa consiste em procedimentos cognitivos e comportamentais designados a desenvolver motivação por mudanças, substituição de dietas disfuncionais por padrões regulares e flexíveis de alimentação, diminuição da preocupação com a forma física e o peso e prevenção de recaídas. O tratamento é tipicamente realizado em 16 a 20 sessões de terapia individual, no período de quatro a cinco meses, apesar de também ter apresentado eficácia em terapia grupal.

Ademais, a Terapia Cognitivo-Comportamental enfatiza o diálogo com um foco mais específico, no qual o terapeuta estrutura a interação e introduz tópicos. O terapeuta cognitivo-comportamental possui papel didático, oferece orientação explícita, aborda os objetivos terapêuticos e explica a racionalidade por detrás do tratamento e das técnicas utilizadas. O foco da TCC está, sempre, na situação de vida atual do paciente, e em seus aspectos cognitivos, como os pensamentos e sistemas de crenças do terapeutaizando, além de realizar a implementação de tarefas e atividades que funcionam como deveres de caso e que o paciente deve realizar em contextos externos às sessões terapêuticas (Wilson et al., 2007).

Duchesne e Almeida (2002) afirmaram que as estratégias para o tratamento na Anorexia Nervosa visam a diminuição da restrição alimentar e do excesso de atividades físicas, para que

haja maior facilidade em aumentar o peso, bem como diminuição da distorção de imagem corporal, modificação das crenças disfuncionais associadas à aparência física, alimentação e peso da paciente, além de buscar aumentar sua auto-estima.

No que diz respeito à Bulimia Nervosa, a implementação das técnicas busca normalizar o padrão alimentar e auxiliar a paciente a desenvolver estratégias para controlar a compulsão alimentar e os comportamentos purgativos de vômito, uso de medicamentos, dietas e excesso de exercícios, além, também, de buscar modificação sua relação com o corpo, imagem corporal, peso e crenças disfuncionais (Duchesne & Almeida, 2002).

Knapp e Beck (2008) dividiram o tratamento da bulimia em quatro estágios, sendo o primeiro de *psicoeducação*, no qual a paciente recebe informações sobre transtornos alimentares e episódios bulímicos, consequências médicas, pesquisas e tratamentos, juntamente com a explicação sobre a visão cognitiva a respeito da manutenção do transtorno; seguido de um estágio de *monitoramento* de comportamentos alimentares; com posterior *introdução de estratégias comportamentais* que visam tentar prevenir os episódios de compulsão e comportamentos que buscam a perda de peso e, por fim, a busca pela *promoção de autocontrole*, com implementação de técnicas para solução de problemas.

O tratamento cognitivo-comportamental separa cada estágio em um número certo de sessões, enquanto as últimas sessões visam organizar um plano que ajude a paciente a prevenir recaídas e manter o tratamento (Knapp & Beck, 2008).

Em relação ao comportamento de indução de vômitos, por exemplo, a Terapia Cognitivo-Comportamental trabalha com a exposição gradual da paciente a situações nas quais realizaria tal comportamento para que possa, aplicar técnicas de autocontrole e, mesmo após a ingestão de alimentos dos quais a paciente costuma eliminar com o vômito, ela buscaria aplicar tais técnicas para evitar tal comportamento. As técnicas são ensinadas ao longo das sessões e aplicadas de forma gradual ao longo do tratamento (Knapp & Beck, 2008).

No que diz respeito ao aumento de auto-estima, a TCC busca estabelecer comunicação com a paciente no intuito de desconstruir estereótipos sociais associados à obesidade e excessiva atenção ao formato corporal, considerando que eles vem acompanhados de sentimentos de inferioridade e fraqueza. Além disso, deve-se buscar estabelecer comunicação direta em relação às expectativas da paciente no intuito de que estas sejam realistas em relação à meta de peso e formato corporal. O objetivo é sempre buscar alcançar um equilíbrio entre auto aceitação e mudança (Duchesne & Almeida, 2002).

Como afirmaram os autores, outro comportamento que a TCC busca modificar ao longo destas sessões é a restrição alimentar. Busca-se, portanto, construir uma comunicação no que se refere à normalização da alimentação, ao se discutir fatores que favorecem a manutenção da restrição dietética e ao se realizar orientações acerca de alimentação, efeitos da mesma no ganho, perda ou manutenção de peso. Ao se realizarem tais discussões, permite-se à paciente um espaço de reflexão e melhor compreensão a respeito do processo pelo qual passa. Além

disso, a terapia também busca estabelecer “horários regulares para alimentação e exposição gradual aos alimentos e situações frequentemente evitadas” (Duchesne e Almeida, 2002).

Estudo de caso - Terapia Cognitivo-Comportamental

Como explanação do processo de tratamento Cognitivo-Comportamental de transtornos alimentares, traz-se um estudo de caso realizado por Camargos et al. (2010) com uma paciente de treze anos, diagnosticada com Anorexia Nervosa e Pneumonia Atípica. Após ser internada, recebeu tratamento multidisciplinar composto por profissionais da Pediatria, Psicologia, Nutrição e Psiquiatria. A paciente vinha apresentando recusa alimentar completa e voluntária, distorção de imagem corporal, medo excessivo de engordar e IMC de 15,5, todos fatores diagnósticos de Anorexia Nervosa. Ademais, apresentava anedonia em suas atividades do dia a dia, isolamento e ansiedade social.

Sua família possui histórico de depressão e ansiedade, com hipervalorização da imagem e desempenho, padrões de comportamentos rígidos e alta cobrança, rotina diária inflexível, com estritas ordens e regras. De acordo com relato dos pais, a paciente já realizava medição de circunferência de suas pernas e braços aos setes anos de idade, além de apresentar clara relação de emaranhamento com sua mãe, buscando estar sempre ao seu lado e ao realizando todas as atividades de casa com a mesma, preferindo sempre sua mãe como acompanhante em momentos de internação (Camargos et al., 2020).

Ao assumir um novo cargo no trabalho, sua mãe passou a ficar menos tempo em casa e a menina, mais tempo sozinha. A partir disso, suas restrições alimentares aumentaram, além da realização excessiva de exercícios físicos e comportamentos auto lesivos (Camargos et al., 2020).

O tratamento foi realizado ao longo de vinte e nove sessões, tendo sido duas ainda quando estava internada e todas as outras em momentos pós alta da internação. Inicialmente, o foco do tratamento estava em realizar renutrição e a evitação de novos comportamentos auto lesivos. O atendimento psiquiátrico ocorreu de quinze em quinze dias, enquanto a psicoterapia foi realizada todas as semanas, com a paciente e sua família (Camargos et al., 2020).

Após a realização da anamnese e construção de vínculo com a paciente, foram realizadas técnicas no intuito de levantar a problemática, avaliar o estilo parental, elaborar diagramas para conhecimento dos pensamentos e comportamentos da paciente, bem como treinar práticas de *mindfulness*, como, por exemplo, a técnica de respiração em três etapas (Camargos et al., 2020).

Posteriormente, foram realizadas intervenções para reestruturação cognitiva ao buscar modificar seu pensamento, com técnicas como o Registro de Pensamento-Ação e construção de frases de incentivo à autoestima com a música favorita da paciente. Após a avaliação da eficácia das intervenções e dos sintomas da paciente, buscou-se acrescentar mais intervenções

destinadas aos sintomas da Anorexia Nervosa, buscando intervir em sua distorção da imagem corporal, como, por exemplo, a realização de técnicas de comparação da percepção de corpo com o contorno real de seu corpo em um papel. Também foram realizadas técnicas de vivências emocionais de imagens mentais, dramatizações e reparentalização com a terapeuta (Camargos et al., 2020).

Por fim, nas últimas sessões do tratamento, realizou-se uma revisão das habilidades desenvolvidas ao longo da terapia, bem como das ferramentas aprendidas ao longo do processo. Observou-se, na paciente, crenças de desamor, desamparo e desvalor, expressas em seus pensamentos como "me sinto inútil e desprezível", "estou gorda", "sou culpada por ter a doença". Além disso, crenças secundárias de compensação, como afirmações de "gostaria de ser muito magra para ser muito feliz". Com o intuito de evitar situações sociais que lhe davam medo, a paciente também traçava estratégias comportamentais como não ir à escola, e, como reação à sua raiva, a paciente realizava comportamentos de autoagressão, como se arranhar ou bater (Camargos et al., 2020).

Após o tratamento, a paciente "apresentou melhora em seu comportamento alimentar, diminuição do medo de ingerir alimentos e aumento de peso com novo índice de massa corporal". A mesma realizou uso de suplementos alimentares no começo do tratamento nutricional e psiquiátrico, que foi retirado ao longo do tratamento psicológico. Ao final, afirmou que seus maiores aprendizados foram de não poder ficar sem comer e de que não deveria preocupar-se com o que os outros pensam a seu respeito. É importante ressaltar que a introdução de intervenções baseadas na distorção de imagem corporal só foi possível após consolidação do vínculo terapêutico, posterior às primeiras quinze sessões (Camargos et al., 2020).

Pode-se concluir, portanto, que o tratamento de transtornos alimentares pela TCC ocorre com o uso de múltiplas técnicas que buscam explorar registros imagéticos, percepções sensoriais do paciente, bem como busca realizar um trabalho holístico que envolva flexibilizar crenças e esquemas relacionados aos comportamentos alimentares. Por fim, deve-se considerar que o tratamento do caso citado acima foi realizado de forma conjunta e multidisciplinar (Camargos et al., 2020).

Pode-se observar a eficácia do tratamento realizado a partir da Terapia Cognitivo-Comportamental, além de permitir a conclusão de que se trata de um processo objetivo de tratamento, que envolve o uso de técnicas práticas, relacionadas à percepção distorcida da paciente, bem como o uso de técnicas de *mindfulness* e técnicas vivências. Não foram utilizadas técnicas puramente cognitivas principalmente por se tratar de um caso com uma adolescente, já que, de acordo com os autores, o uso destas envolve raciocínio lógico-abstrato, o que é menos eficaz com crianças e adolescentes (Camargos et al., 2020).

Neste caso, observou-se a participação ativa da família da terapeutizando, com a realização de sessões com eles, também. Assim como abordado nos outros estudos de caso, muitos dos sintomas anoréxicos desta terapeutizando foram desenvolvidos ao longo das várias interações

com seus familiares e outras relações de sua vida; no entanto, para que haja melhora do quadro e um aumento da percepção da terapeutizando em relação aos seus sintomas e as possíveis causas de sua manutenção, faz-se relevante a participação dos familiares neste processo.



Quer assistir a vídeo-aulas sobre Análise do Comportamento ministradas pelo Prof. Márcio Moreira?

[Clique aqui para acessar](https://vimeo.com/iw4)

A visão da Psicanálise

No que diz respeito ao tratamento dos Transtornos Alimentares de acordo com a abordagem psicanalítica, deve-se abranger, inicialmente, a compreensão psicanalítica de sujeito. A Psicanálise se baseia em Descartes e sua proposição base de "Penso, logo existo" para a reflexão de entendimento do que é um sujeito. Foi apenas a partir deste pensamento filosófico moderno que o ser humano passou a ter importância e "o discurso do saber se voltou para o sujeito do saber, permitindo tomá-lo, ele próprio, como questão de saber" (Elia, 2010).

De acordo com Elia (2010), o ser humano é um ser de linguagem que se constitui no domínio do verbal e, mesmo os sujeitos que não conseguem fazer uso da função da fala, como pessoas que apresentem casos graves de Autismo ou Esquizofrenia, por exemplo, ainda estão incluídos no campo da linguagem, já que se constituíram em um mundo de linguagem. Portanto, pode-se pensar em uma analogia com sujeitos que tentam, de alguma forma, a partir de comportamentos alimentares desregulados, expressar suas falas, buscando outras formas de linguagem no processo de produções simbólicas (orais ou não). A fala, para a Psicanálise, é a maneira pela qual o plano do significante passa a ser destacável para a significação (Elia, 2010).

"O significado é secundário em relação ao significante, que portanto lhe é primário, e é esse o sentido da expressão 'primazia do significante'" (Elia, 2010). Pode-se entender, dessa forma, que a maneira pela qual o sujeito se expressa fica em segundo plano em relação ao que ele quis dizer com aquela fala, por isso a relevância de buscar, na fala do analisando, a partir da Associação Livre, a compreensão do significante daquela produção para ele.

Entretanto, a Psicanálise também leva em consideração a maneira que o significante se apresenta na vida do indivíduo, visto que atos falhos e atos sintomáticos trazem aspectos do inconsciente do paciente e deve-se apreciar tal aparição. No caso dos transtornos alimentares, portanto, deve-se alcançar a compreensão de qual é o significante por trás dos comportamentos alimentares desregulados e os comportamentos purgativos desenvolvidos pelo paciente e, outrossim, compreender o que levou aquele paciente a apresentar seu significante através da alimentação e da relação distorcida com seu corpo; qual fixação ele apresenta, qual a relação disso com sua história e seus conteúdos recalcados (Elia, 2010).

Como em todos transtornos mentais, não se faz possível generalizar a compreensão da origem e causa para o aparecimento da Anorexia Nervosa ou da Bulimia Nervosa para a Psicanálise. De acordo com esta abordagem, cada paciente é único e o desenvolvimento de seu transtorno se dá por diversos fatores pessoais, individuais e únicos de suas experiências e história de vida. No entanto, pode-se concluir que existe, na clínica contemporânea, uma nova forma do sujeito apresentar seu mal-estar, e a Anorexia e a Bulimia Nervosa se apresentam como maneiras atuais de sofrimento em relação ao contato do indivíduo com seu corpo (Elia, 2010).

Ademais, é necessário depreender a relação do sujeito com seu corpo de acordo com a Psicanálise. Lacan, em seu seminário "O objeto da Psicanálise" (1965/66), propôs que se compreenda o objeto de desejo a partir do Real, Simbólico e Imaginário. No que diz respeito ao corpo, portanto, o autor compreende que o Corpo-Real é tudo aquilo que é orgânico, '*bio-lógico*', é o corpo físico do sujeito, compreendido a partir do que se fala dele; o Corpo-Simbólico é a introdução que o sujeito faz em relação a todos os significantes dados ao seu corpo, na linguagem do mundo social, direcionadas a ele, mesmo antes dele nascer, é o emaranhado de palavras que se unirão no nome que o sujeito recebe ao nascer. Por fim, o Corpo-Imaginário é a costura do real ao simbólico, esse corpo se constrói a partir do olhar do outro sobre si, pelas carícias e toques que esse corpo recebe, ou seja, é a imagem que o sujeito vê de seu corpo e acredita que os outros veem. Pessoas com distorção de imagem a desenvolvem na construção do Corpo-Imaginário, ou seja, na absorção da linguagem direcionada a ele, no processo de relacionar as palavras do Corpo-Simbólico ao Corpo-Real.

Desta forma, portanto, reforça-se que o desenvolvimento de tais transtornos advém da relação do indivíduo com seu corpo e sua imagem corporal, construídos na relação com o mundo social ao seu redor, desde antes mesmo de seu nascimento. Além das imposições sociais e estéticas, para que o sujeito tenha sua imagem corporal distorcida, há de haver uma distorção em suas relações sociais e na linguagem direcionada ao seu corpo e à sua identidade (Lacan, 1956/66).

Pizutti (2012) afirmou que o momento de identificação da criança com a imagem de seu próprio corpo é estruturante em sua identidade e constituição como sujeito único, separado de sua mãe e de outros indivíduos anteriormente essenciais para o desenvolvimento de seu *self*. No entanto, para que o sujeito seja capaz de manter esta imagem construída e sua concepção em relação ao seu corpo, ainda que já tenha sido capaz de realizar a separação de sua simbiose inicial, ele depende da validação externa deste corpo, seja por gestos ou palavras emitidas no contexto em que se encontra, sejam estas palavras em relação ao seu corpo ou a corpos semelhantes ao seu. Portanto, considerando o contexto social carregado de pressões sociais e estéticas em que se vive, as interações sociais e todas as relações estabelecidas pelo sujeito desde sua infância serão essenciais na construção e manutenção de sua identidade e auto estima, bem como construção e desenvolvimento de comportamentos alimentares desregulados possivelmente construídos pela busca do "corpo ideal".

A partir disso, o sujeito busca, na comida e na repetição dos atos compulsivos, suprir sua falta e pode, também, revelar a impossibilidade de diferenciação sujeito-objeto, oscilando entre o orgulho de não precisar do objeto e a vergonha de depender dele. O autor ainda afirmou que este transtorno é caracterizado por fixações na fase oral, nas quais o sujeito transfere para seu comportamento alimentar e para sua relação com o corpo, sua problemática pulsional e narcísica arcaica (Lacan, 1956/66).

De acordo com Schnorr (2018, p. 19), pode-se entender a crise bulímica como um ciclo de preenchimento e esvaziamento. O paciente ingere alimentos de maneira voraz e é, posterior-

mente, acometido pela percepção da impossibilidade de se comer mais, por conta da dor física que isso lhe traz. Entretanto, esta dor não é apenas física, podendo se apresentar, também, como uma dor psíquica, visto que "o empanturramento não traz saciedade psíquica e, sim, deflagra o fracasso de seu ato". Desta maneira, os comportamentos purgativos aparecem como tentativa de alívio de dor e frustração, a partir da reconstrução da vivência inicial de vazio. Posteriormente, é comum que se sintam sentimentos de fraqueza e vergonha, já que orgias alimentares possuem reprovação moral e são vistas como pecaminosas, enquanto o jejum e a restrição alimentar são avaliados, culturalmente, como hábitos e condutas louváveis (Schnorr, 2018).

Ainda nessa ideia, Ferreira (2011, p. 4) afirmou que existem pessoas diagnosticadas com anorexia que apresentam personalidade "obstinada, organizada, estudiosa, falam muito pouco e são orgulhosas de seu sintoma", enquanto que as algumas pessoas bulímicas são vistas como desorganizadas, queixosas, que envergonham-se e buscam ocultar seus sintomas. As bulímicas idealizam e querem ser anoréxicas, visto que suas preocupações também estão relacionadas ao corpo e o ganho de peso e seu intuito é, outrossim, emagrecer incessantemente.

Um exemplo de comportamento comum na sociedade ocidental e muito aclamado pela realidade social, histórica e religiosa do contexto em que os transtornos alimentares são extremamente comuns é a quaresma. Os quarenta dias de jejum voluntário são uma prática religiosa entendida como forma de purificação através da abstinência alimentar. Como afirmou Weinberg (2010), o jejum auto imposto não significa, necessariamente, um transtorno alimentar, todavia, faz-se relevante abordar esse hábito e a influência da concepção social e religiosa envolvidas. A compreensão religiosa da funcionalidade da quaresma, segundo Massimi (2006, p. 104), citado pelo autor, é a de que este período de restrição, comumente alimentar, é o "período mais propício para que as enfermidades espirituais do homem sejam resolvidas".

Dessa forma, pode-se incluir este e outros hábitos sociais de restrições alimentares e excesso de controle do formato corporal e da alimentação como diferentes costumes sociais que reforçam, socialmente, a concepção de magreza como autocontrole e saúde e o corpo gordo e a alimentação sem restrições como descontrole e enfraquecimento (Ferreira, 2011; Schnorr, 2018).

Brusset (1991), abordado por Scazufca (1998), afirmou que a Bulimia Nervosa aparece na clínica como a busca pelo gozo impossível. Ao repetir o comportamento de compulsão alimentar, este transtorno se torna fonte de angústia, já que a paciente bulímica se sente obrigada a atos que a afastem de si mesma e que tirem o controle de seu próprio corpo. O autor constrói relações diretas entre esse transtorno e o alcoolismo, ao afirmar serem patologias do excesso, com características de impulsividade, violência, repetição e dependência. Freud (1969) afirmou que uma criança que construa sua relação com o desejo e a obtenção do gozo em suas primeiras experiências com a amamentação, por exemplo, poderá vir a buscar, em sua vida adulta, a repetição desta satisfação de outras maneiras, como, por exemplo, com a prática de beijos perversos ou com excesso de consumo de bebida alcoólica e a prática do

fumo. No entanto, aqueles que, por alguma experiência traumática, venham a compreender a sua satisfação de gozo e prazer, advinda da amamentação, como inaceitável, poderão recalcar tal desejo e, portanto, desenvolver nojo da comida e produzir vômitos histéricos.

Dessa forma, compreende-se que o entendimento psicanalítico do aparecimento de comportamentos alimentares desregulados na vida do paciente pode estar relacionado com a busca pela satisfação do desejo e o processo de recalçamento do inaceitável. Aquilo que o sujeito recalca, ou seja, aquilo que o mesmo deseja, porém acredita estar em dissonância com as exigências impostas à ele, seja pelos outros (pessoas de sua vida) ou pelo *Outro* (cultura e história pessoal), poderá ser o conteúdo que (*re*)aparecerá em sua relação com a alimentação e com seu corpo. Entretanto, não se busca a resolução do comportamento alimentar, mas a ciência do que foi recalçado e quais aspectos da história pessoal do indivíduo estão implicados nestes atos falhos e/ou sintomáticos (Freud, 1969).

Schnorr (2018) reforçou que a bulimia pode ser fruto de fragilidade narcísica no processo de constituição psíquica, podendo, ainda, estar associada à uma cumplicidade narcísica instaurada na relação com a mãe. A partir do momento em que a criança se configura em uma relação pautada na dependência pela figura materna, ela se desenvolve incapaz de vivenciar a ausência e o vazio, desenvolvidos justamente no processo de elaboração da perda do objeto. Em casos em que há presença maciça da figura materna, o indivíduo pode vir a ter diversas dificuldades no desenvolvimento psíquico.

Portanto, já que o primeiro contato do bebê com sua mãe é marcado pela mediação do alimento, pode ser também por esse meio que muitas jovens bulímicas buscam construir diferenciação em relação à mãe. A autora ainda afirma que a ingestão voraz de alimentos e os comportamentos purgativos podem ser entendidos como uma violência contra si mesmo na tentativa de evocar sensações corporais que atestem sua existência e lhe permitem se diferenciar dos outros, ainda que de maneira extremamente danosa. A precariedade na elaboração psíquica da ambivalência e do vazio em pacientes bulímicos invoca que os mesmos procurem um apelo aos seus corpos e busquem sensações que substituam este trabalho psíquico (Schnorr, 2018).

Bleichmar (2000) e Sztajnberg (2003) afirmaram que a Anorexia Nervosa e a Bulimia Nervosa seriam transtornos histéricos, já que o sujeito busca alienar-se de seu corpo a fim de buscar controle sobre o mesmo, ajustá-lo ao ideal cultural e penitenciá-lo por suas imperfeições. Essa alienação permite enxergar tais transtornos com a histeria a partir da ideia da "bela alma", com a qual a histérica busca tirar sua responsabilidade no desenvolvimento de seus sintomas. Os sujeitos anoréxicos e bulímicos, sendo histéricos, prendem-se em sua determinação de atingir objetivos e, alienados de seus corpos, não os reconhecem e pensam que estão sob controle do mesmo.

André (1996), no entanto, não compreende tais transtornos como histéricos, mas traumáticos, frutos da passagem para a adolescência, momento em que tais transtornos comumente se de-

envolvem, fruto da ineficiência na elaboração dos conteúdos provenientes desta fase. Maia (2001) também entende os transtornos alimentares como transtornos traumáticos, apesar de não restringir este trauma à adolescência, mas compreendê-lo como presente em toda a contemporaneidade. O sujeito contemporâneo, exposto ao traumático das pressões sociais e em fantasia de que se encontra em constante perigo de aniquilamento, toma medidas narcísicas patológicas, como, por exemplo, os comportamentos alimentares desregulados presentes na Anorexia e Bulimia Nervosas.

Entretanto, faz-se extremamente necessária a pontuação de que estas são possíveis vias de compreensão dos sintomas anoréxicos e bulímicos e que cada caso é um caso, sendo assim necessário buscar compreender o processo de constituição psíquica do paciente em questão, bem como sua estrutura psíquica e seu tipo clínico para a compreensão do desenvolvimento de sintomas como fruto do retorno do recalcado.

Freud (1920), em seu texto "Além do princípio do prazer", afirmou que percebeu, em seus pacientes, uma forma de compulsão à repetição na qual predomina a experiência de desprazer em detrimento da busca pelo prazer, seria um gozo pelo sofrimento. O autor busca uma explicação satisfatória sobre o tema do masoquismo que leve em consideração o que ele acredita ser seu par de oposto, o sadismo.

No artigo "O ego e o id" (1923), ele apresentou a culpa como uma expressão de tensão entre o Ego e o Superego, ou seja, o sujeito responde de maneira angustiada às exigências feitas pelo seu ideal. O Superego é a instância herdeira do Complexo de Édipo e do processo de introjeção que o indivíduo faz das leis impostas pelo Nome do Pai, ou seja, as regras sociais que são inseridas, pela figura paterna, na relação simbiótica do bebê com sua figura materna.

Suy (2022, p. 45) afirmou que os ditos da cultura, as ordens e os imperativos determinados pelos primeiros amores do bebê são internalizados por ele e é isto que Freud denomina de Superego. Essa instância é crucial para que haja interação social, haja vista a necessidade de as pessoas valorizarem o certo na relação social. Entretanto, a autora afirmou que o Superego também “encapsula um autoexigência fantasiosa”, o que costuma levar indivíduos neuróticos a constantes preocupações com o cumprimento de todas as regras impostas a si.

Freud (2004) afirmou que, inicialmente, quando o sujeito ainda está inserido em uma relação simbiótica com sua mãe, ele é o objeto único de seu investimento libidinal, visto que ele chegou à vida dependendo do amor do outro, de sua figura materna. Desta forma, o bebê se identifica como objeto precioso para suas figuras paternas e precisa que alguém aposte nele para que possa direcionar sua libido a si. Este bebê, imerso em seu Narcisismo Primário, não sente vergonha ou medo de nada, não compreende que suas ações, para além de serem afetadas pelo outro, o afetam.

Posteriormente, como afirmou Suy (2022), para que esta criança possa se tornar um ser humano minimamente agradável, faz-se necessário que este narcisismo seja furado e ele compreenda que precisa perder um pouco, que vive com outros sujeitos e, desta forma, precisa

direcionar parte de sua libido ao outro, ao seus objetos de desejo. A criança começa a ir à escola e conviver com outras crianças e, aos poucos, compreende que não é superior a seus colegas. Neste momento, ocorre a construção do Eu Ideal, ou seja, tudo aquilo que fazia parte do narcisismo do bebê e ele compreendia como seu próprio ideal, direciona-se, neste momento, a uma ideia do como ele compreende que deveria ser. A construção do Eu Ideal se dá pela introjeção das respostas que o sujeito recebe do Outro, do Ideal de Eu que construiu ao interpretar o que foi direcionado à ele. Com seu Eu Ideal, o sujeito aumenta as exigências de seu Ego e há ocorrência de recalque de todas as ideias consideradas, para seu Superego, intoleráveis.

Desta forma, a Anoréxica e a Bulímica determinam os ideais de seus corpos e de sua alimentação e qualquer comportamento que saia da fantasia estabelecida por elas as levará ao sofrimento. No seu artigo "O problema econômico do masoquismo", Freud (1924) chamou a atenção do analista ao fato de que o sujeito possui uma espécie de inibição moral, na vida e na análise, que atua sobre ele ao fazê-lo encontrar-se em um verdadeiro império moral, ainda que sem ter consciência disso. O autor afirmou que há uma diferença entre a moral inconsciente, determinada pela presença do Superego, e o masoquismo moral. Enquanto na primeira, o sujeito tem um aumento do sadismo de seu Superego, na segunda, observa-se um genuíno masoquismo que solicita castigo, seja de si mesmo, de seu Superego, seja dos outros poderes parentais de fora. No contexto dos TAs, um desses poderes poderia ser a pressão social para manutenção de um corpo magro, o que leva o sujeito a gozar em seu sofrimento na busca incessante por esse corpo: a fome que a anoréxica passa e os comportamentos compulsivos e purgativos da bulímica.

Observa-se que, tanto a imposição inconsciente de moral quanto o masoquismo moral, trata-se de relações intrapsíquicas que tem como resultado a satisfação no castigo e sofrimento. Desta forma, a necessidade de punição está atrelada ao desejo inconsciente de sofrimento presente nas fantasias de espancamento, de ter relações passivas (femininas) com o pai. Lima e Leite (2011, p. 167) afirmaram que "a volta do sadismo contra o eu ocorre sempre quando uma supressão das pulsões tem lugar impedindo que grande parte dos componentes pulsionais destrutivos se exerçam na vida".

Freud (1920), no Mito de Eros e da Psiquê, constatou que, enquanto o Eros, representante das pulsões de vida, está sempre em busca da manutenção da vida, o sadismo funciona como uma manifestação de morte e a expressão dessa pulsão é visada como a destruição de objeto. A questão que foi refletida por Freud (1924) é a contradição entre a relação do masoquismo com o princípio do prazer; se o princípio tem como objetivo buscar o prazer e evitar o desprazer, qual seria a compreensão do masoquismo como prazer através da dor? Lacan (1949/1998) ressalta que a garantia de vida se dá pela presença do desejo do Outro.

Desta forma, Lima e Leite (2011, p. 173) afirmaram que, no início da vida, "a criança abdica dos impulsos devido ao medo da autoridade, que, em última instância, é o medo da perda do amor", desta maneira, por exemplo, a pessoa que tem um transtorno alimentar percebe que

seu desejo persiste e é impossível escondê-lo de seu Superego, fato este que justifica a necessidade de punição e a permanente infelicidade dessas pacientes. O sofrimento, portanto, seria um comportamento de punição que o Ego faz ao ter desejos que confrontam o que foi definido pelo seu Superego. O sujeito sentiria prazer na punição de si mesmo, os comportamentos de restrição alimentar na anoréxica e comportamentos compulsivos e purgativos na bulímica são os comportamentos punitivos contra seu desejo. Assim sendo, reforça-se que o reconhecimento do desejo é parte crucial do processo analítico.

Em relação aos sentimentos de culpa muito comuns nos comportamentos de pacientes acometidos com transtornos alimentares, especialmente após os episódios compulsivos na Bulimia Nervosa, Freud (1924) afirmou que existiriam duas origens para ele. Inicialmente, a culpa surgiria do medo da autoridade e, posteriormente, do medo do Superego. Desta forma, após o desenvolvimento desta instância, o sujeito neurótico encontraria-se em constante sofrimento ocasionado pela impossibilidade de esconder seu desejo de seu próprio Superego. A agressividade do sujeito consigo mesmo, ou seja, seu masoquismo e, no caso dos TAs, a restrição alimentar, episódios compulsivos e comportamentos purgativos, seria, de fato, a agressividade que ele deseja liberar no outro e que foi recalcada.

Psicanálise: intervenção

No que diz respeito à Psicanálise, compreende-se que o tratamento psicanalítico de qualquer transtorno mental deve estar baseado na Associação Livre de ideias; compreende-se que o foco do tratamento está no diálogo aberto e não estruturado de ideias, com a discussão de fantasias e sonhos, bem como em temas recorrentes na fala do analisando e em suas experiências passadas. No contexto dos Transtornos Alimentares e comportamentos alimentares desregulados, a Psicanálise compreende, portanto, que é a partir da fala e da associação livre de ideias ao longo das análises, que o analisando poderá entrar em contato com seus significantes, sendo esta a forma de alcançar o inconsciente (Elia, 2010; Lacan, 1956/66; Schnorr, 2018).

De acordo com Campolina (2014), é de extrema importância o diagnóstico do transtorno alimentar e sua diferenciação de possíveis distúrbios biológicos, como diabetes, obesidade, doenças endócrinas, ou outros quadros psiquiátricos, como paranóia e esquizofrenia. Uma paciente que apresente Bulimia ou Anorexia dificilmente buscará tratamento por conta da dificuldade de implicação da mesma em seu próprio sintoma e a rara compreensão de seu papel essencial no desenvolvimento e manutenção de tais sintomas. É exatamente neste ponto que o analista deve trabalhar na análise, de maneira a levar o sujeito a se implicar em seu sintoma e, a partir disso, começar o trabalho analítico.

O analista deve identificar conexões entre os sentimentos e percepções atuais relacionadas com experiências passadas, mantendo atenção aos sentimentos compreendidos, pelo analisando, como inaceitáveis e identificando, desta forma, seus mecanismos de defesa; por fim, seu foco também deve estar no acompanhamento do analisando ao longo do processo de interpretação de seus desejos, sentimentos e ideias recalcadas e inconscientes. O tópico de dis-

cussão deve estar na relação terapêutica e nas conexões existentes entre esta relação e todas as outras da vida do analisando (Shedler, 2010).

Schnorr (2018) reforça que, nas bulímicas, é a dependência do objeto a fonte dos conflitos que as mesmas tentam aplacar em suas condutas típicas e seus comportamentos alimentares desregulados. Pode-se observar uma clara intensidade vivida na relação entre libido do Eu e libido de objeto, neste caso marcada por movimentos conflitantes, já que investir no objeto causa medo de um desequilíbrio narcísico insuportável. A partir disso, compreende-se que a vinculação necessária na relação terapêutica pode aparecer, também, como uma ameaça, visto que a transferência aparece como uma repetição do pavor da dependência do objeto.

Portanto, à medida que esta relação se fortalece, pode-se observar uma intensificação dos sintomas bulímicos e a comum aparição de resistências, a partir de faltas ou atrasos nas sessões, desqualificação de tratamento e, inclusive, abandono do mesmo. No entanto, compreende-se que o momento de contato do sujeito com seu desejo e sua falta, bem como a tomada de consciência em relação aos seus próprios pensamentos e desejos, causadores de seu sofrimento, é o momento em que o sujeito, de fato, entra em análise e é apenas a partir daí que o tratamento se faz, de fato, efetivo. Chama-se esta tomada de consciência de retificação subjetiva, o ensejo para que o analisando consiga enxergar seu papel em sua vida e possa vir a ter qualquer tomada de decisão posterior à isso (Schnorr, 2018).

É importante ressaltar que esta terapia não nega o uso de outros tratamentos integrados, como o nutricional, no processo terapêutico de transtornos alimentares. No entanto, no que se refere ao tratamento psicanalítico, Zerbe (2001) o caracteriza de acordo com o conceito de Continência. O processo de continência é essencial para que os pacientes possam fazer associações entre aspectos de suas vidas; neste contexto, o analista deve, como afirmou Zimmerman (2004), citado por Macedo (2010), "acolher, conter, decodificar, transformar, elaborar e devolver, em doses apropriadas, as identificações projetivas do paciente, depois de nomeadas e significadas". Observa-se a ocorrência de projeção de sentimentos do paciente no analista, colocando-o na posição de alguém importante de sua vida. Depois de realizar esta projeção, é ao longo do processo analítico que o paciente se torna capaz de ter maior consciência de seus afetos recalçados e realizar conexões entre estes sentimentos com suas memórias, conflitos e situações interpessoais, de maneira a descrevê-los com palavras.

A próxima etapa do tratamento psicanalítico é baseada em nomear sentimentos de maneira a permitir que os pacientes desenvolvam uma maior capacidade de manejar suas crises sem retornar aos comportamentos alimentares desregulados. No entanto, reconhece-se que este processo começa com sentimentos não nomeados e, por diversas vezes, ainda desconhecidos ao analisando. Essencialmente, a psicoterapia psicanalítica busca tornar consciente o inconsciente para aumentar as capacidades reflexivas do paciente, visto que, com maior consciência dos afetos e conflitos recalçados, pacientes possuem menor chance de fazer uso de meios mal adaptativos como, por exemplo, os transtornos alimentares (Zerbe, 2001).

Outro processo comum no tratamento psicanalítico de transtornos alimentares é a identificação dos pacientes com seus "agressores" e o tratamento de seus analistas como reflexo da maneira em que foram tratados na sua infância. No processo de transferência, pacientes podem expressar intensa frustração, raiva ou até sentimentos eróticos e amorosos para com seus analistas. Portanto, reforça-se a importância do analista de realizar papel de contingência para que estes consigam interpretar as identificações patológicas com as pessoas importantes de seu passado e construir identificações mais saudáveis com seu analista e com outros indivíduos de sua vida. Nesta terapia, interpretações são feitas, apesar de só poderem ser usadas e expressadas quando o analisando estiver pronto para ouvi-las. Em análise, o tempo é a chave; interpretações precipitadas podem levar o paciente a aumentar sua hostilidade para com o analista e aumentar, consequentemente, sua resistência (Zerbe, 2001).

Faz-se relevante destacar a importância que esta abordagem dá para a supervisão dos analistas e suas análises pessoais, visto que estes devem compreender e separar seus sentimentos e identificações transferenciais e contratransferenciais, de forma a evitar que estes atrapalhem sua escuta e presença analítica. O autor ainda afirmou que, já que pacientes diagnosticados com transtornos alimentares tendem a falar com orgulho do controle que têm (ou acreditam ter) sobre seus corpos ao vomitar quando querem, exercitarem-se por horas ou evitarem comer, analistas usam da transferência para destacar a relação desta auto-definição com relacionamentos antigos muitas vezes repetidos na atual relação com o analista. Desta maneira, outra atuação compreendida como parte do papel dos analistas é a pontuação e o destaque de atos falhos e sintomáticos do paciente, de faltas após sessões nas quais certos temas foram tocados, tentativas de espaçamento entre as sessões ou até interrupção de tratamento, visto que estes são "sintomas analíticos". Ou seja, "sintomas que devem ser articulados como significantes da história do sujeito, significantes que, localizados no Outro, portam a capacidade de representar o sujeito frente a outros significantes" (Seganfredo, 2002, p. 19).

Como afirmaram Elzer e Gerlach (2014), pessoas com transtornos alimentares apresentam muitos mecanismos de defesa e inabilidade ou grande dificuldade de lidar com suas emoções, processá-las e reconhecê-las. Estes indivíduos tendem a lidar com seus problemas através da alimentação e exercícios, visto que estão 'presos' em uma maneira primitiva de lidar com o mundo, ocasionada por uma fixação na fase oral. Isto significa que eles costumam enfrentar diversas situações de estresse e confusão emocional com comportamentos alimentares desregulados, fumo ou excesso de ingestão de bebida alcoólica. De maneira semelhante a este estágio de desenvolvimento, pacientes com transtornos alimentares possuem tendência a buscar satisfação instantânea, com uma necessidade de urgência em tentar resolver suas situações no agora, com grande dificuldade de esperar, postergar gratificação ou de lidar com frustrações. Estes sujeitos também tendem a apresentar muita dificuldade de dizer 'não' para comidas e outras pessoas, costumam ter dificuldade com limites, o que fica evidente na maneira com a qual lidam com os limites de seus corpos e com a baixa tolerância à frustração.

Desta maneira, afetos com os quais o sujeito não consegue lidar são recalçados, mas não eliminados. Eles retornam (retorno do recalçado) e se manifestam em suas vidas em forma de

sintomas; no caso de transtornos alimentares, eles retornam na relação do indivíduo com a sua alimentação. Portanto, a comida é utilizada como conforto que busca o equilíbrio, porém apenas por um certo período de tempo; a relação com a comida também é uma ferramenta na tentativa de expressar emoções ou sentimentos de recompensa ou punição. Para estes indivíduos, o alimento não possui significado de comida ou alimentação fisiológica, são inseridos como símbolos, no intuito de buscar coerência e estabilidade emocional. Como afirmou Lacan (1964/1965), "se a apresentação a quem é suposto saber 'o que eu não sei' não for recebida por este último como signo, estão (e só então) o sintoma terá estatuto de significante", ou seja, o alimento é um um significante, muito além de um mero signo.

No que diz respeito à prática psicanalítica no tratamento de transtornos mentais, portanto, compreende-se que esta é baseada na criação de um espaço seguro para que os pacientes falem, processem os afetos que se destacam na díade terapêutica, acessem os paradigmas transferenciais e contratransferenciais ao buscar assisti-los para dominar seus comportamentos sintomáticos e fazer identificações mais saudáveis com seus analistas (Elzer e Gerlach, 2014).

De acordo com Elzer e Gerlach (2014), a estrutura de atendimento psicanalítico é baseada na posição em que o analisando se coloca em relação aos outros e ao analista, na díade relacional. O método analítico ocorre através do aumento da consciência da realidade psíquica fantasiosa e compreender que desejo do analisando é desejo do Outro e é caracterizado pelas interpretações de suas associações livres e o desenvolvimento de uma relação de transferência que permite que o paciente revele seus sentimentos ao projetá-los em seu analista. Além disso, outra técnica utilizada no tratamento psicanalítico é a interpretação de sonhos, visto que a associação livre é a regra fundamental nas construções oníricas.

Dessa forma, os autores explicaram a atuação do analista de acordo com a "regra da abstinência", que busca permitir que o tratamento analítico esteja organizado de maneira a garantir que o paciente busque satisfações substitutas de seus sintomas na busca da realização de seus desejos. A segunda regra é a do "terceiro ouvido". Como afirmou Reik (1949), citado pelos autores, esta regra diz respeito à compreensão de que o analista pode ouvir o que a pessoa não falou, mas sentiu ou pensou, como também pode 'ouvir' o que ele falou e não realmente escutou, visto que sua compreensão estava abafada pelo controle do pensamento consciente. Ou seja, com a pontuação de atos falhos, o analista leva o analisando a escutar o que disse e não o que conscientemente queria dizer (Elzer e Gerlach, 2014).

Em terceiro lugar, a regra da "Atenção Flutuante", definida por Freud em 1912, diz respeito à atuação na qual o analista busca se impressionar com tudo que o analisando traz sem tentar selecionar determinados temas a serem discutidos. No caso de Transtornos Alimentares, busca-se não limitar a escuta ou dar maior atenção ao conteúdo relacionado a comportamentos alimentares desregulados ou comportamentos purgativos, por exemplo, já que esta abordagem compreende tais comportamentos e afetos como fruto de outros conflitos emocionais

não diretamente conectados necessariamente a este tema central de alimentação e corpo (Elzer e Gerlach, 2014).

No que se refere à Anorexia Nervosa e o tratamento psicanalítico, Elzer e Gerlach (2014) ainda afirmaram que faz-se necessário considerar que este tratamento leva tempo, além de que o começo desta terapia costuma assemelhar-se ao tratamento de pacientes adictos. Um dos objetivos é levar o paciente a diminuir sua intensa necessidade de autonomia, controlada por seu superego, para que o mesmo possa entrar em contato com seus desejos recalcados. No caso do tratamento da Bulimia, a relação entre paciente e analista é mais vívida e pode tolerar melhor a transferência e contratransferência, visto que estes pacientes costumam ter sua função egóica mais bem estabilizada.

Como afirmaram também Lunn e Poulsen (2012), o psicanalista deve preservar uma neutralidade em sua interação com o analisando, manter um comportamento explorador e garantir que o tema das sessões seja definido pelo paciente. No entanto, o psicanalista intervém em momentos nos quais pontua relações entre os comportamentos atuais do analisando, seu estado emocional e suas experiências passadas. Ademais, ele também identifica e responde a manifestações transferenciais, comuns após o desenvolvimento do vínculo entre os dois, identifica e reflete sobre suas possíveis manifestações contratransferenciais, observa as reações de seu analisando às suas intervenções e realiza outras intervenções em cima disso.

Além disso, Elzer e Gerlach (2014) destacaram algumas das técnicas mais importantes de um analista:

1. Perguntas abertas, semi abertas e fechadas, ainda que seja relevante destacar que perguntas fechadas são menos usadas e, portanto, utiliza-se mais de perguntas de "como", "por quê", "quem", "onde", "o que" e "quando";
2. Escuta ativa, com especial atenção a expressões como "aham", "sim" ou movimentos de linguagem corporal que levem o paciente a perceber a presença e atenção do analista (estes últimos em casos nos quais os pacientes ainda não estão no divã);
3. Pausas e silêncios, com o objetivo de levar o paciente a escutar o que acabou de dizer ou refletir sobre alguma resposta monóloga ou falta de resposta para alguma pergunta;
4. Espelhamento e parafraseamento, com o intuito de devolver ao paciente algo que ele disse e destacar contradições entre suas falas;
5. Clarificação, para que o analista compreenda melhor algum assunto e para que o paciente não fuja dele ao falar muito superficialmente sobre algum tema relevante;
6. Confrontação de conteúdos inconscientes emergentes (atos falhos, atos sintomáticos, conteúdos de sonhos) ou contradições;

7. Interpretações de possíveis correlações entre conteúdos recalcados, atos falhos e outros comportamentos relevantes em análise ou em contextos fora de análise, trazidos na sessão.

De acordo com Gorgati et al. (2002), uma abordagem utilizada no tratamento de transtornos alimentares é a Psicoterapia Psicodinâmica Focal, perspectiva psicológica oriunda da Psicanálise que se configura como uma boa proposta de tratamento para pacientes com transtornos alimentares, já que tem como principal objetivo recuperar e fortalecer a auto-estima, ao buscar compreender as sensações e afetos inconscientes que influenciam a aparição e manutenção dos comportamentos alimentares desregulados. A psicoterapia psicodinâmica não possui uma definição conceitual precisa, porém tem o foco de auxiliar o paciente a compreender os significados de seus sintomas manifestos e buscar alternativas mais adaptadas e saudáveis para lidar com seu sofrimento psíquico.

Esta abordagem busca compreender a importância da história pessoal do paciente, suas experiências primitivas traumáticas e sua influência no desenvolvimento destes transtornos, visto que “a experiência clínica revela que uma proposta de tratamento focada exclusivamente no sintoma alimentar ou exclusivamente nos conteúdos psicológicos do paciente mostra-se um tratamento parcial e incompleto” (Gorgati et al., 2002, p. 47).

As autoras também afirmaram que a proposta do tratamento deve ser integrada, buscando redução de sintomas juntamente com a compreensão dos aspectos psicológicos mais profundos que levam o sujeito a se comportar desta maneira. Portanto, o tratamento psicanalítico se apresenta como uma boa opção para estes transtornos (Gorgati et al., 2002).

Outra abordagem utilizada em pesquisas que buscam evidências científicas do tratamento psicológico de transtornos mentais é a Psicologia do *Self*, de Heinz Kohut, de 1980. Esta abordagem é oriunda da teoria psicanalítica, apesar de não ser compreendida como abordagem psicanalítica de maneira unânime.

De acordo com Azevedo e Neto (2018), Kohut defendeu a ideia de que seus pacientes apresentavam falhas na constituição de seu *Self*, que indivíduos neuróticos apresentavam uma personalidade caracterizada por um *Self* multifragmentada e desarmônico. Segundo o autor, o intuito do tratamento psicanalítico é o de ajudar o paciente a desembaraçar-se de seus objetos arcaicos e desenvolver um *self* coeso para complementar um desenvolvimento mental saudável.

Ainda segundo Azevedo e Neto (2018), Kohut compreendeu o procedimento da Psicologia do *Self* dividido em duas etapas, uma de espelhamento e escuta empática e outra de interpretação do que foi apresentado. Esta abordagem compreende que as vulnerabilidades do paciente reaparecerão na transferência com o analista. No entanto, o analista não pontua a grandiosidade do paciente, pontua, em realidade, por exemplo, a necessidade compreensível de se sentir grandioso. O analista não conforta o paciente, mas se empatiza com a necessidade de cons-

trução de uma identidade idealizável. Desta maneira, compreende-se que o analista dá especial atenção à maneira com a qual experiências do paciente impactam sua noção de Self.

Estudo de caso - Psicanálise

O caso clínico utilizado para análise do tratamento de Bulimia Nervosa para a Psicanálise é o apresentado por Campolina (2014). A analisanda, nome fictício Ana, que possuía 27 anos, apresentou comportamentos de compulsão com dinheiro, comidas, refrigerantes, esportes e anfetaminas, *glifage* (medicamento prescrito para tratamento de pré-diabéticos) e suplemento alimentar. Foi levada ao consultório com 23 anos, por sua mãe. A analisanda, no entanto, afirmou não estar doente, apenas ter o desejo de continuar magra, pois "tem horror de engordar uma grama".

A analisanda afirmou que sua mãe sempre a está criticando e que faz constantes comentários sobre seu corpo como, por exemplo, quando fala que "ela é como um elástico", que seu peso é instável e está sempre engordando e emagrecendo muito. A mãe já tirou todos os trincos dos banheiros da casa com o intuito de vigiar a filha, pois acredita que a mesma vomita tudo o que come. A jovem afirmou que sua mãe a controla em tudo e que "ela é o que a mãe quer". Seu pai é coronel, mas, como afirmou a paciente, quem possui comportamentos controladores e de chefia na casa é sua mãe; a mãe tem ciúmes do pai com as filhas e, por isso, o contato deles é pequeno (Campolina, 2014).

Durante o tratamento, Ana se mudou da casa da mãe para morar sozinha, afirmou que o relacionamento das duas sempre esteve "entre abandono e grude" e que isso a estava fazendo mal. A analisanda trouxe, em várias sessões, que também cuida de sua mãe, escolhe a roupa que ela usará quando sair e que cuida para que sua mãe sempre seja a "mulher mais bonita da sociedade". A analisanda decidiu manter a análise quinzenal pois afirmou ter certeza de que a analista estava tentando controlá-la como sua mãe (Campolina, 2014).

Ana relatou dificuldade em viver sozinha e não conseguir ganhar dinheiro suficiente para manter o estilo de vida que tinha com seus pais. Também se refere à mãe como uma mulher muito poderosa que, além de ganhar muito dinheiro, conquista a todos pela sua beleza facial e corporal. Sente-se mal por pensar isso da mãe e afirmou que esse pensamento está presente em todos os dias de sua vida (Campolina, 2014).

A analisanda relatou ter ouvido, aos sete anos de idade, na praia, uma mulher lhe falar que ela era muito linda e que tinha corpo de "mocinha", que "iria deixar todos os homens loucos". Desde então, afirma se olhar no espelho e ver uma moça gigante, com tamanho de baleia, pois entende seu corpo como "uma bunda enorme". Afirma que não consegue ficar sem namorados ou ficantes, porém que todos a tratam como sua mãe e que nenhum nunca declarou que a ama. Ana ainda se nomeia "doente por homem" e diz que "não suporta viver sem um homem para amar e ser amada"; que "não consegue andar, trabalhar e existir sem uma história de amor" (Campolina, 2014).

A mesma, durante o tratamento, voltou a morar com os pais por não suportar a "falta do colo da mãe" e por afirmar que, ao morar só, longe da mãe, "estava enlouquecendo". Cuida de sua irmã mais velha que é, segundo ela, "psicótica grave" e relata que sua irmã mais nova é bem sucedida, casada e com emprego, que a vê muito pouco por ser muito "careta". Atualmente, a paciente está obesa e se alimentando excessivamente de goiabada; afirma que este alimento "tampa um mal que está instalado em sua vida". (Campolina, 2004, p. 24),

"minha cocaína... meu crack..., minha vermelhinha Cica, ...marca Cica é minha marca; minha doçura, que é minha companheira desde quando eu ainda era uma criancinha; que me dá sossego até eu chegar ao banheiro e pô-la para fora... mas é isso que me dá alívio para o meu tormento, o mal que me devora... que devora meu intestino... minha cuca... meu sono... minha carência".

Ana tentou, constantemente, sujar o consultório da analista de alguma maneira, deixando cabelos no assento, farelos de biscoito no chão, não puxando a descarga, afirmando que gosta de deixar um pouco de si nos lugares que vai, que "isso ninguém tira dela". Ademais, passou em dois concursos muito concorridos, porém foi reprovada no Psicotécnico. Sua mãe lhe disse que ficou muito triste com estes resultados e que sua irmã mais velha afirmou que, mesmo sendo "doidona da casa", passou em um concurso e trabalhou por 10 anos no cargo, comentários estes que desestabilizam a paciente (Campolina, 2014).

Portanto, a partir da breve apresentação do caso, a autora relatou que "como pudemos perceber na fala dessa jovem, a comida tem a função de diminuir a dor de existir e de preencher o que podemos nomear de um vazio real, concreto, impossível de recobrir". A relação com sua mãe pôde ser vista como devastadora na vida da paciente, o que a leva a idealizar e demandar um amor infinito, tanto com sua mãe quanto com seus amantes (Campolina, 2014).

A intensidade da relação com a mãe apresentou intensa simbiose entre as duas, o que reforçou que a paciente baseava muito de sua vida emocional nas reações da mãe e influências disso em seus comportamentos. Seu pai foi incapaz de exercer papel de Nome do Pai, impossibilitando, portanto, sua castração e a inserção das regras sociais (Campolina, 2014).

Ademais, a analisanda apresentou fixações na fase oral, com comportamentos alimentares significativos e a "necessidade de encontrar um homem que possa devorá-la". Dessa maneira, observou-se dificuldade na construção da transferência, visto que "está claro que a paciente busca uma relação para ser devorada, pois essa posição a localiza, ou seja, seu gozo é ser devorada e devorar, surgindo daí a *erotomania mortífera*"; no entanto, o papel da analista neste momento é o de Outro, de alteridade radical, que deve contrariar a paciente e sua posição de gozo infinito (Campolina, 2014).

Todas as relações da vida do paciente eram imaginárias, portanto coube ao analista impor regras, dizer não ao gozo da devoração e não se oferecer como mais um objeto deste circuito pulsional. Desta maneira, a analisanda teve a necessidade de buscar suprir seu gozo de maneira distinta, para que sua pulsão buscasse outros destinos, não devorando e comendo tudo e

não se permitindo ser devorada; fechando, entretanto, este circuito pulsional com uma inserção do mundo externo e nas regras sociais, que permitissem à paciente a busca por objetos mais específicos e a capacidade de dizer não às coisas e não aceitar qualquer objeto na obtenção de seu gozo (Campolina, 2014).

Atualmente, de acordo com a autora, a paciente apresenta menos conflitos com sua mãe e tem dedicado mais tempo aos estudos; tem conseguido, progressivamente, reduzir seu gozo mortífero. O cargo de um possível concurso para o qual vem estudando poderá servir de amparo para que a mesma apresente melhor condição psíquica e redução da aflição de vazio, carência e devoração. Este cargo poderá vir a ser um “Nome do Pai”, ainda que precário, para Ana conseguir se organizar, criando assim novos destinos às suas pulsões” (Campolina, 2014).

No caso explicado acima, observou-se a presença do papel dos familiares no tratamento de Ana. Apesar de o desenvolvimento e a manutenção dos sintomas da analisanda estarem relacionados às relações familiares, bem como outras relações de sua vida, faz-se necessário reforçar a importância da presença e participação destas pessoas no processo de compreensão de realidade fantasiosa e a influência do desejo na tomada de consciência dos pacientes em relação aos seus sintomas e o auxílio que os familiares podem promover neste processo, com a participação ativa e preocupação para com o paciente.



[Clique aqui para ouvir](#)

Prática Baseada em Evidências na Psicologia

Com base nos exemplos apresentados, podemos destacar que, apesar das distintas concepções das quatro abordagens em relação ao desenvolvimento dos transtornos alimentares, bem como a intervenção a ser feita, considerando as diferentes visões de homem, sofrimento e adoecimento psíquico, a Psicologia possui alguns consensos no que diz respeito a características presentes nos sintomas dos pacientes acometidos por estes transtornos.

Faz-se possível sugerir que, ainda que os comportamentos alimentares sejam físicos e envolvam modificação corpórea, bem como afetam a saúde física dos indivíduos, as quatro abordagens os compreendem como sendo relacionados a dificuldades emocionais e de sentimentos frutos de adversidades nas relações estabelecidas em suas vidas. Ainda que a maneira de compreender como estas adversidades foram lidadas ao longo do desenvolvimento do indivíduo e seus mecanismos de defesa e construção dos sintomas, é possível inferir que estas abordagens compreendem, em algum nível, que os comportamentos alimentares desregulados, bem como a relação distorcida e não saudável do sujeito com seu corpo, formato corporal e alimentação, são fruto das interações dele com o mundo ao seu redor, em especial com as outras pessoas.

De acordo com a Análise do Comportamento, como já dito anteriormente, muitos comportamentos alimentares desregulados podem ter função de busca por reforçadores anteriormente estabelecidos, também, em suas relações. Para a Gestalt-Terapia, quem adoece nunca é o sujeito, mas as fronteiras de contato que estabelece com os outros indivíduos de sua vida e os comportamentos alimentares desregulados podem ser ajustamentos criativos disfuncionais para as condições disfuncionais destas relações.

Já para a Terapia Cognitivo-Comportamental, os transtornos alimentares podem ser consequências da percepção e dos pensamentos distorcidos que o indivíduo desenvolve em relação ao seu corpo, peso e formato corporal e a busca pelo controle disso e das relações que estabelece. Por fim, no que diz respeito à Psicanálise, estes comportamentos podem ser tentativas falhas de preenchimento de vazios e dificuldade de lidar com a falta, bem como pouca compreensão e aceitação do desejo, o que leva este sujeito a conflitos com seu Superego. Além disso, estes pacientes podem apresentar dificuldades na busca por uma construção identitária na relação com os outros e o Outro de sua vida.

Desta maneira, o objetivo das terapias psicológicas para o tratamento dos transtornos alimentares e para a diminuição do sofrimento ocasionado pelas dificuldades relacionais do sujeito com seu corpo e sua alimentação, nestas abordagens, possui concordância, ainda que se tratem de concepções distintas.

Para a Análise do Comportamento, o autoconhecimento que deve-se buscar ao longo do tratamento, de maneira a levar o terapeuta a aprender as contingências que mantêm seus comportamentos, bem como as consequências que lhe sejam reforçadoras ou punitivas, é,

também, o momento de conhecimento destas relações e suas interferências em sua vida e sintomas. Já para a Gestalt-Terapia, para que o cliente consiga parar de realizar tais comportamentos e, portanto, estabelecer ajustamentos criativos funcionais, mesmo para condições disfuncionais, ele deve desenvolver *awareness* em relação à estas condições e sua relação com seu tempo e espaço, de maneira a se conhecer.

A Terapia Cognitivo-Comportamental compreende que deve-se buscar conhecer os pensamentos distorcidos que o indivíduo tem em relação ao seu corpo e compreender, também, quais são seus pensamentos sobre seus comportamentos compulsivos e purgativos, de maneira a levá-lo a apreender mais sobre suas crenças e influência delas em seus sintomas e seu sofrimento. Por fim, para a Psicanálise, a tomada de consciência que o paciente deve estabelecer no momento em que entra em contato com seus conteúdos recalcados e a influência destes em seus sintomas é o momento em que o indivíduo entra, de fato, em análise e se faz possível a compreensão de tais características relacionais de sua vida.

Para que seja possível introduzir o tema da Prática Baseada em Evidências na Psicologia e no tratamento dos transtornos alimentares, é necessário, inicialmente, abordar o conceito da Prática Baseada em Evidências no mundo médico, onde foi inicialmente desenvolvida.

A PBE foi desenvolvida na década de noventa no campo da Medicina, com o intuito de basear as práticas médicas em evidências científicas para que fossem garantidos o melhor tratamento e intervenção para cada doença, além da economia de recursos e organização da atuação médica. O objetivo dessa prática é o de garantir a qualidade dos serviços prestados aos diversos pacientes, empenho na proteção dos direitos dos consumidores e interesse dos planos de saúde em maximizar o custo-benefício dos tratamentos prestados aos seus beneficiários (Leonardi & Meyer, 2015).

Segundo Bastos (2002, p. 9), a Medicina Baseada em Evidências tem, como principais anseios, a eficácia, efetividade, eficiência e legitimidade dos tratamentos prestados por médicos.

"esses resultados, padrão-ouro, são obtidos através de ensaios clínicos controlados e servem de eixo de sustentação para o desenvolvimento de guidelines para a boa prática profissional, com legitimidade para serem aceitos como verdadeiros pelos profissionais e constituindo-se em elemento de apoio à decisão diagnóstica e terapêutica".

Recorrendo-se a esta discussão do contexto médico, buscou-se adaptá-la à Psicologia e desenvolver uma atuação psicológica que fosse, portanto, baseada em evidências. No entanto, há uma grande cisão e carência da definição de evidência nesta área da saúde, considerando que seu objeto de estudo é extremamente subjetivo e individualizado (Bastos, 2002).

DeRubeis et al. (2005, p. 175) afirmaram que buscar entender qual abordagem é melhor para todas as queixas clínicas, ou seja, buscar classificar as abordagens psicológicas para tratamento de todas as psicopatologias seria o mesmo que "perguntar se insulina ou antibiótico é melhor, sem saber a condição na qual esses tratamentos serão administrados". Eles ainda fa-

lam sobre a possibilidade de diferentes intervenções produzirem resultados positivos semelhantes, porém por conta de fatores específicos distintos, o que reforça a problematização de buscar evidências específicas para tratamentos diferentes, conduzidos de maneiras diferentes, com indivíduos completamente únicos.

Por conta de todas essas discussões em relação às pesquisas estatísticas sobre as abordagens psicológicas, a APA (2006) publicou o artigo *Evidence-Based Practice in Psychology*, em 2006, sobre a Prática Baseada em Evidências na Psicologia. Nele, compreende-se que a PPBE é a integração das evidências encontradas nas pesquisas disponíveis, com a perícia clínica do profissional da área, e as características culturais e preferências do paciente.

A perícia clínica do psicólogo é essencial no processo de definição de evidências válidas para classificação de intervenções dado que este profissional, para além de praticante e atuante na área clínica, é um cientista e, portanto, possui embasamento teórico para a realização desta perícia. De acordo com a APA (2006), psicólogos são capazes de reconhecer padrões significativos no comportamento de seus clientes, bem como utilizar recursos funcionais, para além de descritivos, na busca por compreender tais padrões. Ademais, são capazes de utilizar seu conhecimento teórico para revisar as conceituações dos casos ao longo do tratamento, buscando evidências que possam confirmar ou desconfirmar sua hipótese diagnóstica, bem como evidências da eficácia (ou falta dela) na redução do sofrimento dos pacientes.

No entanto, deve-se aceitar que tal *expertise* é limitada e, portanto, faz-se necessária a integração dela com as características idiossincráticas de cada paciente, a cultura em que se insere e suas preferências. Valoriza-se, portanto, características específicas do desenvolvimento físico e emocional do paciente, bem como a fase de vida em que se encontra. Para mais, valoriza-se seu gênero, identidade de gênero, cultura, idade, contexto familiar, crença religiosa, orientação sexual, entre outros, visto que estes valores são cruciais na construção da personalidade do indivíduo, bem como sua maneira de se relacionar, atitudes direcionadas ao mundo e aos outros e possíveis psicopatologias (APA, 2006, p. 280):

"O contexto social e ambiental do paciente, incluindo fatores estressores recentes e/ou crônicos, são importantes na formulação do caso e no plano do tratamento. Fatores socioculturais e familiares, classe social, contexto social amplo, realidade econômica e situacional (por exemplo, desemprego, perturbações nas relações familiares, falta de segurança econômica, perdas recentes, preconceitos, status de imigração) causam enorme influência na saúde mental do sujeito, em sua capacidade adaptativa, em sua procura pelo tratamento e em seus recursos psicológicos, sociais e financeiros".

Dentre os principais meios de busca por evidências válidas em intervenções psicológicas, destacam-se a observação clínica do psicólogo e seus estudos de caso; pesquisas etnográficas em saúde pública, que apresentam a disponibilidade, utilização e aceitação dadas aos tratamentos em saúde mental; estudos de intervenções, dado que estes são realizadas em contextos naturais, e não laboratoriais, de tratamento psicológico; ensaios randomizados, visto que

estes ensaios permitem a redução de vieses e providenciam ferramentas mais rigorosas na definição de relações de causa-efeito entre intervenções e seus resultados e, também, meta-análises, considerando que este é um método estatístico efetivo para a agregação de resultados de dois ou mais estudos independentes sobre uma mesma questão de pesquisa e a combinação de seus resultados em uma medida sumária (APA, 2006).

De acordo com Forgany (2015), ao se olhar para o futuro, deve-se buscar modular as melhores intervenções psicológicas e o encontro destas com as necessidades de cada pessoa. Atualmente, existem muitos poucos estudos sistemáticos e testados empiricamente a respeito da união de tratamentos psiquiátricos com tratamentos psicológicos; ainda se vê muitos pacientes recebendo tratamentos e combinações de tratamentos que não possuem validação científica.

Compreende-se, assim sendo, que, independentemente dos resultados obtidos em uma pesquisa a respeito das evidências científicas da qualidade de uma terapia e seus resultados na redução dos sintomas, “a PPBE é caracterizada como um processo individualizado de tomada de decisão clínica que ocorre por meio da integração da melhor evidência científica com a perícia clínica e as idiossincrasias do cliente”. Pode-se concluir que “o acúmulo de evidências empíricas sobre a eficácia de diferentes terapêuticas é insuficiente se não for acompanhado dos princípios teóricos que as fundamentam” (Leonardi & Meyer, 2015, p. 1150).

Assim sendo, o objetivo deve estar baseado em obter dados suficientes para mostrar que a abordagem psicológica estudada traz resultados positivos, quando comparada ao placebo ou a indivíduos que não realizem nenhum acompanhamento ou tratamento psicológico (grupo controle), única e exclusivamente para a validação da abordagem como uma prática efetiva na redução de sofrimento humano (APA, 2006; Leonardi & Meyer, 2015; Bastos, 2002; Schedler, 2010).

É importante ressaltar que a PPBE não pretende rivalizar as abordagens psicológicas nos tratamentos dos transtornos mentais, já que sua busca está na validação de todas elas, contanto que haja evidência de sua eficácia de tratamento, melhora dos sintomas e redução do sofrimento. Portanto, o intuito desta pesquisa não é o de classificar e catalogar a qualidade das intervenções, apenas de reforçar a importância da existência e realização de pesquisas que reforcem a apresentação de evidências da qualidade individual das abordagens no tratamento dos transtornos alimentares (APA, 2006; Leonardi & Meyer, 2015; Bastos, 2002; Schedler, 2010).

Desse modo, compreende-se que o objetivo deste estudo é, também, de apresentar as práticas de quatro abordagens psicológicas para o tratamento de transtornos alimentares, baseando-se em estudos clínicos e as evidências apresentadas neles. Pode-se afirmar que existem diversas maneiras distintas de realizar o tratamento destes transtornos, inclusive por conta da concepção teórica que cada abordagem tem em relação ao desenvolvimento deles, as compreensões

históricas, familiares, sociais e de aprendizagem envolvidas no processo individual e idiosincrático de cada cliente (APA, 2006).

Ainda assim, o intuito é apresentar as diferentes maneiras de realizar o tratamento, para que o assunto seja levado em consideração, discutido nos contextos necessários; ademais, para que este documento sirva de estudo nestes processos e, também, como base para estimular mais estudos na área (APA, 2006).

De acordo com Hilbert et al. (2017), o desenvolvimento e a implementação de diretrizes de Práticas Baseadas em Evidências são passos essenciais na disseminação de tratamentos que possuam resultados empiricamente comprovados. Apesar dos diversos avanços nas pesquisas clínicas em relação ao tratamento de transtornos alimentares, um número muito amplo de literaturas demonstra que muitos pacientes com estes diagnósticos não recebem tratamentos baseados em evidências científicas. Um aumento na pesquisa por estudos clínicos que comprovem a qualidade de tratamentos psicoterápicos é necessário para que haja o oferecimento de orientações úteis e confiáveis no tratamento destes transtornos. Os autores ainda afirmaram que, porque a busca por orientações atualizadas de técnicas é um processo complexo e que demanda muito tempo, recomenda-se o desenvolvimento de diretrizes internacionais padronizadas para tal.

Suporte empírico *versus* Prática Baseada em Evidências

De acordo com Wachholz et al. (2018), o termo “evidências científicas” é empregado como um conjunto de informações que possam ser utilizadas para confirmar ou negar alguma teoria ou hipótese científica. As evidências são resultado de pesquisas e estudos conduzidos com o intuito de esclarecer a relação de causa e efeito entre duas ou mais variáveis, suas diferentes condições e intervenções científicas. No contexto psicológico, de acordo com a APA (2006), compreende-se que uma abordagem, para que possa ser considerada uma Prática Baseada em Evidências, deve apresentar um número específico de evidências; o que constitui a melhor evidência vai depender do objetivo em questão, mas devem-se incluir resultados de diversos métodos nomotéticos e idiográficos (ensaios clínicos randomizados, experimentos de caso único, estudos de caso), para além de uma listagem de tratamentos empiricamente sustentados (Leonardi & Meyer, 2015).

Como afirmou Lohr (2011, pp. 100-101), um problema no contexto de classificação de pesquisas como evidência está na deficiência do que seria uma evidência de boa qualidade; o modelo atual definido pela APA “ampliou o uso deste termo para a inclusão de toda e qualquer forma de crença ou opinião clínica”, o que enfraquece a cientificidade. Considerando a extrema relevância da produção de conhecimento científico no contexto da Psicologia, compreende-se a importância do acúmulo de evidências empíricas que possam servir de suporte empírico para a demonstração da eficácia de diferentes abordagens é insuficiente se isso não for acompanhado de todos os princípios teóricos e éticos determinados pela APA na definição do que seria uma Prática Baseada em Evidências (e.g., Lilienfeld, 2011, Lohr, 2011).

As evidências empíricas são necessárias, mas não suficientes, visto que deve-se considerar, também, se a intervenção funciona (eficácia), se funciona no "mundo real" (efetividade), a que custo ela funciona (eficiência), qual a distribuição de riscos e benefícios para o uso desta abordagem (sem riscos) e se é disponível a todos (equidade) (Wachholz et al., 2018). Desta forma, compreende-se que uma evidência científica pode servir de suporte empírico para a demonstração da eficácia de um tratamento; no entanto, não se pode classificar qualquer suporte empírico como evidência suficiente para a nomeação de uma abordagem como uma Prática Baseada em Evidências, visto que deve-se seguir a orientação da APA em relação a um conjunto de evidências e pesquisas para a denominação de uma abordagem como PBE. Por exemplo, para que haja essa classificação, deve-se apresentar 1) um ou mais ensaios clínicos randomizados conduzidos por diferentes pesquisadores que demonstrem que aquele tratamento é superior a placebo ou a outras intervenções psicoterápicas ou que são equivalentes a outro tratamento estabelecido em estudos estatisticamente significantes realizados anteriormente; (2) nove ou mais experimentos de caso único conduzidos por diferentes pesquisadores que demonstrem que aquele tratamento é superior a placebo ou a outros tratamentos já estabelecidos (Leonardi & Meyer, 2015).

Portanto, vale ressaltar que os artigos encontrados e apresentados nos resultados desta pesquisa podem ser definidos como exemplos de suporte empírico da eficácia do tratamento disponibilizado pela abordagem psicológica, mas não é dado suficiente para a classificação destas abordagens como Práticas Baseadas em Evidências.

Evidências de eficácia das distintas abordagens psicológicas no tratamento dos TAs

Um estudo conduzido por Maat et al. (2009) foi realizado a partir de uma pesquisa sistemática da literatura de 1970 a 2007, na busca pelos resultados obtidos nos tratamentos psicológicos realizados com intervenções psicodinâmicas. Foram estudadas 27 pesquisas, que tiveram seus resultados separados entre redução de sintomas e mudança de personalidade e opinião do terapeuta e do paciente. Em sua conclusão, afirmou-se que o tratamento psicodinâmico de longo prazo é uma modalidade de tratamento efetiva, com efeitos moderados a intensos, tanto no que concerne a redução de sintomas quanto na mudança de comportamento. Os efeitos foram mais intensos na redução de sintomas, mas mudanças moderadas em personalidade podem ser clinicamente significativas em termos de qualidade de vida e prevenção de recaídas. Pacientes e terapeutas não apresentaram divergências de opinião em relação ao sucesso do tratamento, além de os resultados do tratamento terem sido mantidos mesmo anos após o término do processo.

Leichsenring et al. (2014) encontraram, em sua pesquisa, que o tratamento psicodinâmico possui evidências efetivas no que diz respeito ao tratamento da maioria dos transtornos mentais.

Uma meta-análise de estudos baseados no tratamento de transtornos alimentares, realizada por Linardon et al. (2018), concluiu que os vinte e quatro estudos observados (dos quais, treze foram estudos randomizados controlados) trouxeram significativos efeitos nos tratamentos realizados, indicando eficácia de abordagens da terceira onda comportamental na redução de comportamentos de comer desordenados e na melhora de sintomas relacionados à distorção de imagem dos pacientes.

Apesar de a psicoterapia ser compreendida como parte do tratamento em diversas diretrizes, apenas sete delas recomendaram intervenções psicológicas específicas. Todas as sete recomendaram terapia familiar, em especial quando se referiam a pacientes adolescentes. Para psicoterapia individual, a maioria das diretrizes recomendaram Terapia Cognitivo-Comportamental, que é apresentada como uma terapia com maior enfoque nos sintomas e na modificação de comportamentos e pensamentos disfuncionais que fazem com que o transtorno se mantenha (Linardon et al., 2018).

Houve menos consenso em relação à recomendação de terapias psicodinâmicas, o que pode vir a ser uma demonstração das consequências de um número menor de pesquisas científicas que apresentem evidências e eficácia de tratamento de transtornos mentais realizados com as abordagens psicodinâmicas, entre elas, a Psicanálise (Linardon et al., 2018).

De acordo com Scorsolini-Comin e Santos (2012, p. 854), hoje em dia, observa-se uma priorização de psicoterapias breves para o tratamento de TAs, independentemente da abordagem teórica utilizada, visto que se faz comum a busca por vias mais rápidas de tratamentos. Os objetivos dessas psicoterapias são “solucionar o problema (ou parte dele), reduzir os sintomas e promover um aumento global da qualidade de vida do paciente”. Nesta pesquisa, o esquema de tratamento com 15 sessões de psicoterapia breve foi aplicado como abordagem psicoterapêutica em alguns estudos sobre TA e apresentou boa eficácia.

Teriato (2009) reforçou a necessidade de se realizar uma intervenção mais eficaz durante a fase inicial do tratamento de TAs com adolescentes, momento em que os sintomas podem fornecer pistas sobre a jornada de desenvolvimento do jovem paciente. Selecionando aquelas contribuições clínicas que se relacionam com o aparecimento dos TA como uma psicopatologia da identidade, o autor sugere que é importante concentrar-se nas fases do processo terapêutico que são cruciais na construção de um espaço de intimidade e aproximação com os conteúdos internos, o que pode ser utilizado pelo adolescente para crescer e descobrir-se a si mesmo.

Fassino, Amianto e Ferrero (2008), Bruno, Rosani e Berlincioni (2009) e Lewis, Dennerstein e Gibbs (2008) realizaram estudos a partir do uso de um enfoque psicanalítico na condução das intervenções com TAs e apresentam resultados positivos com pessoas em diferentes estágios do tratamento. Já Rutherford e Couturier (2007) apresentaram, em sua pesquisa, evidências de que os modelos de terapia familiar são mais eficazes para o tratamento de adolescen-

tes com AN, enquanto que os modelos de Terapia Cognitivo Comportamental, para pacientes diagnosticadas com BN.

De acordo com Hetherington e Rolls (2001), recentes estudos demonstraram eficácia na Terapia Cognitivo-Comportamental no tratamento de Bulimia Nervosa, baseando-se no entendimento de que mudanças em comportamentos alimentares desregulados não se persistem se não houver, também, mudanças nos comportamentos cognitivos envolvidos.

No que diz respeito às abordagens psicodinâmicas, em uma pesquisa realizada por Le Grange et al. (2007), concluiu-se que a Terapia Familiar Sistêmica apresentou melhores resultados clínica e estatisticamente nos componentes comportamentais e atitudinais dos pacientes, quando comparada à Psicoterapia de Apoio, tanto no pós-teste, quanto no *follow-up* (de seis meses). A redução dos sintomas bulímicos ocorreu, também, de maneira mais rápida nos pacientes que realizaram a TFS.

A pesquisa realizada por Mussell et al. (1999) teve como amostra 500 psicólogos, escolhidos de maneira randômica e o objetivo de avaliar quais técnicas e abordagens psicológicas são mais utilizadas no tratamento de transtornos alimentares. Conclui-se que a abordagem mais utilizada foi a TCC (38,8%), seguida da opção "ecletica" (28,3%), "outras" (13,3%), sistêmica (10%), psicodinâmicas (5%), IPT (3,3%) e narrativa (1,7%).

Setenta por cento dos entrevistados indicaram utilizar técnicas psicoterápicas empiricamente comprovadas em suas atuações, no que diz respeito ao tratamento de transtornos alimentares. Em relação aos participantes que responderam não utilizar estas técnicas, suas justificativas foram a falta de treinamento (62,5%), a incerteza de onde procurar tal estudo (23,1%) e, por fim, a inconsistência deste tipo de técnica com seu próprio estilo psicoterapêutico (23,1%). Além disso, 73,3% dos entrevistados afirmaram existir uma carência de treinamento em relação às técnicas baseadas em evidências ao longo do curso de formação em Psicologia e, também, cursos de formação posterior.

A maioria dos entrevistados indicou um desejo por maiores treinamentos em relação ao uso de técnicas baseadas em evidências. Portanto, os resultados mostram que, apesar das evidências positivas em relação ao uso de técnicas baseadas em evidências, em especial a Terapia Cognitivo Comportamental, no tratamento de transtornos alimentares, um número muito pequeno dos psicólogos entrevistados afirmou ter recebido treinamentos específicos nesta área. Todos os dados obtidos nesta pesquisa corroboram com a compreensão de que existe pequeno investimento no desenvolvimento de técnicas baseadas em evidências na formação de psicólogos e no tratamento de transtornos alimentares.

YOUTUBE

MÁRCIO MOREIRA



AULAS, CONCEITOS E MUITO MAIS...

CONTEÚDOS EXCLUSIVOS

[Clique aqui para acessar](#)

Justificativa, objetivo procedimentos de elaboração deste livro

Como dito anteriormente, a discussão sobre a Prática Baseada em Evidências está em crescimento no âmbito do tratamento psicológico de diversos transtornos. No entanto, é possível observar, também, que as meta-análises e revisões bibliográficas que abordam os resultados de uma intervenção que possam servir de suporte empírico da eficácia dos tratamentos psicológicos de transtornos alimentares foram escritas e publicadas, majoritariamente, na língua inglesa. Além disso, também parece não haver muitos manuais ou textos que possam servir de diretriz e embasamento para psicólogos no atendimento de pacientes diagnosticados com transtornos alimentares na língua portuguesa.

O objetivo deste trabalho é apresentar pesquisas realizadas com o uso de ensaios randomizados e/ou estudos de caso que sirvam de suporte empírico da eficácia dos tratamentos psicológicos de transtornos alimentares com as abordagens Análise do Comportamento, Gestalt Terapia, Terapia Cognitivo-Comportamental e Psicanálise.

Para isso, buscou-se explicar o que é o estudo das Práticas Baseadas em Evidências no contexto da Psicologia e nos estudos referentes aos transtornos alimentares, com a diferenciação deste estudo e da classificação de artigos como suporte empírico. Além disso, apresentou-se a compreensão teórica das quatro abordagens a respeito do desenvolvimento e manutenção dos sintomas anoréxicos e bulímicos.

Posteriormente, foram apresentados estudos de caso e estudos clínicos que exemplificam tratamentos psicológicos destes transtornos em quatro abordagens da Psicologia e evidenciem sua eficácia. Estes documentos foram traduzidos e foi apresentada uma sistematização do processo em que estas intervenções foram realizadas.

Procedimento

Para a realização da pesquisa foram selecionados artigos que abordam diferentes intervenções psicológicas para o tratamento de transtornos alimentares e que apresentam evidências de sua eficácia, com o intuito de analisar as melhores opções de tratamento e técnicas até então pesquisadas e publicadas.

Seleção das meta-análises e revisões bibliográficas

A seleção destes artigos ocorreu de acordo com alguns critérios e foi realizada a partir da busca na plataforma do Google Acadêmico. Foram utilizados os seguintes termos para a pesquisa na plataforma: a) evidence-based/psychological/treatment/eating disorders/systematic review/meta analysis; b) psychology/treatment/eating disorders/ systematic review/meta analysis e c) evidence/eating disorders/psychology/systematic review/meta analysis.

Inclusão e exclusão

Dentre as meta-análises e revisões bibliográficas encontradas, foram incluídas aquelas apresentadas nas primeiras três páginas do Google Acadêmico e foram lidos o título e o resumo para que fossem mantidas apenas as que apresentavam pesquisas com evidências do tratamento psicológico de transtornos alimentares, excluindo-se, portanto, pesquisas sobre o tratamento médico, por exemplo. Além disso, também foi considerado o ano de publicação das pesquisas, com a tentativa de exclusão de todas aquelas postadas há mais de dez anos, ainda que, por conta do número limitado dessas pesquisas em algumas abordagens, isso não foi possível.

Seleção de artigos

Para a seleção dos artigos apresentados nas meta-análises e revisões bibliográficas, foi realizada 1) a escolha de três artigos para cada abordagem apresentada anteriormente e foi considerada, também, 2) a recência deles, com a inclusão dos três mais recentes. Ademais, também foi considerada a 3) variedade de técnicas utilizadas, com o intuito de se analisar o número mais variado possível de técnicas para cada abordagem.

Extração das informações

Após a seleção dos artigos, foram extraídas informações cruciais para a compreensão do processo da intervenção, incluindo:

1. Número de participantes das pesquisas;
2. Diagnóstico do transtorno que estes possuam;
3. História de vida e anamnese, se os artigos eram estudos de caso;
4. Duração do tratamento e o número de sessões,
5. Técnicas que foram utilizadas pelo terapeuta, sejam estas verbais, que incluem as características das perguntas e respostas dadas pelo terapeuta às falas do paciente, ou práticas, que incluem a aplicação de técnicas e atividades práticas realizadas ao longo das sessões, bem como o uso ou não de deveres de casa, por exemplo;
6. Existência ou não de um tratamento multidisciplinar, ou seja, avaliar se os pacientes que participaram das pesquisas apresentadas nos artigos fizeram, conjuntamente ao tratamento psicológico, outros tratamentos de saúde, sejam estes psiquiátricos, endócrinos, entre outros.

Tradução dos artigos

É importante ressaltar que, visto que todos os artigos que foram selecionados estavam escritos na língua inglesa, foi realizada a tradução desses documentos para a língua portuguesa, com o intuito de fazê-los acessíveis aos profissionais brasileiros e permitir que haja implementação dos tratamentos que apresentam maiores evidências científicas no Brasil. Esta tradução foi feita pela pesquisadora.

Sistematização das informações

Por fim, também foi realizada a organização dos artigos e das informações extraídas, com definição de duração de tratamento, técnicas e respostas utilizadas e uso de tratamentos multidisciplinares. O intuito foi o de permitir que a informação fosse sintetizada e apresentada de forma didática, podendo servir de estudo para implementação de tais práticas na intervenção com pacientes anoréxicos e/ou bulímicos.

Cronograma

A pesquisa e sistematização de todas as meta-análises e revisões bibliográficas ocorreu durante o período de quatro meses, com início no mês de Agosto de 2022 e término ao final do mês de Novembro de 2022. O momento inicial de seleção das meta-análises e revisões bibliográficas e classificação dos artigos no Google Acadêmico teve duração aproximada de um mês, até o final do mês de Agosto ou meados de Setembro de 2022.

Posteriormente, foram selecionadas e extraídas as informações citadas acima e foi realizada sua tradução, durante o período aproximado de um mês, até o meio do mês de Outubro. Por fim, foi realizada a organização das informações encontradas, a discussão e conclusão do trabalho, que ocorreu até o início do mês de Novembro.



WALDEN4.COM.BR

IW4 CURSOS

Estude on-line com vídeos, textos e exercícios sobre
Análise do Comportamento

www.waden4.com.br

Suporte empírico: Análise do Comportamento

A busca por artigos que apresentem evidências científicas na Análise do Comportamento trouxe uma interessante reflexão, visto que estes resultados foram limitados, em sua maioria, às abordagens da terceira onda de tratamento behaviorista como, por exemplo, a Terapia de Aceitação e Compromisso e a Análise do Comportamento Dialética. Estas abordagens, no entanto, não são compreendidas, de forma unânime, como parte da Análise do Comportamento. Desta maneira, serão explicitadas especificamente quais abordagens foram utilizadas nas pesquisas, ainda que estejam englobadas no título 'Análise do Comportamento'.

Suporte Empírico 1

O primeiro artigo apresentado foi selecionado pelas referências da Meta Análise "The empirical status of the third-wave behaviour treatment of eating disorders: a systematic review" de Linardon et al. (2017), e está titulado de "A controlled trial of cognitive-behavioural and behavioural treatment of anorexia nervosa" de Juarascio et al. (2013).

Na pesquisa realizada por Juarascio et al. (2013), 111 pessoas diagnosticadas com transtornos alimentares participaram e foram divididas em dois grupos; o primeiro recebeu tratamento em uma clínica para cuidados de pacientes com TAs e o segundo recebeu este mesmo tratamento acompanhado de duas sessões semanais de Terapia de Aceitação e Compromisso com profissionais da área.

O tratamento nesta clínica é baseado na regulação da alimentação dos pacientes, estabilização de padrões alimentares, aumento de peso e eliminação de comportamentos compensatórios. A orientação teórica do programa é eclética e inclui componentes psicodinâmicos, cognitivo-comportamentais e feministas. Estes pacientes participavam deste grupo sete dias da semana em sessões de 60 a 75 minutos.

Já o segundo grupo, para além dos procedimentos citados acima, receberam o acréscimo de atendimentos com a ACT, mais atividades focadas em sintomas específicos de transtornos alimentares e outras, focadas em sintomas depressivos e ansiosos. Os terapeutas haviam trabalhado na clínica por, pelo menos, um ano antes do experimento e foram eles que criaram o manual de tratamento que os pacientes receberam, além de seguir *checklists* com o intuito de garantir adesão. A adesão também era analisada através de supervisões semanais.

Nos resultados, 20 dos 52 pacientes atendidos pela ACT tiveram seus sintomas classificados na faixa normativa no pós-teste. Além disso, 18% dos pacientes atendidos apenas pelo tratamento da clínica tiveram maiores chances de serem hospitalizados novamente, sugerindo menor manutenção dos ganhos do tratamento, quando comparado com o tratamento de ACT. Ainda que os resultados tenham sido pequenos, pode-se observar, portanto, que este aumento do números de atendimentos com a ACT apresentou padrão consistente de redução de sinto-

mas patológicos do transtorno, além da redução da possibilidade de retorno à hospitalização nos pacientes que participaram do *follow-up* de seis meses.

Suporte empírico 2

O segundo suporte empírico de tratamento analítico comportamental de transtornos alimentares é o artigo "A systematic review of dialectical behavior therapy for the treatment of eating disorders", de Bankoff et al. (2012), selecionado nas referências da Meta-Análise "Dialectical Behavior Therapy for Binge Eating Disorder", de Telch e Agras (2001).

Nesta pesquisa, os pacientes realizaram sessões semanais de 2h no período de 20 semanas com duas psicólogas. As primeiras duas sessões foram realizadas no intuito de apresentar os objetivos do tratamento, com apresentação verbal e escrita dos mesmos. As terceira, quarta, quinta e sexta sessões tiveram o objetivo de desenvolver estratégias de *mindfulness*. Nas sessões 7-12, estratégias de regulação emocional e, nas sessões 13-18, aumento das habilidades dos pacientes para lidar com a frustração. As duas últimas sessões concentraram uma revisão das habilidades e estratégias aprendidas e cada grupo construiu um plano individualizado para manutenção desta prática na regulação de emoções e evitação de comportamentos alimentares compulsivos.

O objetivo das habilidades de *mindfulness* foi o de auxiliar os pacientes a aumentar a capacidade de observar e descrever suas experiências, pensamentos e intenções comportamentais sem julgamentos e no momento presente. A regulação de emoções buscou ensiná-los a entender suas emoções e diminuir a vulnerabilidade à emoções negativas, bem como aumentar a frequência de emoções positivas. O aumento da tolerância à frustração teve o intuito de auxiliar os pacientes a encontrar maneiras de lidar com estresses e dores inevitáveis da vida ao incluir estratégias de facilitação da aceitação da realidade.

Todas as sessões foram gravadas e, se um paciente faltava à sessão, ele era instruído a escutar a gravação para se preparar para a próxima sessão. Os resultados apresentaram que as habilidades desenvolvidas ao longo do treinamento comportamental dialético levaram os pacientes a diminuir seus comportamentos alimentares compulsivos. Além disso, 89% dos participantes do grupo de TCD pararam de realizar estes comportamentos em, pelo menos, quatro semanas antes do término do tratamento. No entanto, esta percentagem de abstinência dos comportamentos foi reduzida para 56% nos seis meses de *follow-up*.

Os autores afirmaram que não está exatamente claro como o tratamento reduziu os sintomas e, porque não houve comparação com outro tipo de tratamento neste estudo, não é possível afirmar que os efeitos foram resultado de características específicas do tratamento comportamental dialético. Desta maneira, este estudo foi capaz de comprovar a eficácia da abordagem na redução dos sintomas, apenas quando comparado ao grupo controle.

Suporte empírico 3

O terceiro artigo que apresenta evidências científicas da eficácia do tratamento comportamental dialético de transtornos alimentares é o “Dialectical Behavior Therapy for Bulimia Nervosa”, de Safer et al. (2001), selecionado nas referências da Meta-Análise “The empirical status of the third-wave behaviour therapies for the treatment of eating disorders: A systematic review” de Linardon et al. (2017).

Esta pesquisa aplicou a abordagem em trinta e uma pacientes mulheres diagnosticadas com Bulimia Nervosa com o total de 20 sessões de 50 minutos semanais. O objetivo principal da terapia foi o de desenvolver habilidades de regulação emocional para diminuição dos sintomas compulsivos e compensatórios. Os autores afirmaram que a Terapia Comportamental Dialética compreende que os sintomas bulímicos são realizados com o intuito de influenciar, modificar e controlar estados emocionais dolorosos. Desta maneira, o foco no tratamento é o de aumentar o repertório comportamental dos pacientes para que os mesmos substituam seus comportamentos disfuncionais por outros com funções e consequências reforçadoras ao indivíduo, a curto e longo prazo. Três pacientes não concluíram o tratamento ao final da pesquisa.

Os resultados após 20 semanas de pesquisa apresentaram fim dos comportamentos compulsivos e purgativos em quatro pacientes; cinco participantes ainda apresentavam alguns destes comportamentos, porém com uma redução significativa de 88% dos compulsivos e 89% dos purgativos. No entanto, cinco participantes mantiveram o transtorno, de acordo com os critérios do DSM-V.



aprendizagem

AUTISMO TEA ABA

Profissionais capacitados
e experientes. Venha
conhecer nossos
serviços.

Instituto Walden4 - ABA & TEA

[Clique aqui para conhecer mais](#)

Suporte empírico: Gestalt Terapia

O número de pesquisas encontradas que apresentam evidências científicas do tratamento de transtornos alimentares com a Gestalt Terapia foi praticamente nulo. As palavras utilizadas na pesquisa no Google Acadêmico foram todas as citadas no procedimento do trabalho, além de a) gestalt therapy/systematic review/experimental trial; b) gestalt therapy/evidence/treatment/eating disorders; c) eating disorders/treatment/gestalt therapy/evidence; d) anorexia nervosa/treatment/gestalt therapy; e) bulimia nervosa/treatment/gestalt therapy; f) eating disorders/experimental trial/gestalt therapy; g) systematic review/gestalt therapy/eating disorders, e outras variações deste tipo de pesquisa.

Os artigos foram procurados nas primeiras três páginas do Google Acadêmico em cada uma destas pesquisas. Os únicos artigos encontrados foram aqueles que apresentavam a teoria da abordagem humanista na compreensão do desenvolvimento de tais transtornos. No entanto, não foi encontrado nenhum artigo que apresentasse pesquisas sobre o tratamento de transtornos alimentares realizadas com o uso de ensaios randomizados com a Gestalt Terapia.

É necessário reforçar a compreensão de que, ainda que não tenhamos encontrado artigos que apresentem estas evidências, isto não significa que estes artigos não existam, apenas que o procedimento seguido e citado acima não foi suficiente para encontrar estes documentos. Desta maneira, conclui-se que este pode ser um dado que demonstre pouco interesse desta abordagem na realização de pesquisas randomizadas na busca por evidências científicas do tratamento gestáltico. A única revisão bibliográfica encontrada que discute a presença de evidências científicas da Gestalt Terapia foi a "Gestalt Therapy Effectiveness: A Systematic Review of Empirical Evidence", de Raffagnino (2019); no entanto, nada sobre transtornos alimentares foi discutido ou apresentado nesta revisão.

Desta forma, fez-se necessário incluir, nos resultados desta abordagem, dois estudos de caso de tratamento de transtornos alimentares, encontrados no Capítulo 9, nomeado de "Transtornos alimentares na clínica gestáltica", do livro "Quadros disfuncionais e Gestalt-terapia", de Frazão e Fukumitsu (2017).

Suporte empírico 1

O primeiro estudo de caso apresentado no capítulo citado acima é o de Marina (nome fictício), paciente diagnosticada com Anorexia Nervosa. De acordo com as autoras, a paciente chegou ao consultório em janeiro de 2013 com 35 anos, 1,71 cm de altura e 42 quilos. Magra, pálida e assustada, Marina apresenta sintomas anoréxicos desde os 17 anos, tendo realizado diversos tratamentos nutricionais, homeopáticos e psicológicos desde então. Ela reconhece seu diagnóstico. Mora com seu namorado, mais velho que ela e seus pais, apesar de casados, moram em estados diferentes; ela tem uma irmã mais velha (Frazão & Fukumitsu, 2017).

Além do transtorno, Marina apresenta distorção de imagem corporal e alucinação auditiva, com falas relacionadas à alimentação, típicas da Anorexia: comidas boas, más, permitidas, proibidas, especificações de quantidades, entre outras. Frequentava academia de segunda a sexta-feira e era muito elogiada pelos professores, que a incentivavam a manter o peso e a forma corporal. Alimentava-se à base de frutas e legumes, raramente saindo da rotina alimentar. Quando comia fora, não se permitia ultrapassar 170 gramas. Marina tinha medo da comida e não tinha coragem de comer muitas coisas que comia antes de desenvolver o transtorno (Frazão & Fukumitsu, 2017).

Engordar lhe causava pânico e, apesar de extremamente magra, via-se muito gorda quando olhava no espelho. Possuía regras quanto ao tamanho de seu corpo, as coxas não podiam se encostar, o braço (bíceps) deveria ser medido com a mão de maneira que o dedo indicador encostasse no polegar (Frazão & Fukumitsu, 2017).

O terapeuta teve o foco inicial de compreender que Marina era um todo e que a Anorexia fazia parte desse todo; uma parte muito grande e relevante, porém apenas uma parte. Ao longo do processo terapêutico, Marina foi capaz de observar sua incapacidade de impor limites ao transtorno, percebeu que havia se perdido e abandonado as coisas com as quais sentia prazer. Em nenhum momento, no entanto, o foco do tratamento foi a Anorexia, ainda que estivessem diante de um real risco de morte. Portanto, o terapeuta tinha consciência de que era necessário que algumas mudanças imediatas e concretas fossem realizadas nos hábitos alimentares de Marina para que este risco fosse diminuído (Frazão & Fukumitsu, 2017).

Ao atender pacientes com transtornos alimentares, é preciso ir além do que é o transtorno e compreender como ele é, um sintoma, a “ponta do iceberg”. Ao acompanhar Marina, o terapeuta foi capaz de perceber aspectos nos relacionamentos familiares com o pai, mãe e irmã, que precisavam ser trabalhados, aspectos no trabalho e no namoro que representavam a forma de ser e se posicionar, de impor limites e de se destacar. Os comportamentos alimentares desregulados e o excesso de exercícios físicos a protegiam de ver a vida que levava, já que grande parte de seu tempo era ocupado por estas preocupações (Frazão & Fukumitsu, 2017, pp. 143).

À medida que o tratamento foi sendo realizado, Marina foi desenvolvendo capacidade para olhar para estas relações e sua maneira de estar no mundo, sua forma de se relacionar com os outros, cheia de regras, assim como sua relação com a alimentação. Por diversas vezes foi capaz de observar que seu corpo de menina contextualizava seu comportamento de menina. Encarar o prato de comida e inserir, lentamente, outros alimentos foram alguns dos processos pelos quais Marina passou ao longo da terapia (Frazão & Fukumitsu, 2017).

As autoras reforçam a importância de se ter a sensibilidade e o cuidado para não minimizar o problema, mas contextualizá-lo com as diversas figuras e o fundo que as representa na vida de cada paciente (Frazão & Fukumitsu, 2017).

Suporte empírico 2

O segundo estudo de caso apresentado no texto é o de uma paciente diagnosticada com Bulimia Nervosa. Helena (nome fictício) tem 26 anos e afirmou ter começado a apresentar os sintomas com 21 anos, com episódios compulsivos e comportamentos purgativos de vômito. Afirmou não ter controle de seu comportamento de comer; quando começa, não consegue parar, até o momento em que não cabe 'mais nada'. Após provocar o vômito, sente-se mal e culpada, lhe parece um ciclo sem fim (Frazão & Fukumitsu, 2017).

A terapeuta, ao olhar para a vida da paciente para além da bulimia, observa que ela havia perdido sua única irmã, cinco anos mais nova, de uma doença genética crônica sem cura; poucos meses antes, havia perdido sua avó, uma das pessoas mais importantes de sua vida. O sintoma está presente *neste momento*. Em uma das sessões, a paciente relata que teve uma crise de compulsão “do nada”, apesar de que, em terapia, recordou-se de que havia recebido, naquele dia, a notícia de que um familiar com planejamento suicida. Foi capaz de perceber que um sentimento que estava negando para si, uma raiva desse familiar que “escolhe tirar a vida enquanto outros a perderam sem querer, outro que queriam viver tanto” (Frazão & Fukumitsu, 2017, p. 145).

Desta forma, destaca-se a relevância da ampliação de *awareness* dos sentimentos que envolvem os acontecimentos da vida da paciente e compreender a influência deles nos processos de comportamentos compulsivos e purgativos. “Se, no paciente com anorexia, o tempo é um fator importante, no caso da bulimia, o próprio funcionamento do transtorno nos possibilita trabalhar sem o risco iminente de morte”. A bulimia pode ser uma metáfora, ao comer comida, busca ‘matar’ sua fome de relação, de pertencimento nas relações de sua vida (Frazão & Fukumitsu, 2017, p. 145).

As autoras afirmaram que é preciso ampliar o foco do tratamento para o contexto da paciente ao seu mundo externo, ao observar o que de fato está ocorrendo em sua vida, percebe-se que o sintoma está encobrindo algo e o papel do terapia é possibilitar a descoberta de novas formas de lidar com suas relações e, conseqüentemente, com a sua alimentação.



WWW.WALDEN4.COM.BR

iW4 Livros

Leia livros on-line sobre Análise do Comportamento
publicados pela Editora do Instituto Walden4

[Clique aqui para conhecer mais](#)

Suporte empírico: Terapia Cognitivo-Comportamental

A seguir, serão apresentados artigos que apresentam suporte empírico do tratamento cognitivo-comportamental de transtornos alimentares. Os dois primeiros artigos selecionados foram encontrados nas referências bibliográficas da meta-análise “The Efficacy of Cognitive-Behavioral Therapy for Eating Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis” e se chamam “Pharmacologic and cognitive-behavioral treatment for bulimia nervosa: A controlled comparison” e “Cognitive-behavioral and response-prevention treatments for bulimia nervosa”. Já o terceiro artigo utilizado para análise de eficácia de tratamento cognitivo-comportamental foi o mesmo analisado posteriormente, sobre o tratamento psicanalítico, de Poulsen et al. (2014), visto que a pesquisa analisou a diferença nos resultados dos tratamentos com a TCC e a Psicanálise.

Suporte empírico 1

Na pesquisa realizada por Agras et al. (1989), o procedimento terapêutico foi pautado na observação e monitoramento da quantidade de comida ingerida, de comportamentos compulsivos e comportamentos purgativos dos pacientes diagnosticados com Bulimia Nervosa. Estes pacientes passaram por quatorze sessões de uma hora no período de quatro meses. Os terapeutas eram todos doutores especializados no tratamento de Bulimia. Além disso, os terapeutas receberam supervisão semanal. Dos 77 participantes iniciais, 10 abandonaram o tratamento ao longo do experimento e os outros 67 foram divididos em três grupos, sendo o segundo o grupo que recebeu Tratamento Cognitivo-Comportamental.

O primeiro ficou responsável por realizar o automonitoramento de comportamentos compulsivos e purgativos, o segundo, além de receber psicoeducação a respeito dos comportamentos compulsivos gerados pelo hábito de fazer dietas, os pacientes também foram instruídos a manter um automonitoramento de seus comportamentos; este tratamento também teve como objetivo auxiliar os participantes a realizarem três refeições diárias, buscando, ao longo do tratamento, aumentar a variedade de alimentos ingeridos, o que pode permitir a análise da diferença destes dois grupos, visto que o segundo teve intenção de aumentar não só a consciência dos pacientes a respeito de seus comportamentos, mas aumentar o repertório comportamental destes. Por fim, o terceiro grupo recebeu um treinamento de dessensibilização sistemática, no qual se alimentaram com as comidas que costumavam levá-los a comportamentos purgativos, para que pudessem, juntamente com o terapeuta, aumentar sua conscientização a respeito dos sentimentos que eliciaram e as contingências que os levaram a tal comportamento; depois que aumentaram a confiança no treinamento, foram instruídos a fazer isto em casa.

Os principais objetivos da terapia Cognitivo-Comportamental foram os de auxiliar o paciente a realizar, pelo menos, três refeições diárias, aumentar a quantidade de comida ingerida ao longo do dia, em especial no início do dia, assim como a variedade de alimentos ingeridos e a

inserção de alimentos dos quais os pacientes tivessem aversão. Outra parte do tratamento incluiu a educação a respeito do transtorno alimentar (psicoeducação) e reconstrução cognitiva das crenças a respeito da alimentação e imagem corporal. Ao final do tratamento, os pacientes também passaram por treinamento de atividades distintas para evitar casos de relapso ao buscar diferentes maneiras de enfrentamento.

Os resultados confirmaram a eficiência do tratamento cognitivo-comportamental no tratamento de Bulimia, visto que 77% dos participantes reduziram seus comportamentos purgativos e 56% pararam completamente os comportamentos alimentares compulsivos. Os resultados foram muito melhores nos participantes que receberam tratamento do que aqueles que apenas realizaram automonitoramento de seus comportamentos.

Adicionalmente, estes pacientes também demonstraram melhora significativa de sintomas de outras psicopatologias, como depressão, preocupação excessiva com alimentação e maturidade nas relações interpessoais.

Suporte empírico 2

Em outra pesquisa realizada por Agras et al. (1992), 71 participantes diagnosticados com Bulimia Nervosa foram divididos em cinco grupos. Cada grupo recebeu um tipo diferente de tratamento; dois receberam apenas tratamento medicamentoso, porém com diferença de duração (16 e 24 semanas), outros dois receberam tratamento medicamentoso e psicoterápico (16 e 24 semanas), com a abordagem cognitivo-comportamental, e um quinto grupo recebeu apenas tratamento psicoterápico.

No que se refere ao tratamento cognitivo-comportamental, os participantes realizaram sessões individuais e semanais de terapia, com duração de cinquenta minutos. Os psicólogos que realizaram o tratamento eram todos doutores e já atendiam pacientes bulímicos há, pelo menos, cinco anos. O procedimento do tratamento foi o de automonitoramento da quantidade de comida ingerida, episódios compulsivos e comportamentos purgativos. Além disso, no início do tratamento, o objetivo principal era garantir que os pacientes realizassem três ou mais refeições balanceadas por dia. Estes também eram encorajados a acrescentar, em suas refeições, alimentos dos quais tinham medo ou aversão. Ao longo do processo, o objetivo terapêutico era o de desconstruir crenças distorcidas em relação à imagem corporal, alimentação e suas rígidas regras alimentares. Ao final, buscou-se estabelecer estratégias de confiança nas não recaídas aos comportamentos desregulados.

Os resultados da pesquisa mostraram melhora muito mais significativa nos participantes que receberam tratamento integrado, com medicamentos e terapia. A TCC se mostrou eficiente na redução dos episódios compulsivos e purgativos em 82,6% (48% ficaram abstinentes de tal comportamento, ou seja, pararam completamente com seus episódios), dos pacientes, bem como na redução dos pensamentos de preocupação e excessiva fome. Além disso, os autores também puderam observar a capacidade do tratamento psicoterápico cognitivo-comporta-

mental em manter os ganhos terapêuticos dos participantes, mesmo após o encerramento do tratamento medicamentoso.

Suporte empírico 3

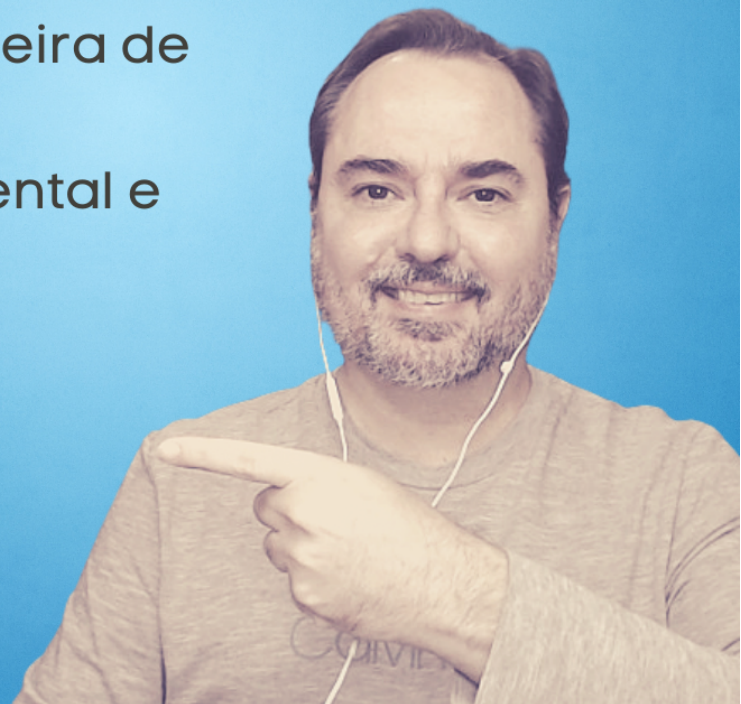
No estudo citado anteriormente, realizado por Lunn e Poulsen (2012), os participantes que passaram pelo tratamento cognitivo-comportamental receberam 30 sessões de 50 minutos precedidas por uma sessão inicial de noventa minutos. Nas primeiras quatro semanas, o tratamento ocorreu duas vezes por semana; nas próximas dez semanas, semanalmente, e quinzenalmente nas últimas seis semanas. Por conta da diferença de duração dos dois tratamentos testados nesta pesquisa, o Psicanalítico e o Cognitivo-Comportamental, a análise de mudança de intensidade e frequência dos sintomas ocorreu em três momentos; o primeiro cinco meses após o início dos tratamentos, o segundo um ano após o início e o último, ao final do tratamento cognitivo-comportamental (5 meses depois) e ao final do tratamento psicanalítico (19 semanas depois).

Dos participantes que receberam tratamento Cognitivo-Comportamental, 15 (42%) pararam completamente seus episódios compulsivos e purgativos após cinco meses de terapia. Em dois anos, 44% dos participantes passaram pela mesma melhora. Os autores afirmaram que foi possível observar uma rapidez neste tratamento, visto que a melhora nos sintomas pode ser observada de maneira mais imediata e eles acreditam que a causa disto é o fato de que esta abordagem é focada no sintoma com o claro intuito de redução de episódios compulsivos.

Desta forma, os autores concluem que a TCC é uma abordagem eficiente para o tratamento de Bulimia Nervosa. No entanto, eles reforçam a importância de desenvolvimento de alternativas para este tratamento, visto que a maioria dos pacientes (56%) ainda mantiveram sintomas mesmo após o experimento.

O que @s psicólog@s cientistas andam estudando?

Episódio **#4**
Revista Brasileira de
Terapia
Comportamental e
Cognitiva



Quer saber quais são as publicações mais recentes em periódicos científicos? Acompanhe o programa "O que os psicólogos cientistas andam estudando", apresentado pelo Prof. Márcio Moreira gratuitamente no Youtube:

[Clique aqui para assistir](#)

Suporte empírico: Psicanálise

Abaixo serão apresentadas pesquisas que apresentam evidências científicas do tratamento psicodinâmico de transtornos alimentares. Faz-se relevante destacar a dificuldade de encontrar artigos que apresentam evidências do tratamento explicitamente psicanalítico, ou seja, por exemplo, de orientação lacaniana e freudiana. Desta forma, fez-se necessária a seleção de pesquisas realizadas com a utilização de abordagens psicodinâmicas, ou seja, psicoterapias que foram construídas a partir da teoria psicanalítica, como a Psicologia do Self e o tratamento Psicodinâmico Focal.

A seleção do primeiro artigo científico com suporte empírico do tratamento psicanalítico de Anorexia Nervosa foi feita a partir da busca pelas referências bibliográficas da Meta Análise nomeada de “The effectiveness of long-term psychoanalytic psychotherapy—A meta-analysis of randomized controlled trials”, de Smit et al. (2012). Desta maneira, dentre as referências utilizadas, selecionamos, para esta pesquisa, o artigo “Psychological therapies for adults with anorexia nervosa: Randomized controlled trial of out-patients treatments”, de Dare et al. (2001).

Suporte empírico 1

Dare et al. (2001) realizaram um experimento randomizado controlado com diferentes tratamentos psicoterápicos ambulatoriais de Anorexia Nervosa, com a utilização de três diferentes abordagens psicológicas e um Grupo Controle. As abordagens pesquisadas foram a Psicoterapia Psicodinâmica Focal, a TCC e a Terapia Familiar. Como dito na introdução deste trabalho, Psicoterapia Psicodinâmica Focal é uma terapia oriunda da Psicanálise.

O tratamento Psicodinâmico Focal foi realizado a partir do estabelecimento de uma posição não-diretiva, na qual o psicólogo não aconselhou o paciente em relação aos seus comportamentos alimentares, suas possíveis causas ou lhe ensinou a respeito da administração de tais sintomas. No entanto, trabalhou com a noção de consciência e inconsciência, os significados conscientes e inconscientes dos sintomas apresentados no passado e nas relações atuais do mesmo com as pessoas com quem se relaciona e as manifestações das influências destes sintomas na relação estabelecida com o terapeuta, de maneira a influenciar no interesse do paciente em se dedicar à análise (transferência) (Dare et al., 2001).

As sessões analíticas ocorreram de maneira semanal, tiveram a duração de cinquenta minutos e ocorreram no período de um ano. O psicanalista trabalhou em conjunto com um médico e um assistente social e os três estavam em terapia e participando de supervisão analítica de uma hora e meia, de maneira quinzenal, durante a realização do experimento. Inicialmente, 54 pacientes diagnosticados com Anorexia Nervosa participaram da pesquisa, dos quais doze realizaram o tratamento psicanalítico.

Ao final, os pacientes que receberam tratamento psicanalítico tiveram mais capacidade de ganho de peso que os participantes do grupo controle, haja vista que neste último apenas um quinto dos participantes ganhou peso, enquanto no grupo que recebeu tratamento, dois terços ganharam, sendo que entre 23% e 38% destes aumentaram cerca de 10% do peso. Além disso, o estudo também concluiu que psicoterapias especializadas, ou seja, aquelas que se baseiam na teoria de alguma abordagem psicológica, são mais efetivas que o tratamento de rotina para transtornos alimentares, já que cerca de um terço dos pacientes que receberam algum tratamento especializado não possuíam mais os sintomas critérios para o diagnóstico de Anorexia Nervosa, de acordo com o DSM-V ao final do experimento.

Suporte Empírico 2

O segundo artigo científico utilizado para análise de dados que forneçam um suporte empírico para o tratamento psicanalítico de transtornos alimentares foi o de Lunn e Poulsen (2012). Este artigo foi escolhido a partir da busca pelas referências do artigo “Bulimia: Psychoanalytic treatment and theory”, escolhido nas referências da meta-análise “Integrated Psychodynamic Therapy for Bulimia Nervosa and Binge Eating Disorder: Theory, Practice and Preliminary Findings”. Os autores Lunn e Poulsen começaram sua pesquisa em 2012, ano no qual publicaram esta pesquisa, e analisaram os dados obtidos no ano de 2014, no artigo "A Randomized Controlled Trial of Psychoanalytic Psychotherapy or Cognitive-Behavioral Therapy for Bulimia Nervosa".

Poulsen et al. (2014) realizaram um estudo randomizado no qual compararam o tratamento Psicanalítico e o tratamento Cognitivo-Comportamental de indivíduos com Bulimia Nervosa. No que se refere ao processo terapêutico da Psicanálise, os pacientes foram atendidos semanalmente no período de dois anos em sessões de cinquenta minutos. Este tratamento foi realizado com a compreensão de que os sintomas bulímicos seriam resultado da dificuldade de enfrentamento e reconhecimento de desejos inconscientes. Portanto, o intuito foi trabalhar a capacidade desses indivíduos de refletir e tolerar experiências emocionais e facilitar suas compreensões em relação aos seus conteúdos recalcados. O processo ocorreu de maneira a incentivar a Associação Livre, ainda que o analista tenha tentado trabalhar com pontuações e destaques das possíveis relações e associações entre o que foi trazido e os comportamentos bulímicos. O tratamento consistiu em três fases: a primeira focada em estabelecer vínculo entre analista e analisando e reconhecer e identificar os sintomas bulímicos, a segunda com especial atenção na relação transferencial e a fase final de fechamento do tratamento (Poulsen et al., 2014).

Dos 70 participantes, 34 realizaram o tratamento psicanalítico, dos quais 24 terminaram a pesquisa. Destes, cinco (15%) cessaram seus comportamentos de compulsão alimentar ao final do experimento. Uma das conclusões da pesquisa, no que concerne ao tratamento psicanalítico, é de que, visto que a principal característica da Bulimia Nervosa é a incapacidade de tolerar e regular experiências afetivas e que, portanto, sintomas bulímicos servem para buscar evitar afetos negativos, a psicoterapia psicanalítica busca, justamente, o reconhecimento geral

de afetos recalçados. Desta forma, os autores hipotetizaram que este tratamento seria útil para a redução de comportamentos alimentares compulsivos (Poulsen et al., 2014; Lunn & Poulsen, 2012).

No entanto, considerando os resultados obtidos e a compreensão de que sintomas anoréxicos e bulímicos são comportamentos alimentares desregulados que buscam alívio de sofrimento imediato, uma atuação mais diretiva e pontual poderia vir a ser mais efetiva no tratamento destes transtornos. Desta maneira, os autores recomendam o desenvolvimento de uma versão de tratamento psicanalítico mais estruturada e focada no tratamento sintomático de maneira mais pontual (Poulsen et al., 2014; Lunn & Poulsen, 2012).

Suporte empírico 3

A terceira pesquisa que apresenta evidências científicas do tratamento psicanalítico de transtornos alimentares, “Empirical Comparison of Two Psychological Therapies: Self Psychology and Cognitive Orientation in the Treatment of Anorexia and Bulimia” de Bachar et al. (1999), foi selecionada nas Referências Bibliográficas da Meta-Análise “The Current State of the Empirical Evidence for Psychoanalysis: A Meta-analytic Approach”, de Maat et al. (2013).

Nesta pesquisa, 33 participantes diagnosticados com transtornos alimentares receberam atendimentos em três contextos distintos. Estes pacientes receberam tratamento com a abordagem da Psicologia do Self, de Heinz Kohut (abordagem oriunda da teoria psicanalítica, explicada na introdução deste trabalho), com a abordagem Cognitivo-Comportamental ou apenas tratamento nutricional, de controle. Os três grupos receberam tratamento nutricional semanal de 20 a 30 minutos no período de três meses e os dois grupos que receberam tratamento psicológico se encontraram com os psicólogos em sessões semanais de 50 minutos pelo período de um ano.

Os psicólogos que atenderam em Psicanálise e Cognitivo-Comportamental eram formados nestas abordagens e foram supervisionados semanalmente ao longo do experimento. As sessões foram gravadas e analisadas por outros psicólogos para análise da aplicação das técnicas.

Em relação ao atendimento psicodinâmico, nove dos catorze pacientes passaram por remissão, ou seja, seus sintomas permaneceram sob controle e diminuíram de intensidade. Dos pacientes com anorexia, cinco dos seis participantes (83%) passaram por essa melhora; dos pacientes bulímicos, quatro dos oito participantes (50%). Os autores concluem a importância de pesquisar e aplicar abordagens psicodinâmicas no tratamento psicológico de transtornos alimentares para o enriquecimento do atual repertório de técnicas terapêuticas utilizadas neste campo de pesquisa, atualmente dominado pela TCC.

Discussão

O objetivo deste trabalho foi o de apresentar exemplos de procedimentos que servem de suporte empírico da eficácia dos tratamentos psicológicos de transtornos alimentares. Como explicado anteriormente, compreende-se que estes artigos podem funcionar como suporte empírico para a demonstração das intervenções e a eficácia destes tratamentos, o que não garante que estas práticas sejam Práticas Baseadas em Evidências. Após a discussão a respeito da PPBE, foram apresentados estudos de caso e estudos clínicos que exemplificam tratamentos psicológicos destes transtornos em quatro abordagens da Psicologia e evidenciam sua eficácia. Estes documentos, que abordam evidências científicas (suporte empírico) do tratamento de transtornos alimentares para as quatro abordagens selecionadas, foram traduzidos da Língua Inglesa para a Língua Portuguesa.

Desta forma, buscou-se apresentar algumas atuações que psicólogos de cada uma destas abordagens podem ter, em seus consultórios, na busca pela compreensão das possíveis causas de desenvolvimentos de transtornos alimentares e a busca pela redução dos sintomas e do sofrimento de pessoas com Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa. No entanto, ainda que tenha sido possível encontrar evidências científicas do tratamento destas abordagens, faz-se pertinente salientar a importância da constante discussão a respeito do uso da PPBE no aumento da acessibilidade dos pacientes a outras abordagens para além da TCC.

Para a busca destes artigos, foi realizada uma pesquisa por revisões bibliográficas e meta-análises, com o intuito de procurar, em suas referências, os artigos que apresentavam ensaios clínicos randomizados e estudos de caso do tratamento de transtornos alimentares nas abordagens citadas anteriormente. Nestas pesquisas, o foco esteve em buscar as informações apresentadas no procedimento do trabalho, ou seja, o número de participantes, número de sessões, técnicas utilizadas pelos psicólogos, história de vida (no caso dos estudos de caso), e realização ou não de outro tipo de tratamento para além do psicológico.

Nos resultados, foi possível incluir três artigos nos quais foram realizados ensaios clínicos randomizados que apresentaram suporte empírico do tratamento de Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa para a TCC, Análise do Comportamento e abordagens Psicodinâmicas, bem como dois estudos de caso da Gestalt Terapia. Nestes artigos, observou-se que, ainda que de maneiras muito distintas e específicas para cada abordagem, os tratamentos seguiram o procedimento estabelecido e garantiram redução dos sintomas previamente descritos. Cada artigo especificou o tempo de terapia determinado e cumprido para o tratamento dos transtornos, exceto os dois estudos de caso da Gestalt-Terapia, bem como os critérios utilizados na análise da redução dos sintomas.

Após apresentadas as evidências de tratamento de Anorexia Nervosa e Bulimia Nervosa nas quatro abordagens, faz-se relevante a reflexão a respeito do processo de procura por tais artigos científicos. Exceto com a TCC, a busca por artigos que abordem estas evidências em pesquisas experimentais e estudos de caso nas outras três abordagens foi extremamente difi-

cil. Uma das possíveis causas para esta dificuldade pode ser uma menor preocupação destas outras abordagens em desenvolver pesquisas que busquem demonstrar empiricamente sua eficácia através de pesquisas realizadas com ensaios randomizados.

Comparações entre abordagens

Pôde-se observar que na Análise do Comportamento e na TCC, o número de sessões foi pré-definido em um período mais curto, de aproximadamente 20 semanas, enquanto nas pesquisas com as abordagens psicodinâmicas, a duração da pesquisa foi maior. Além disso, a TCC e as abordagens comportamentais possuem padrões mais específicos de técnicas a serem utilizadas no tratamento, enquanto as abordagens psicodinâmicas e humanistas não especificam tão detalhadamente as atividades realizadas nem mesmo as intervenções que foram utilizadas nos experimentos. Os autores Poulsen et al. (2014), por exemplo, apresentaram esta discussão ao afirmarem o fato de que a abordagem Cognitivo-Comportamental foi capaz de reduzir os sintomas de maneira mais rápida, haja vista sua pragmática intenção de focar especificamente nos sintomas, diferentemente da abordagem psicanalítica, não-diretiva, que não faz uso de procedimentos comportamentais específicos.

No entanto, é possível observar que, independentemente do tratamento utilizado e da teoria que embasa o desenvolvimento dos transtornos alimentares e o aparecimento dos sintomas, os tratamentos foram capazes de reduzir os sintomas dos pacientes anoréxicos e bulímicos participantes.

PPBE: Ser ou não ser?

Como afirmado pela APA (2006), a PPBE poderia facilitar a tomada de decisão na recomendação das abordagens disponíveis para o cuidado com o cliente diagnosticado com algum transtorno mental. Esta prática, ainda de acordo com a APA, poderia contribuir, também, com a saúde pública por conta da aplicação de princípios de eficácia empiricamente baseados, o que leva o psicólogo a manter seu aprendizado e atualização constantes. De acordo com a Comissão de Diretrizes e Procedimentos de Acreditação da APA (2013), o uso da PPBE na busca por evidências dos tratamentos encoraja o aumento de programas de treinamento de estudantes para ensiná-los a atender com base nos métodos que apresentam suporte empírico.

Desta maneira, compreende-se que existe a possibilidade que o crescimento da PPBE faça com que o tratamento psicológico seja mais recomendado para a TCC, inclusive no contexto dos planos de saúde, visto que a recomendação costuma ser baseada na apresentação de evidências científicas e na objetividade e eficácia deste tratamento. Por conta disso, é importante que haja reflexão sobre a real necessidade da apresentação destas evidências na capacidade deste tratamento de reduzir sintomas e o sofrimento dos pacientes com transtornos alimentares, sobre a forma de se buscar estas evidências, além da reflexão sobre o fato de que abordagens que não apresentem estas pesquisas podem vir a perder relevância e força no contexto

de tratamentos psicológicos de diversos transtornos mentais, ainda que sejam eficazes em seus tratamentos.

De acordo com Reed et al. (2006), existe controvérsia na literatura a respeito dos métodos empregados na busca por evidências da eficácia de um tratamento psicológico, em relação às maneiras de mensuração dos resultados obtidos na terapia clínica. Leonardi e Meyer (2016, p. 1470) especificam os três métodos de pesquisa utilizados com este intuito; o ensaio clínico randomizado, o experimento de caso único e estudo de caso. A Psicanálise e abordagens psicodinâmicas, as abordagens humanistas e, inclusive, algumas abordagens analítico comportamentais possuem a inclinação de utilizar os dois últimos métodos citados, o experimento de caso único e os estudos de caso, haja vista que estes dois processos permitem uma mensuração do desempenho do indivíduo quando comparado com ele mesmo, sem uma comparação nomotética dele com a média de outros indivíduos diagnosticados com o mesmo transtorno.

Inclusive, também destaca-se o fato de que os tratamentos nas abordagens psicodinâmicas e humanistas, por exemplo, costumam ter maior duração de tratamento, o que dificulta a pesquisa por evidências com tempo pré-determinado de experimento, já que a Psicologia busca não apenas a diminuição prática e objetiva da ocorrência dos sintomas, mas o conhecimento das possíveis causas e funções que sustentem tais sintomas. No entanto, existem críticas a respeito do uso de estudos de caso neste processo, visto que este “não é um método experimental e, por essa razão, tem pouco valor como evidência científica para a sustentação de uma prática terapêutica” no contexto de pesquisas em ciências naturais.

Ainda que muitos psicanalistas tenham explicitado o pouco investimento na busca por pesquisas objetivas e pragmáticas que apresentem evidências científicas empíricas de tal tratamento, Loparic (2008) afirmou que a “aproximação entre a psicanálise e as ciências positivas do homem parece uma necessidade de sobrevivência”. Um exemplo de crítica que pode vir a dificultar o uso da Psicanálise e outras abordagens psicológicas, que não se dediquem a tais pesquisas, no tratamento psicológico, é a exposta por Parloff (1982), em seu artigo "Psychotherapy Research Evidence and Reimbursement Decisions: Bambi Meets Godzilla". O autor afirmou que a Psicanálise não se enquadra em uma prática psicoterápica eficaz, já que não apresenta métodos padronizados que permitam repetição de tratamento e atuação que garanta redução dos sintomas; reforça que a ausência de definição leva a gastos injustificados pelo governo e prejuízo para os pacientes, que se submeterão a um tratamento que não apresenta garantia de eficácia. Essas críticas basearam a recomendação do autor para o uso de terapias cognitivo-comportamentais, já que essas trariam menos ambiguidade em seus métodos, definições mais claras das metas que buscam e das intervenções a serem realizadas com os pacientes.

A APA (2006) descreve os tratamentos psicológicos de algumas abordagens da Psicologia que apresentem evidências científicas de sua eficácia. Ainda que, dentre estes documentos, não haja pesquisa da Psicanálise a respeito do tratamento de transtornos alimentares, é apresentado o tratamento psicanalítico do Transtorno de Pânico, o que é interessante para a observação

de certa adaptação da abordagem dentro do escopo de estudos da PPBE. No entanto, no que diz respeito ao tratamento da Gestalt Terapia, não são apresentadas, de fato, neste site, pesquisas com evidências científicas.

O que alguns analistas do comportamento afirmam (abordagens estas que não concordam com o uso de ensaios randomizados na obtenção de evidências científicas do tratamento psicológico) é que o foco do tratamento não deve estar na realização de ensaios randomizados em larga escala para a busca de comprovação da melhora dos sintomas, visto que estas abordagens possuem uma visão idiográfica e não nomotética, ou seja, o foco está no indivíduo e no seu processo único da causa de seus sintomas, o que os mantém e quais são os ganhos secundários com eles, por exemplo. A pesquisa nomotética visa investigar pessoas com o mesmo diagnóstico, distribuídas randomicamente, para a comparação de tratamentos com diferentes abordagens e grupo controle, buscando comparar o indivíduo com a média dos indivíduos que possuem o mesmo transtorno. Estes ensaios restringem as diferenças individuais na realização de pesquisas com um número muito grande de participantes, perdendo o indivíduo ao tentar comparar as duas medidas de tendência central para buscar relevância estatisticamente significativa (Leonardi & Meyer, 2006).

Desta forma, faz-se relevante apresentar, também, algumas das críticas ao uso da PBE na recomendação das abordagens, visto que existe uma grande discussão a respeito da necessidade de foco, tempo e investimento dos pesquisadores nestas outras abordagens para a realização de pesquisas que busquem apresentar evidências científicas, além da falta de consenso a respeito do que seria uma evidência psicológica e da maneira que tais evidências são investigadas. Algumas dessas críticas foram citadas por Lilienfeld et al. (2013); entre elas, está o fato de que o uso de técnicas padronizadas dificulta a transposição de efeitos derivados dos ensaios clínicos para a prática individual e o contexto idiográfico de cada paciente. Ademais, os autores também destacam o fato de que algumas das abordagens demonstradas como eficazes nos estudos controlados seriam dificilmente replicadas no *setting* clínico do dia a dia.

Winnicott (1986b/1990, p. 174) afirmou que as necessidades de pesquisas científicas não podem guiar a atuação do psicólogo no tratamento do paciente, da mesma forma que nenhum *setting* terapêutico pode ser repetido, que “todo analista está fazendo pesquisa, mas esta não pode ser planejada como tal”, visto que o analista deveria seguir as necessidades maturacionais do paciente. No contexto psicanalítico, Carvalho (2014) afirmou que esta abordagem é uma ciência, porém ciência do singular.

Lacan (1966/1998, p. 843) afirmou que a Psicanálise se diferencia da ciência lógico-experimental, pois ela tem o foco de sua investigação no sujeito como singular, naquilo que ele tem de indiscernível, no que o diferencia dos demais e que, portanto, não serviria de práticas científicas tradicionais, científicas, padronizadas e generalizáveis. Desta forma, o autor classifica a Psicanálise como uma ciência conjectural; a técnica é situável, só exercível na relação do sujeito com o significante no contexto em que se insere naquele momento.

De acordo com Carvalho (2014), o que se espera no final de uma análise é que o analisando consiga reconhecer o que há nele de único, o que, para além de sua estrutura, consiste em seu modo inconsciente e singular de gozar e desejar em sua vida. O que se conclui, portanto, é que a Psicanálise é uma ciência, mas uma ciência do singular, do particular, do inconsciente, e que, por isso, há muita discordância desta abordagem em relação ao uso de pesquisa nomotéticas e padronizadas de estudo do tratamento psicanalítico de transtornos mentais.

Mezan (2007) afirmou que a singularidade do objeto de estudo psicanalítico é um empecilho para a aplicação de lógica nos fenômenos psíquicos, visto que as ciências humanas estão longe de atingir linearidade e relações de causa e efeito presentes nas ciências naturais, o que faz com que o método experimental não seja totalmente aplicável neste contexto. Uma reflexão interessante é a desenvolvida por Fontoni (2015), quando o autor afirmou que uma possível solução à demanda de evidências na Psicanálise não é fazer com que esta abordagem se adeque ao modelo de ciência experimental, mas contar com a reabertura da medicina para as particularidades das ciências humanas e a dificuldade de padronização das pesquisas e atuações nesta área.

Considerações finais

Observa-se que, para que fosse possível apresentar as pesquisas que servem de suporte empírico do tratamento de transtornos alimentares para as abordagens citadas, fez-se necessário abordar, anteriormente, o tema dos transtornos alimentares desde sua compreensão médica e suas implicações na saúde física do paciente, até o entendimento teórico das abordagens psicológicas a respeito do desenvolvimento e manutenção dos transtornos.

A primeira consideração que pode ser feita a respeito desta revisão bibliográfica é de que, ainda que tenha sido possível encontrar artigos que possam servir de suporte empírico para a comprovação da eficácia dessas abordagens nos tratamentos destes transtornos, observa-se que ainda há muita discordância em relação à Prática Baseada em Evidências no contexto da Psicologia (Leonardi & Meyer, 2015; DeRubeis et al., 2005; Reed et al., 2006; Parloff, 1982; Loparic, 2008; Mezan, 2007; Fontoni, 2015).

O que pode-se concluir é que foi encontrado suporte empírico, o que não permite, no entanto, a afirmação de que essas abordagens sejam Práticas Baseadas em Evidências, considerando todas as exigências determinadas pela APA para a definição de uma prática neste contexto.

Enquanto observa-se que algumas abordagens, como a TCC, possuem grande parte de seu investimento focalizado justamente na garantia da demonstração empírica de sua eficácia na redução dos sintomas apresentados, outras, como a Psicanálise e a Gestalt Terapia, não apresentam tantas pesquisas com este interesse, o que pode significar que seu foco não está na padronização da atuação destes profissionais, já que compreendem que cada caso é um caso e nem sempre haverá específicas atuações do psicólogo, nem tempo específico de tratamento,

que garantirão, de fato, o contato com a causa geradora de sintomas e, conseqüentemente, sua redução.

Por conta do fato de que a TCC é a abordagem que mais busca demonstrar a eficácia de seu tratamento de maneira prática, com a realização de pesquisas e ensaios randomizados, é ela a recomendada pela maioria dos membros da comunidade médica, justamente pelo investimento da Medicina nas pesquisas da PBE. No entanto, isso não é comprovação da validade exclusiva desta abordagem no tratamento destes transtornos, o que pode afetar negativamente o contato dos pacientes a outros tratamentos psicológicos que também são extremamente úteis no tratamento de transtornos alimentares.

Desta forma, compreende-se que foi possível encontrar suporte empírico do tratamento de transtornos alimentares nas quatro abordagens da Psicologia, ainda que apenas em inglês e com certa dificuldade, principalmente nas abordagens que discutem a validade e necessidade de se realizar pesquisas nomotéticas e ensaios randomizados na busca pela sua adaptação no contexto da Prática Baseada em Evidências.

Referências bibliográficas

- Adami, I. & Garcia, J. R. L. (2018, Novembro). Bulimia nervosa na intervenção psicoterapêutica psicanalítica. Centro de Ciências Humanas, Departamento de Psicologia, Universidade do Sagrado Coração, Bauru.
- Agras, W. S., Schneider, J. A., Arnow, B., Raeburn, S. D., & Telch, C. F. (1989). Cognitive-behavioral and response-prevention treatments for bulimia nervosa. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 57(2), 215-221. <https://doi.org/10.1037/0022-006x.57.2.215>
- Agras, W. S., Rossiter, E. M., Arnow, B., Schneider, J. A., Telch, C. F., Raeburn, S. D., Koran, L. M. (1992). Pharmacologic and cognitive-behavioral treatment for bulimia nervosa: A controlled comparison. *The American Journal of Psychiatry*, 149, 82-87. <http://dx.doi.org/10.1176/ajp.149.1.82>
- Ambulim (Ambulatório de Bulimia e Transtornos Alimentares). *História do Ambulim*.
- American Psychology Association Presidential Task Force on Evidence-Based Practice (2006). Evidence-Based Practice in Psychology. *American Psychologist*, 61(4), 271-285.
- American Psychology Association. (2016). *Division 12, Psychological Treatments*. Society of clinical psychology.
- Anderluch, M. B., Rabe-Hesketh, S., Tchanturia, K., & Treasure, J. L. (2003). Childhood Obsessive-Compulsive Personality Traits in Adult Women With Eating Disorders: Defining a Broader Eating Disorder Phenotype. *American Journal of Psychiatry*, 160(2), 242-247.
- Andersen, A. E. (1999). Males with eating disorders: Medical considerations. Em P. S. Mehler & A. E. Andersen (Eds.), *Eating disorders: A guide to medical care and complications*, 214-226. Johns Hopkins University Press.
- Andersen, A. E. (2002). Eating disorders in males. In C. F. Fairburn & K. D. Brownell (Eds.), *Eating disorders and obesity: A comprehensive handbook*, 2, 188-191. Guilford Press.
- Andersen, A. E., Cohn, L., & Holbrook, T. (2000). *Making weight: Men's conflicts with food, weight, shape and appearance*. Gurze Books.
- Anjos, L. A. (1992). Índice de massa corporal (massa corporal.estatura-2) como indicador do estado nutricional de adultos: revisão da literatura. *Revista de Saúde Pública*, 26(6), 431-436.
- Bachar, E., Latzer, Y., Kreitler, S., Berry, E. M. (1999). Empirical comparison of two psychological therapies. Self psychology and cognitive orientation in the treatment of anorexia and bulimia. *Journal Psychotherapy Practical Research*, Spring, 8(2), 115-128.

- Baise, M. (2008). *Avaliação dos traços de personalidade em pacientes com anorexia nervosa, segundo o Inventário de Temperamento e Caráter de Cloninger*. (Dissertação de mestrado). Programa de Pós-Graduação em Psicologia, São Paulo.
- Barros, S. & Gonçalves, L. B. Sabe a diferença entre Índice de Massa Corporal e Índice de Adiposidade Corporal? *Sapo LifeStyle*.
- Bastos, L. A. M. (2002). Psicanálise baseada em evidências? *PHYSIS: Revista Saúde Coletiva*, 12(2), 391-408.
- Bean, P., Loomis, C. C., Timmel, P., Hallinan, P., Moore, S., Mammel, J., Welzin, T. (2004). Outcome variables for anorexic males and females one year after discharge from residential treatment. *Journal of Addictive Diseases*, 23, 83-94.
- Beck, J. S. & Rosa, S. M. M. (2013). *Terapia Cognitivo-Comportamental: Teoria e prática*. Artmed.
- Bleichmar, E. D. (2000). Anorexia/bulimia: un intento de ordenamiento desde el Enfoque Modular-Transformacional. *Revista de Psicoanálisis* 4.
- Borges, N. J. B. G, Sicchieri, J. M. F, Ribeiro, R. P. P, Marchini, J. S. & Dos Santos, J. E. (2006). Transtornos alimentares: quadro clínico. *Revista Medicina*, 39(3), 340-348.
- Boodman, S. G. (2007). Eating disorders: Not just for women. *Washington Post*.
- Bruno, D., Rosani, M., & Berlincioni, V. (2009). Giocare al teatro: nota clinica su un'esperienza di laboratorio teatrale con pazienti affette da DCA. *Rivista Sperimentale di Freniatria: La Rivista della Salute Mentale*, 133(1), 143-149.
- Camargos, S. P. S., Lopes, R. F. F. & Bernardino, L. G. (2020). Terapia Cognitivo-Comportamental Multicomponente para Adolescentes com Transtorno Alimentar: Um Estudo de Caso. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 16(2), 114-121.
- Campolina, M. B. R. (2014). *Bulimia e devastação: uma clínica do feminino*. (Monografia). Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Minas Gerais.
- Carreteiro, T. C. (2005). Corpo e contemporaneidade. *Psicologia em Revista*. 11(17), 62-76.
- Carvalho, M. L. & Lima, D. M. A. (2017). A Anorexia em Adolescentes Sob a Ótica da Gestalt-terapia: The anorexia in adolescents from the perspective of Gestalt therapy. *IGT na Rede*, 14(26), 23-30.
- Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID - 10: descrições clínicas e diretrizes diagnósticas (1993). *Artmed*.

- Casper, R., Eckert, E., Halmi, K., Goldberg, S., Davis, J. (1980). Bulimia: Its incidence and clinical significance in patients with anorexia nervosa. *Archives of General Psychiatry*.
- Claudino, A. M.; Borges, M. B. F. (2002). Critérios diagnósticos para os transtornos alimentares: conceitos em evolução. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 24(III), 7-12.
- Castoriadis, C. (1995). *A Instituição imaginária da sociedade*. Paz e Terra.
- Copetti, A. V. S. & Quiroga, C. V. (2018). A influência da mídia nos transtornos alimentares e na autoimagem em adolescentes. *Revista de Psicologia da IMED*, 10(2), 161-177. <https://doi.org/10.18256/2175-5027.2018.v10i2.2664>
- Costa, B. E. T. & Sousa, S. A. L. M. (2011). *Um Olhar Gestáltico Sobre a Bulimia*. (Trabalho de conclusão de Pós-graduação *Lato Sensu* de Gestalt-Terapia). Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-Terapia de Goiânia, Goiás.
- Dare, C., Eisler, I., Russell, G., Treasure, J., Dodge, L. (2001). Psychological therapies for adults with anorexia nervosa: randomized controlled trial of out-patient treatments. *British Journal of Psychiatry*, 178, 216-221. <https://doi.org/10.1192/bjp.178.3.216>
- DeRubeis, R. J., Brotman, M. A. & Gibbons, C. J. (2005). A conceptual and methodological analysis of the nonspecifics argument. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 12(2), 174-183.
- Duchesne, M. & Almeida, P. E. M. (2002). Terapia cognitivo-comportamental dos transtornos alimentares. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 24(III), 49-53.
- Elia, L. (2010). *O conceito de sujeito*. Luciano Elia. Jorge Zahar Ed., Psicanálise passo-a-passo, 50(3).
- Elzer, M. & Gerlach, A. (2014). *Psychoanalytic Psychotherapy: a handbook*. European Federation of Psychoanalytic Psychotherapy. Karnac Books Ltd.
- Fassino, S., Amianto, F., & Ferrero, A. (2008). Psicoterapia breve psicodinamica adleriana: elementi teorici e indicatori di processo. *Minerva Psichiatrica*, 49(3), 203-216.
- Ferreira, R. A. (2011). Anorexia nervosa e bulimia nervosa. Não se trata disso. *Comunicação proferida na V Enapol*.
- Frazão, L. & Fukumitsu, K. (2017). Quadros clínicos disfuncionais e gestalt-terapia: 5 Capa comum. *Summus Editorial*, 1ª edição.
- Freud, S. (1912). Recomendações ao médico para o tratamento psicanalítico. Fundamentos da clínica psicanalítica. *Autêntica*, 93-106.

- Freud, S. (1920). Além do princípio de prazer. *Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud*, Imago, 18.
- Freud, S. (1923) O ego e o id. *Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud*, Imago, 19.
- Freud, S. (1924) O problema econômico do masoquismo. *Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud*, Imago, 19.
- Freud, S. (1969/1926). Inibições, sintomas e ansiedade. In: *Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud*, Imago, 20.
- Fortes, L. S., Conti, M. A. & Ferreira, M. E. C. (2012). Relação entre comportamentos de risco para transtornos alimentares e processo maturacional em jovens atletas. *Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde*, 17(5), 379-395.
- Fontoni, M. (2015). O futuro da psicanálise: uma busca por evidências? *Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo*.
- Gonçalves, A. K., Almeida, M. L. T. & Hubner, I. C. (2021). Terapia cognitivo comportamental para o transtorno de compulsão alimentar: revisão integrativa de literatura. *Repositório universitário de Ânima (RUNA)*.
- Gorgati, S. B., Holcberg, A. S. & Oliveira, M. D. (2002). Abordagem psicodinâmica no tratamento dos transtornos alimentares. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 24(3), 44-48.
- Greenberg, S. T.; Schoen, E. G. (2008). Males and eating disorders: Gender-based therapy for eating disorder recovery. *Professional Psychology: Research and Practice*, 39(4), 464–471. <https://doi.org/10.1037/0735-7028.39.4.464>
- Hayes S, Luoma J, Bond F, Masuda A & Lillis J. (2006). Acceptance and commitment therapy: model, processes and outcomes. *Behaviour Research and Therapy*, 44, 1-25.
- Hercowitz, A. (2015). Transtornos alimentares na adolescência. *Pediatrics Moderna*, 51(7).
- Hetherington, M. M.; Rolls, B. J. (2001). Dysfunctional eating in the eating disorders. *Psychiatric Clinics of North America*, 24(2), 235-248.
- Hilbert, A., Hoek, H. W., & Schmidt, R. (2017). Evidence-based clinical guidelines for eating disorders: international comparison. *Current opinion in psychiatry*, 30(6), 423–437. <https://doi.org/10.1097/YCO.0000000000000360>
- Hilbert, A., Petroff, D., Herpertz, S., Pietrowsky, R., Tuschen-Caffier, B., Vocks, S., & Schmidt, R. (2019). Meta-analysis of the efficacy of psychological and medical treatments for binge-eating disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 87(1), 91–105. <https://doi.org/10.1037/ccp0000358>

- Herzog, D. B., Greenwood, D. N., Dorer, D. J., Flores, A. T., Ekeblad, E. R., Richards, A., Blais, M. A., Keller, M. B. (2000). Mortality in eating disorders: a descriptive study. *International Journal of Eating Disorders*, 28(1), 20-6. [https://doi.org/10.1002/\(sici\)1098-108x\(200007\)28:1<20::aid-eat3>3.0.co;2-x](https://doi.org/10.1002/(sici)1098-108x(200007)28:1<20::aid-eat3>3.0.co;2-x).
- Hoek, H. W. & Hoeken, D. Van (2003). Review of the prevalence and incidence of eating disorders. *National Library of Medicine*.
- Kaye, W. H. Bulik, C. M. Thornton, N. B. & Masters, K. (2004). Comorbidity of anxiety disorders with anorexia and bulimia nervosa. *National Library of Medicine*.
- Keel, P. K., & Haedt, A. (2008). Evidence-Based Psychosocial Treatments for Eating Problems and Eating Disorders. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 37(1), 39–61. <https://doi.org/10.1080/15374410701817832>
- Kiyan, A. M. M. (2006). *E a Gestalt emerge: Vida e Obra de Frederick Perls*. Editora Altana.
- Klump, K. L., Suisman, J. L., Burt, S. A., McGue, M., & Iacono, W. G. (2009). Genetic and environmental influences on disordered eating: An adoption study. *Journal of abnormal psychology*, 118(4), 797–805. <https://doi.org/10.1037/a0017204>.
- Knapp, P. & Beck, A. T. (2008). Fundamentos, modelos conceituais, aplicações e pesquisa da terapia cognitiva: Cognitive therapy: foundations, conceptual models, applications and research. *Revista Brasileira Psiquiátrica*, 54-64.
- Lacan, J. (1964/1965). *O seminário, livro 12: Problemas cruciais para a Psicanálise*. Centro de Estudos Freudianos do Recife. Publicação não comercial.
- Lacan, J. (2018). *O seminário 13: el objeto del psicoanálisis*. Centro de Estudos Freudianos do Recife. Publicação não comercial.
- Le Grange D., Crosby R. D., Rathouz P. J. & Leventhal B. L. (2007). A randomized controlled comparison of family-based treatment and supportive psychotherapy for adolescent bulimia nervosa. *Archives of General Psychiatry*, 64(9), 1049–1056.
- Lilienfeld, S. O., Ritschel, L. A., Lynn, S. J., Cautin, R. L., & Latzman, R. D. (2013, Nov). Why many clinical psychologists are resistant to evidence-based practice: root causes and constructive remedies. *Clinical Psychology Review*, 33(7), 883-900. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2012.09.008>
- Leichsenring, F., Klein, S., & Salzer, S. (2014). The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy in Specific Mental Disorders: A 2013 Update of Empirical Evidence. *Contemporary Psychoanalysis*, 50(1-2), 89–130. <https://doi.org/10.1080/00107530.2014.88031>

- Leichsenring, F., Leweke, F., Klein, S., & Steinert, C. (2015). The Empirical Status of Psychodynamic Psychotherapy – An Update: Bambi's Alive and Kicking. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 84(3), 129–148.
- Leonardi, J. L. & Meyer, S. B. (2015). Prática Baseada em Evidências em Psicologia e a História da Busca pelas Provas Empíricas da Eficácia das Psicoterapias. *Psicologia, ciência e profissão*, 35(4), 1139-1156.
- Leonardi, J. L. & Meyer, S. B. (2016). Evidências de Eficácia e o Excesso de Confiança Translacional da Análise do Comportamento Clínica. *Temas em Psicologia*, 24(4), 1465-1477.
- Lewis, A. J., Dennerstein, M., & Gibbs, P. M. (2008). Short-term psychodynamic psychotherapy: review of recent process and outcome studies. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 42(6), 445-455.
- Linardon J, Fairburn CG, Fitzsimmons-Craft EE, Wilfley DE, Brennan L. (2017). The empirical status of the third-wave behaviour therapies for the treatment of eating disorders: A systematic review. *Clinical Psychological Review*, 58, 125-140. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2017.10.005>
- Linardon, J., Gleeson, J., Yap, K., Murphy, K., & Brennan, L. (2018). Meta-analysis of the effects of third-wave behavioural interventions on disordered eating and body image concerns: implications for eating disorder prevention. *Cognitive Behaviour Therapy*, 1–24. <https://doi.org/10.1080/16506073.2018.1517>
- Lima, M. M. R. & Leite, S. (2011). O masoquismo e o problema econômico em Freud. *Psicanálise & Barroco em revista*, 9(2), 161-177.
- Lock, J. (2015). An Update on Evidence-Based Psychosocial Treatments for Eating Disorders in Children and Adolescents. *Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology*, 44(5), 707–721. <https://doi.org/10.1080/15374416.2014.971458>
- Loparic, Z. (2008). O paradigma winnicottiano e o futuro da psicanálise. *Revista Brasileira de Psicanálise*, 42(1), 137-150.
- Lunn, S., & Poulsen, S. (2012). Psychoanalytic psychotherapy for bulimia nervosa: A manualized approach. *Psychoanalytic Psychotherapy*, 26(1), 48–64. <https://doi.org/10.1080/02668734.2011.652977>
- Maat S., de Jonghe F., Schoevers R. & Dekker J. (2009). The effectiveness of long-term psychoanalytic therapy: a systematic review of empirical studies. *Harv Rev Psychiatry*. 17(1), 1-23. <https://doi.org/10.1080/10673220902742476>

- Maat, S., de Jonghe, F., Kraker, R., Leichsenring, F., Abbass, A., Luyten, P., Barber, JP., Rien Van, Dekker J. The current state of the empirical evidence for psychoanalysis: a meta-analytic approach. *Harv Rev Psychiatry*, 21(3), 107-137. <https://doi.org/10.1097/HRP.0b013e318294f5fd>
- Macedo, C. R. M. (2010). A função continente e o uso da contratransferência como instrumentos na psicoterapia de grupo com pacientes com severas perturbações no desenvolvimento do psiquismo. *Vínculo*, 7(2), 16-23.
- Maia, M. S. (2001). Um tapete vermelho para a angústia: clínica psicanalítica e contemporaneidade. *Percurso, Revista de Psicanálise*, 27, 67-76.
- Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5. *Porto Alegre: Artmed*, 2014.
- Massimi, M. (2006). Sermões quaresmais e conhecimento de si mesmo. *Interações*, 11(21), 97-120.
- Mattos, J. M. (2000). *A visão de saúde e doença da Gestalt-terapia na compreensão da compulsão alimentar*. (Monografia de Conclusão de Curso). Núcleo de Gestalt-terapia Dialógico, Rio de Janeiro.
- Miller, A. (1997). *O drama da criança bem dotada: como os pais podem formar e (deformar) a vida emocional dos filhos*. Summus.
- Melnik, T.; Souza, W. F. & Carvalho, M. R. (2013). A importância da prática da psicologia baseada em evidências: aspectos conceituais, níveis de evidência, mitos e resistências. *Revista Costarricense de Psicologia*, 33(2), 79-92.
- Moreira, M. B. & Medeiros, C. A. (2019). *Princípios básicos de análise do comportamento*. Artmed, 2.
- Morgan, C. M., Vecchiatti, I. R. & Negrão, A. B. (2002). Etiologia dos transtornos alimentares: aspectos biológicos, psicológicos e sócio-culturais. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 24(3), 18-23.
- Murphy, R., Straebl, S., Cooper, Z. & Fairburn, C. G. (2010). Cognitive Behaviour Therapy for Eating Disorders. *Psychiatric Clinical of North America*, 33, 611–627.
- Mussell, M. P., Crosby, R. D., Crow, S. J., Knopke, A. J., Peterson, C. B., Wonderlich, S. A. & Mitchell, J. E. (1999). Utilization of Empirically Supported Psychotherapy Treatments for Individuals with Eating Disorders: A Survey of Psychologists. Graduate Department of Professional Psychology, University of St. Thomas, Minneapolis, Minnesota. *Empirically Supported Psychology*, 230-237.

- Neto, G. A. R. M., Martinez, V. C. V., Santos, F. O. & Junior, M.C. S. (2006). Anorexia e Bulimia, suas interfaces com a histeria e o discurso psicanalítico. *Aletheia*, 23, 101-111.
- Nielsen, S. (2001). Epidemiology and Mortality of Eating Disorders. *Psychiatric Clinics North America*, 24(2), 201-214.
- Novaes, J. V. (2013). *O intolerável peso da feiúra: sobre as mulheres e seus corpos*. Editora PUC-Rio e Garamond.
- Nunes, A. L. & Holanda, A. (2008). Compreendendo os transtornos alimentares pelos caminhos da Gestalt-Terapia. *Revista da Abordagem Gestáltica*, 16(2), 172-181.
- Nunes-Costa, R. A., Lamela, D. J. P. V., Gil-Costa, L. (2009). Teoria e eficácia da terapia comportamental dialética na bulimia nervosa e no transtorno da compulsão alimentar periódica. Revisão de literatura, *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 58(2).
- Oliveira, L. L. & Hutz, C. S. (2010). Transtornos alimentares: o papel dos aspectos culturais no mundo contemporâneo. *Psicologia em Estudo*, 15(3), 575-582.
- Oliveira, L. P. M., Queiroz, V. A. O., Silva, M. C. M, Pitangueira, J. C. D., Costa, P. R. F., Demétrio, F., Anjos, M. C. G. & Assis, A. M. O. (2012). Índice de massa corporal obtido por medidas autorreferidas para a classificação do estado antropométrico de adultos: estudo de validação com residentes no município de Salvador, estado da Bahia, Brasil. *Epidemiologia e Serviços de Saúde*, 21(2), 325-332. <https://dx.doi.org/10.5123/S1679-49742012000200015>
- Oliveira, L. L. & Deiro, C. P. (2013). Terapia cognitivo-comportamental para transtornos alimentares: a visão de psicoterapeutas sobre o tratamento. *Revista brasileira de terapia comportamental cognitiva*, 15(1), 36-49.
- Parloff, M. (1982). Psychotherapy Research Evidence and Reimbursement Decisions: Bambi Meets Godzila. *American Journal of Psychiatry*, 139(6), 718-727.
- Pinzon, V. & Nogueira, F. C. (2004) Epidemiologia, curso e evolução dos transtornos alimentares. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 31(4), 158-160.
- Pizutti, J. M. (2012). *A constituição do sujeito na psicanálise* (Monografia).
- Raffagnino, R. (2019). Gestalt Therapy Effectiveness: A Systematic Review of Empirical Evidence. *Open Journal of Social Sciences*, 7(6).
- Reed, G. M., Kihlstrom, J. F., & Messer, S. B. (2006). What qualifies as evidence of effective practice? In J. C. Norcross, L. E. Beutler, & R. F. Levant (Orgs.), *Evidence-based practices in mental health: Debate and dialogue on the fundamental questions* (pp. 13-55). American Psychological Association.

- Reik, T. (1949). *Listening with the Third Ear: The Inner Experience of a Psychoanalyst* Book Description. *Farrar, Straus and Giroux*.
- Rutherford, L., & Couturier, J. (2007). A review of psychotherapeutic interventions for children and adolescents with eating disorders. *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 16(4), 153-157.
- Safer, D.L.M.D.; Telch, C. F. Ph.D. & Agras, S. W. (2001). Dialectical Behaviour Therapy for Bulimia Nervosa. *The American Journal of Psychiatry*.
- Santos, L. P. & Faria, L. A. F. (2006). Ansiedade e Gestalt-Terapia. *Revista de abordagem gestáltica*, 12, 267-277.
- Santos, D. R. & Soares, M. R. Z. (2017). Avaliação inicial e funcional de um caso clínico de Transtorno Alimentar sob a perspectiva da Análise do Comportamento. *Revista Brasileira de Psicoterapia*, 19(2), 45-58.
- Sato, K. (2007). Cap. 3: A Presença do arquétipo feminino no transtorno alimentar. Em A. Schilings; A. L. Nunes; F. M. Gaspar; J. K. Sato; K. O. Fukumitsu; M. J. Teixeira & S. Karwowski. *Transtornos alimentares: Uma visão gestáltica*. Em Livro Pleno.
- Seganfredo, M. (2002). *A clínica psicanalítica do sintoma: a literalidade do saber inconsciente*. (Dissertação de mestrado). Universidade de Brasília, Brasília.
- Scazufca, A. C. M. (1998). *Abordagem psicanalítica da anorexia e da bulimia como distúrbios da oralidade*. (Dissertação de mestrado). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
- Schedler J. (2010). The Efficacy of Psychodynamic Psychotherapy. University of Colorado Denver School of Medicine. *American Psychologist*, 98-109.
- Schnorr, F. B. (2018). A constituição psíquica na bulimia: corpo, narcisismo e sofrimento. (Certificado de Conclusão de Curso de Pós-graduação *Lato Sensu* em Teoria Psicanalítica). Centro Universitário de Brasília, Brasília.
- Serra, G. M. A. (2001). *Saúde e nutrição na adolescência: o discurso sobre dietas na revista Capricho*. (Dissertação de mestrado). Pós graduação em saúde pública, Rio de Janeiro.
- Scorsolini-Comin, F. & Santos, M. A. (2012). Psicoterapia como estratégia de tratamento dos transtornos alimentares: análise crítica do conhecimento produzido. *Estudos de Psicologia*, 29, 851-863.
- Suy, A. (2022). *A gente mira no amor e acerta na solidão*. Planeta do Brasil.

- Swanson, S. A., Crow, S. J., Le Grange, D., Swendsen, J., & Merikangas, K.R. (2011). Prevalence and correlates of eating disorders in adolescents. *Archives of General Psychiatry*, 68(7), 714-723. <https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2011.22>
- Sztajmberg, R. (2003) Corpo e alma: alinhavo ou costura na constituição feminina? Em *Estados Gerais da Psicanálise*.
- Teixeira, M. J. (2004a). *Fome de vida: a psicoterapia com pacientes com transtornos alimentares*. Trabalho apresentado no X Encontro de Abordagens Terapêuticas Humanistas e Fenomenológicas, Brasil.
- Teixeira, M. J. (2004b). *Anorexia nervosa*. Trabalho apresentado no X Encontro de Abordagens Terapêuticas Humanistas e Fenomenológicas, Marília, Brasil.
- Teixeira P. C., Costa, R. F., Matsudo, S. M. M. & Cordás, T. A. (2009). A prática de exercícios físicos em pacientes com transtornos alimentares. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 36(4), 145-152.
- Tellegen, T. (1984). *Gestalt e grupos: uma pesquisa sistêmica*. Summus.
- Telch, C. F. & Agras, W. S. (2001). Dialectical Behaviour Therapy for Eating Disorders. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, Stanford University School of Medicine, 69(6), 1061-1065.
- Teriato, V. (2009). Dal cibo alle fantasie: Il trattamento psicoterapeutico dei disturbi del comportamento alimentare nell'adolescenza. *Infanzia Adolescenza*, 8(1), 35-44.
- Tolin, D. F., Forman, E. M., Klonsky, E. D. & Thombs, B. D. (2015). Empirically Supported Treatment: Recommendations for a New Model. *Clinical Psychology Science and Practice*.
- Vale, A. M. O. (2002). *Prevalência de comportamentos alimentares anormais e práticas inadequadas de controle de peso entre estudantes secundaristas da rede pública e privada de Fortaleza* (Dissertação de Mestrado). Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará.
- Vale, A. M. O.; Elias, L. R. (2011). Transtornos Alimentares: uma perspectiva analítico-comportamental. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental Cognitiva*, 13(1), 52-70.
- Víctora, L. G. (2016). Corpo real, corpo simbólico, corpo imaginário. *Correio APPOA*.
- Washington Post. (1996). *As origens femininas da sexualidade*. (V. Ribeiro, Trad.). Jorge Zahar.
- Weinberg, C. (2010). Do ideal ascético ao ideal estético: a evolução histórica da Anorexia Nervosa. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, 13(2), 224-237.

- Wachholz, P. A., Lima, S. A. M. & Boas, P. J. F. V. (2018). Da prática baseada em evidências para a saúde coletiva informada por evidências: coletiva informada por evidências: revisão narrativa. *Revista Brasileira em Promoção da Saúde*, 31(2), 1-7.
- Wilson, G. T., Grilo, C. M., & Vitousek, K. M. (2007). Psychological treatment of eating disorders. *American Psychologist*, 62(3), 199–216. <https://doi.org/10.1037/0003-066x.62.3.19>
- Winnicott, D. W. (1990). The Price of Disregarding Psychoanalytic Research. In D. Winnicott, *Home is Where We Start From*, 172-82. Penguin. (Original work published 1986b).
- Zerbe, K. J. (2001). The crucial role of psychodynamic understanding of eating disorders. *The psychiatric clinics of North America*, 24.
- Zimerman, D. E. (2008). A função de "Continente" do Analista e os "Subcontinentes". In: *Bion: da teoria à prática - uma leitura didática*. Artmed, 2, 264-2